

Buku Referensi

KESELAMATAN IBU DAN BAYI

Dalam Sistem Kesehatan Nasional

Rosa Susanti • Dewi Mayangsar • Yeti Yuwansyah
Imelda Diana Marsilia • Siti Nur Farida • Sujianti



BUKU REFERENSI : KESELAMATAN IBU DAN BAYI DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

Penulis

Rosa Susanti, S.ST., M.Kes.

Bd. Dewi Mayangsari, S.Si.T., M.Kes., M.Keb.

Yeti Yuwansyah, SST., M.Kes., M.Keb.

Bdn. Imelda Diana Marsilia, SST., SKM., M.Keb.

Bd. Siti Nur Farida., SST., M.Kes.

Sujianti, S.ST., Bdn., M.Kes.



Buku Referensi : Keselamatan Ibu Dan Bayi Dalam Praktik Kebidanan

Penulis:

Rosa Susanti, S.ST., M.Kes.
Bd. Dewi Mayangsari, S.Si.T., M.Kes., M.Keb.
Yeti Yuwansyah, SST., M.Kes., M.Keb.
Bdn. Imelda Diana Marsilia, SST., SKM., M.Keb.
Bd. Siti Nur Farida., SST., M.Kes.
Sujianti, S.ST., Bdn., M.Kes.

ISBN: 978-634-7556-91-2

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Khoirul Anam

Cetakan Pertama: Mei, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku referensi berjudul *Keselamatan Ibu dan Bayi dalam Praktik Kebidanan* ini dapat disusun dan diterbitkan. Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi akademik dan profesional dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kebidanan, khususnya dalam upaya menjamin keselamatan ibu dan bayi sebagai prioritas utama dalam setiap asuhan.

Keselamatan pasien (*patient safety*) dalam kebidanan merupakan fondasi penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Praktik kebidanan tidak hanya menuntut kompetensi klinis yang memadai, tetapi juga kemampuan dalam mengidentifikasi risiko, mengambil keputusan yang tepat, melakukan tindakan berbasis standar, serta membangun budaya keselamatan di setiap tatanan pelayanan. Tantangan di lapangan yang semakin kompleks menuntut bidan untuk senantiasa memperbarui pengetahuan dan meningkatkan keterampilan secara berkelanjutan.

Buku ini disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai aspek keselamatan ibu dan bayi dalam praktik kebidanan. Pembahasan diawali dengan konsep *patient safety* dalam kebidanan sebagai landasan teoretis dan praktis dalam membangun budaya keselamatan. Selanjutnya, buku ini mengulas identifikasi faktor risiko maternal dan neonatal sebagai langkah preventif dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas.

Topik manajemen kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dibahas sebagai bagian penting dari respons cepat dan tepat terhadap kondisi yang mengancam jiwa. Pencegahan infeksi dalam praktik kebidanan turut diuraikan sebagai strategi esensial dalam menjaga mutu layanan dan keselamatan pasien. Selain itu, dokumentasi dan pelaporan insiden dibahas sebagai bagian dari sistem pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan kesehatan.

Buku ini juga mengkaji manajemen risiko dalam praktik mandiri bidan, mengingat semakin berkembangnya pelayanan kebidanan di komunitas. Pada bagian akhir, strategi peningkatan mutu pelayanan kebidanan dipaparkan sebagai upaya sistematis dalam mewujudkan pelayanan yang aman, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan ibu dan bayi.

Kami berharap buku referensi ini dapat menjadi sumber rujukan bagi mahasiswa kebidanan, dosen, praktisi bidan, serta tenaga kesehatan lainnya dalam memahami dan menerapkan prinsip keselamatan ibu dan bayi secara komprehensif. Semoga

buku ini turut berkontribusi dalam mendukung pencapaian pelayanan kebidanan yang profesional, berkualitas, dan berlandaskan keselamatan pasien.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan ilmu kebidanan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi di Indonesia.

Mei, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 KONSEP PASIEN SAFETY DALAM KEBIDANAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Konsep Dasar Patient Safety	4
C. Budaya Keselamatan Pasien dalam Pelayanan Kebidanan	6
D. Standar Patient Safety dalam Pelayanan Kebidanan	7
E. Manajemen Risiko dalam Praktik Kebidanan.....	8
F. Patient Safety pada Masa Kehamilan	9
G. Patient Safety pada Persalinan	10
H. Patient Safety pada Masa Nifas	11
I. Patient Safety pada Bayi Baru Lahir	12
J. Komunikasi Efektif dalam Patient Safety	13
K. Sistem Pelaporan dan Evaluasi Insiden	14
L. Peran Bidan dalam Implementasi Patient Safety.....	16
M. PENUTUP.....	17
Referensi	20
Glosarium	22
BAB 2 IDENTIFIKASI FAKTOR RESIKO MATERNAL DAN NEONATAL	24
A. Pendahuluan	24
B. Konsep Dasar Faktor Risiko Maternal Neonatal	25
C. Faktor Risiko Maternal	26
D. Faktor Risiko Neonatal.....	28
E. Metode Identifikasi Faktor Risiko.....	29
F. Dampak Faktor Risiko.....	31
G. Upaya Pencegahan dan Penatalaksanaan	33
H. Penutup	36
Referensi	37
BAB 3 MANAJEMEN KEGAWATDARURATAN OBSTETRI DAN NEONATAL.....	38
A. Pendahuluan	38
B. Prinsip Dasar Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal.....	38
C. Kegawatdaruratan kehamilan.....	40

D. Kegawatdaruratan Persalinan.....	41
E. Kegawatdaruratan Pascapersalinan.....	42
F. Kegawatdaruratan Neonatal.....	43
G. Prosedur Tindakan Operatif Gawat Darurat.....	44
H. Penutup	45
Referensi	46
Glosarium.....	48

BAB 4 PENCEGAHAN INFEKSI DALAM PRAKTIK KEBIDANAN..... 49

A. Pendahuluan.....	49
B. Konsep Dasar Pencegahan Infeksi dalam Kebidanan.....	50
C. Risiko Infeksi pada Ibu, Bayi, dan Tenaga Kesehatan	52
D. Kewaspadaan Standar dalam Praktik Kebidanan	55
E. Teknik Aseptik pada Tindakan Kebidanan	58
F. Pencegahan Infeksi Menurut Tahap Pelayanan Kebidanan.....	60
G. Intervensi Khusus Berbasis Rekomendasi	62
H. Pengolahan Alat dan Lingkungan Praktik.....	63
I. Edukasi Ibu dan Keluarga.....	64
J. Audit Mutu, Supervisi, dan Budaya Keselamatan.....	65
K. Studi Kasus dan Refleksi.....	67
L. Penutup	67
Referensi	69
Glosarium.....	72

BAB 5 MANAJEMEN RISIKO DALAM PRAKTIK MANDIRI BIDAN 77

A. Pendahuluan.....	77
B. Definisi Manajemen Risiko Klinis dalam Kebidanan.....	80
C. Identifikasi Risiko dalam Praktik Mandiri Bidan.....	81
D. Studi Kasus Persalinan Letak Sungsang.....	81
E. Asuhan Keperawatan Penilaian Risiko dan Seberapa Besar Potensinya	81
F. Peran Bidan Delima Dalam Manajemen Risiko	82
G. Studi Kasus Asuahn Kebidanan Komprehensif.....	83
H. Inovasi dan Strategi dalam Praktik Kebidanan	85
I. Peningkatan Kualitas Pelayanan Melalui Manajemen Risiko	86
J. Perencanaan Pembukaan Praktik Mandiri Bidan Yang Aman	87
K. Peran Teknologi dalam Manajemen Risiko	89
L. Manajemen Risiko Dalam Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.....	90
M. Manajemen Risiko Pada Neonatus dan Bayi	90

N. Budaya Keselamatan Pasien di Praktik Mandiri Bidan.....	91
O. Peran Organisasi Profesi dalam Mendukung Manajemen Risiko.....	92
P. Manajemen Risiko Dalam Konteks Kewirausahaan Kebidanan.....	93
Q. Pelayanan Yang Di Berikan Bidan Praktik Mandiri.....	94
R. Penutup	95
Referensi	97
Glosarium	98
 BAB 6 STRATEGI PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEBIDANAN	 100
A. Pendahuluan.....	100
B. Promosi dan Pengembangan Pendidikan.....	102
C. Manajemen Sumber Daya Manusia	103
D. Peraturan, Regulasi Dan Standar Untuk Layanan.....	105
E. Pembuatan Kebijakan.....	106
F. Standar Pelayanan Kebidanan.....	107
G. Penilaian Mutu Pelayanan Kebidanan	110
H. Strategi Untuk Melakukan Penilaian Mutu Pelayanan Kebidanan.....	111
I. Penutup	112
Referensi	113
Glosarium	116
 PROFIL PENULIS	 117

BAB 1

KONSEP PASIEN SAFETY DALAM KEBIDANAN

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Patient Safety dalam Pelayanan Kesehatan

Keselamatan pasien (*patient safety*) merupakan komponen fundamental dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Konsep ini menekankan bahwa setiap proses pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara aman, sistematis, dan berorientasi pada pencegahan kesalahan yang dapat merugikan pasien. Keselamatan pasien tidak hanya berkaitan dengan kompetensi tenaga kesehatan, tetapi juga melibatkan sistem pelayanan, prosedur klinis, komunikasi antar tenaga kesehatan, serta budaya organisasi dalam fasilitas kesehatan. Organisasi kesehatan global seperti *World Health Organization* menegaskan bahwa keselamatan pasien merupakan indikator penting dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan menjadi prioritas utama dalam sistem kesehatan di berbagai negara (World Health Organization., 2021).

Dalam praktik pelayanan kesehatan, berbagai risiko dapat terjadi selama proses diagnosis, terapi, maupun tindakan medis. Kesalahan medis (*medical errors*) dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya komunikasi antar tenaga kesehatan, kesalahan dalam dokumentasi, penggunaan obat yang tidak tepat, maupun kelemahan sistem pelayanan kesehatan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa insiden keselamatan pasien masih menjadi masalah global yang signifikan, terutama di negara berkembang yang menghadapi keterbatasan sumber daya dan sistem pelayanan kesehatan yang belum optimal (Agbar et al., 2023). Oleh karena itu, penerapan sistem keselamatan pasien menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta melindungi pasien dari risiko cedera akibat kesalahan medis.

Dalam pelayanan kebidanan, konsep patient safety memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan dua individu sekaligus, yaitu ibu dan bayi. Masa kehamilan, persalinan, dan nifas merupakan periode yang memiliki risiko tinggi terhadap berbagai komplikasi kesehatan. Kesalahan dalam pelayanan kebidanan, seperti keterlambatan diagnosis komplikasi obstetri, kesalahan pemberian obat, maupun kesalahan prosedur klinis, dapat berdampak serius terhadap kesehatan ibu dan bayi. Penelitian terkini

menunjukkan bahwa sebagian besar komplikasi maternal dan neonatal sebenarnya dapat dicegah melalui penerapan sistem keselamatan pasien yang efektif, termasuk pemantauan klinis yang tepat, komunikasi tim yang baik, serta penggunaan standar pelayanan yang jelas (Moller et al., 2019).

Dampak kesalahan medis dalam pelayanan maternal dan neonatal tidak hanya meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis bagi pasien, keluarga, serta tenaga kesehatan yang terlibat. Selain itu, kejadian tersebut juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian terbaru menegaskan bahwa implementasi patient safety yang efektif mampu menurunkan insiden keselamatan pasien secara signifikan serta meningkatkan kualitas pelayanan maternal dan neonatal (Ferorelli et al., 2024).

Meskipun demikian, penerapan keselamatan pasien dalam pelayanan kebidanan masih menghadapi berbagai tantangan. Kompleksitas kondisi klinis, kebutuhan koordinasi antar tenaga kesehatan, keterbatasan fasilitas kesehatan, serta beban kerja tenaga kesehatan yang tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya insiden keselamatan pasien. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan sistematis yang mencakup penguatan kebijakan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta pengembangan budaya keselamatan pasien dalam lingkungan pelayanan kesehatan.

2. Definisi dan Konsep Dasar Patient Safety

Patient safety secara umum didefinisikan sebagai suatu sistem yang dirancang untuk membuat pelayanan kesehatan menjadi lebih aman melalui upaya pencegahan terjadinya cedera pada pasien akibat kesalahan dalam proses pelayanan kesehatan. Konsep ini melibatkan berbagai kegiatan seperti identifikasi risiko, pelaporan insiden, analisis penyebab kesalahan, serta implementasi strategi pencegahan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan di masa mendatang (Bates & Singh, 2018).

Dalam praktik pelayanan kesehatan, terdapat beberapa terminologi yang digunakan untuk menggambarkan kejadian yang berkaitan dengan keselamatan pasien. Salah satu istilah penting adalah insiden keselamatan pasien, yaitu setiap kejadian yang tidak disengaja yang dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera pada pasien. Insiden keselamatan pasien dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Nyaris Cedera (KNC), Kejadian Tidak Cedera (KTC), serta Kondisi Potensial Cedera (KPC).

Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) merupakan insiden yang menyebabkan cedera pada pasien akibat tindakan medis yang dilakukan atau tidak dilakukan.

Kejadian Nyaris Cedera (KNC) adalah insiden yang berpotensi menyebabkan cedera tetapi berhasil dicegah sebelum mencapai pasien. Kejadian Tidak Cedera (KTC) merupakan kejadian yang telah terjadi tetapi tidak menimbulkan cedera pada pasien, sedangkan Kondisi Potensial Cedera (KPC) merupakan kondisi yang memiliki potensi menyebabkan cedera apabila tidak segera diatasi. Pemahaman terhadap klasifikasi insiden ini sangat penting dalam sistem pelaporan keselamatan pasien karena dapat membantu tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi dan mencegah kejadian serupa di masa depan (Ferorelli et al., 2024).

Selain pemahaman mengenai terminologi, penerapan patient safety juga memerlukan pembentukan budaya keselamatan pasien (*patient safety culture*). Budaya keselamatan pasien merupakan nilai, sikap, serta perilaku dalam organisasi yang mendukung upaya peningkatan keselamatan dalam pelayanan kesehatan. Dalam budaya keselamatan pasien, tenaga kesehatan didorong untuk melaporkan kesalahan atau insiden secara terbuka tanpa rasa takut terhadap sanksi, sehingga organisasi dapat belajar dari kesalahan yang terjadi dan melakukan perbaikan sistem secara berkelanjutan (Bates & Singh, 2018).

3. Regulasi dan Kebijakan Patient Safety

Implementasi patient safety dalam pelayanan kesehatan memerlukan dukungan regulasi dan kebijakan yang jelas. Di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan, kebijakan keselamatan pasien diwujudkan melalui penyusunan standar operasional prosedur, pembentukan tim keselamatan pasien, serta penerapan sistem pelaporan insiden yang terintegrasi dengan program peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Secara global, berbagai organisasi kesehatan internasional berperan aktif dalam mengembangkan kebijakan dan strategi keselamatan pasien. Salah satu organisasi yang memiliki peran penting dalam bidang ini adalah World Health Organization yang telah mengembangkan berbagai program global untuk meningkatkan kesadaran serta implementasi patient safety di seluruh dunia. Program tersebut mencakup pengembangan pedoman keselamatan pasien, kampanye global keselamatan pasien, serta penyusunan rencana aksi global untuk mengurangi kejadian yang dapat dicegah dalam pelayanan kesehatan (World Health Organization., 2021).

Di Indonesia, kebijakan keselamatan pasien diatur oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui berbagai regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pelayanan kesehatan. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Menteri Kesehatan tentang keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan yang menekankan penerapan standar keselamatan

pasien, sistem pelaporan insiden, serta penguatan budaya keselamatan pasien dalam organisasi pelayanan kesehatan.

4. Tujuan dan Manfaat Patient Safety dalam Kebidanan

Penerapan patient safety dalam pelayanan kebidanan memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap ibu dan bayi selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Dengan adanya sistem keselamatan pasien yang efektif, risiko terjadinya komplikasi maupun kesalahan medis dapat diminimalkan sehingga keselamatan ibu dan bayi dapat terjamin.

Selain itu, patient safety juga berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kebidanan. Pelayanan yang aman dan berkualitas tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tenaga kesehatan, tetapi juga dapat meningkatkan kepuasan pasien serta keluarganya terhadap pelayanan yang diberikan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan sistem keselamatan pasien yang baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan maternal dan neonatal secara signifikan (Moller et al., 2019).

Manfaat lain dari penerapan patient safety adalah mencegah terjadinya kejadian tidak diharapkan dalam pelayanan kesehatan. Melalui sistem pelaporan insiden serta analisis terhadap penyebab kesalahan, fasilitas pelayanan kesehatan dapat melakukan perbaikan sistem secara berkelanjutan. Dengan demikian, patient safety tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan kesalahan, tetapi juga sebagai strategi peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

B. Konsep Dasar Patient Safety

1. Prinsip Patient Safety

Keselamatan pasien (*patient safety*) merupakan sistem yang dirancang untuk menjamin bahwa pelayanan kesehatan diberikan secara aman dan meminimalkan risiko cedera pada pasien akibat kesalahan medis. Prinsip dasar patient safety meliputi pencegahan kesalahan, identifikasi risiko, pelaporan insiden, pembelajaran dari kesalahan, serta implementasi perbaikan sistem secara berkelanjutan. Pendekatan ini menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Dalam praktik pelayanan kesehatan modern, patient safety tidak hanya berfokus pada individu tenaga kesehatan, tetapi juga pada sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Sistem tersebut mencakup kebijakan organisasi, prosedur operasional standar, komunikasi tim kesehatan, serta penggunaan teknologi kesehatan yang aman. Pendekatan sistem ini penting karena sebagian besar insiden keselamatan pasien tidak hanya disebabkan oleh kesalahan

individu, tetapi juga oleh kelemahan sistem pelayanan kesehatan (Bates & Singh, 2018).

2. Model Keselamatan Pasien

Salah satu model yang banyak digunakan untuk memahami terjadinya kesalahan dalam pelayanan kesehatan adalah Swiss Cheese Model yang dikembangkan oleh James Reason. Model ini menggambarkan bahwa suatu insiden keselamatan pasien terjadi akibat adanya beberapa lapisan pertahanan sistem yang memiliki celah. Ketika celah pada setiap lapisan tersebut sejajar, maka insiden keselamatan pasien dapat terjadi. Model ini menjelaskan bahwa kesalahan dalam pelayanan kesehatan seringkali merupakan hasil dari kombinasi faktor manusia, sistem organisasi, dan lingkungan kerja (Wiegmann et al., 2022).

Dalam pelayanan kebidanan, model ini sangat relevan karena proses pelayanan maternal melibatkan berbagai tahapan pelayanan mulai dari pemeriksaan antenatal, persalinan, hingga masa nifas. Apabila terdapat kelemahan pada salah satu tahap pelayanan, maka risiko terjadinya insiden keselamatan pasien dapat meningkat.

3. Faktor Penyebab Insiden Keselamatan Pasien

Insiden keselamatan pasien dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Secara umum, faktor penyebab insiden keselamatan pasien dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu faktor manusia, faktor sistem organisasi, serta faktor lingkungan kerja.

Faktor manusia meliputi keterbatasan pengetahuan, kelelahan tenaga kesehatan, kesalahan komunikasi, serta kurangnya pengalaman klinis. Faktor organisasi berkaitan dengan kebijakan institusi, ketersediaan sumber daya, serta sistem manajemen pelayanan kesehatan. Sementara itu, faktor lingkungan kerja meliputi kondisi fasilitas pelayanan kesehatan, beban kerja yang tinggi, serta keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sebagian besar insiden keselamatan pasien disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor tersebut, sehingga pendekatan sistem sangat diperlukan dalam upaya pencegahan insiden keselamatan pasien (Reyes Ramos & Costa Abós, 2024).

4. Sistem Pelaporan Insiden

Sistem pelaporan insiden merupakan komponen penting dalam implementasi patient safety. Sistem ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk melaporkan berbagai kejadian yang berkaitan dengan keselamatan pasien, seperti kejadian tidak diharapkan, kejadian nyaris cedera, maupun kondisi yang berpotensi menimbulkan cedera.

Melalui sistem pelaporan insiden, organisasi pelayanan kesehatan dapat melakukan analisis terhadap penyebab kejadian serta mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Selain itu, pelaporan insiden juga berperan sebagai sarana pembelajaran organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam praktik kebidanan, pelaporan insiden menjadi sangat penting karena dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan ibu dan bayi selama proses pelayanan kesehatan (Hassan et al., 2024).

C. Budaya Keselamatan Pasien dalam Pelayanan Kebidanan

1. Konsep Budaya Keselamatan

Budaya keselamatan pasien (*patient safety culture*) merupakan nilai, sikap, dan perilaku yang dimiliki oleh tenaga kesehatan dalam organisasi pelayanan kesehatan yang mendukung upaya peningkatan keselamatan pasien. Budaya keselamatan pasien mencerminkan komitmen organisasi terhadap pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas.

Budaya keselamatan pasien yang kuat ditandai oleh adanya komunikasi terbuka, kerja sama tim yang baik, dukungan manajemen terhadap keselamatan pasien, serta adanya sistem pelaporan insiden yang tidak bersifat menyalahkan individu. Penelitian menunjukkan bahwa budaya keselamatan pasien memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi patient safety di fasilitas pelayanan kesehatan (Reyes Ramos & Costa Abós, 2024).

2. Komunikasi Efektif dalam Tim Kesehatan

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keselamatan pasien. Kesalahan komunikasi antar tenaga kesehatan sering menjadi penyebab utama terjadinya insiden keselamatan pasien. Oleh karena itu, berbagai metode komunikasi standar seperti SBAR (*Situation, Background, Assessment, Recommendation*) digunakan untuk meningkatkan kejelasan komunikasi dalam tim kesehatan.

Dalam pelayanan kebidanan, komunikasi efektif sangat penting karena pelayanan maternal dan neonatal melibatkan berbagai tenaga kesehatan seperti bidan, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Komunikasi yang baik dapat membantu tim kesehatan dalam mengambil keputusan klinis yang tepat serta mencegah kesalahan medis.

3. Kepemimpinan dalam Patient Safety

Kepemimpinan memiliki peran penting dalam membangun budaya keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Pemimpin organisasi kesehatan bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan kerja yang mendukung penerapan patient safety, termasuk menyediakan sumber daya yang diperlukan, mengembangkan kebijakan keselamatan pasien, serta memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan dalam melaporkan insiden keselamatan pasien.

Kepemimpinan yang efektif juga dapat mendorong tenaga kesehatan untuk berpartisipasi aktif dalam program keselamatan pasien serta meningkatkan komitmen organisasi terhadap pelayanan kesehatan yang aman.

4. Pembelajaran dari Insiden Keselamatan Pasien

Salah satu prinsip utama dalam patient safety adalah pembelajaran dari kesalahan. Setiap insiden keselamatan pasien harus dianalisis untuk mengetahui penyebabnya serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Proses pembelajaran dari insiden biasanya dilakukan melalui metode *Root Cause Analysis* (RCA) atau analisis akar masalah. Melalui pendekatan ini, organisasi pelayanan kesehatan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya insiden serta mengembangkan strategi untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama di masa depan.

D. Standar Patient Safety dalam Pelayanan Kebidanan

Standar keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan mengacu pada *International Patient Safety Goals* (IPSG) yang dikembangkan oleh organisasi akreditasi kesehatan internasional. Standar ini bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan medis serta meningkatkan keselamatan pasien dalam pelayanan kesehatan (Djajasasana et al., 2024).

1. Identifikasi Pasien dengan Benar

Identifikasi pasien yang benar merupakan langkah awal dalam memastikan keselamatan pasien. Kesalahan identifikasi pasien dapat menyebabkan berbagai kesalahan medis seperti kesalahan pemberian obat, kesalahan prosedur medis, maupun kesalahan diagnosis.

2. Komunikasi Efektif Antar Tenaga Kesehatan

Komunikasi yang jelas dan akurat antar tenaga kesehatan sangat penting dalam mencegah kesalahan medis. Informasi penting seperti hasil pemeriksaan laboratorium, kondisi pasien, serta rencana perawatan harus disampaikan secara tepat dan lengkap.

3. Keamanan Penggunaan Obat

Kesalahan dalam pemberian obat merupakan salah satu penyebab utama insiden keselamatan pasien. Oleh karena itu, penggunaan obat harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan prinsip benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, dan benar cara pemberian.

4. Kepastian Lokasi, Prosedur, dan Pasien yang Benar

Standar keselamatan pasien juga menekankan pentingnya memastikan bahwa tindakan medis dilakukan pada pasien yang tepat, dengan prosedur yang benar, serta pada lokasi yang benar.

5. Pencegahan Infeksi

Infeksi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan (*healthcare-associated infections*) merupakan salah satu masalah penting dalam keselamatan pasien. Pencegahan infeksi dapat dilakukan melalui penerapan praktik kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri, serta sterilisasi peralatan medis.

6. Pencegahan Risiko Pasien Jatuh

Pasien yang dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan memiliki risiko jatuh yang dapat menyebabkan cedera. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu melakukan penilaian risiko jatuh serta menerapkan tindakan pencegahan yang sesuai

E. Manajemen Risiko dalam Praktik Kebidanan

1. Identifikasi Risiko pada Pelayanan Kebidanan

Manajemen risiko dalam pelayanan kebidanan dimulai dengan proses identifikasi risiko yang mungkin terjadi selama pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Risiko tersebut dapat muncul pada berbagai tahap pelayanan, mulai dari pemeriksaan antenatal, persalinan, hingga masa nifas.

2. Analisis Risiko Pelayanan Maternal dan Neonatal

Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis risiko untuk menentukan tingkat kemungkinan dan dampak dari risiko tersebut. Analisis risiko ini penting untuk menentukan prioritas tindakan pencegahan yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.

3. Pencegahan Kesalahan Medis

Upaya pencegahan kesalahan medis dapat dilakukan melalui berbagai strategi, seperti peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, penerapan standar operasional prosedur, penggunaan teknologi kesehatan yang aman, serta peningkatan komunikasi dalam tim kesehatan.

4. Strategi Mitigasi Risiko

Strategi mitigasi risiko bertujuan untuk mengurangi dampak dari risiko yang telah diidentifikasi. Dalam pelayanan kebidanan, strategi ini dapat meliputi pelatihan kegawatdaruratan obstetri, penggunaan checklist keselamatan pasien, serta penguatan sistem rujukan maternal dan neonatal.

F. Patient Safety pada Masa Kehamilan

1. Keselamatan Ibu dalam Pemeriksaan Antenatal

Pelayanan antenatal (*antenatal care/ANC*) merupakan strategi utama dalam menjamin keselamatan ibu dan janin selama masa kehamilan. Pelayanan ini bertujuan untuk memantau kondisi kesehatan ibu dan janin secara berkala serta mendeteksi secara dini adanya komplikasi kehamilan. Pelayanan ANC yang berkualitas tidak hanya berfokus pada pemeriksaan fisik, tetapi juga mencakup aspek edukasi, skrining risiko, serta intervensi preventif yang tepat.

Keselamatan ibu dalam pemeriksaan antenatal sangat bergantung pada ketepatan diagnosis, kelengkapan pemeriksaan, serta komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien. Kegagalan dalam mendeteksi faktor risiko sejak dini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi serius seperti preeklamsia, perdarahan, maupun infeksi. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan antenatal berkontribusi signifikan terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi (DeSisto et al., 2023).

2. Skrining Faktor Risiko Kehamilan

Skrining faktor risiko merupakan komponen penting dalam patient safety pada masa kehamilan. Faktor risiko dapat berasal dari kondisi medis ibu, riwayat obstetri, maupun kondisi sosial ekonomi. Identifikasi dini terhadap kehamilan risiko tinggi memungkinkan tenaga kesehatan untuk melakukan intervensi yang tepat, termasuk rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih lengkap.

Penelitian terbaru menekankan pentingnya pendekatan berbasis *risk-appropriate care* dalam pelayanan maternal, yaitu pemberian pelayanan sesuai dengan tingkat risiko kehamilan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan keselamatan ibu dan bayi serta mencegah komplikasi yang dapat dicegah (DeSisto et al., 2023).

3. Pencegahan Komplikasi Kehamilan

Sebagian besar komplikasi kehamilan seperti hipertensi, anemia, dan infeksi sebenarnya dapat dicegah melalui pelayanan antenatal yang optimal. Upaya pencegahan meliputi pemantauan tekanan darah, pemberian suplementasi zat besi, imunisasi, serta edukasi mengenai tanda bahaya kehamilan.

Data global menunjukkan bahwa komplikasi seperti perdarahan, infeksi, dan hipertensi masih menjadi penyebab utama kematian ibu, namun sebagian besar dapat dicegah dengan pelayanan yang tepat waktu dan berkualitas .

4. Keselamatan Pemberian Obat pada Ibu Hamil

Pemberian obat pada ibu hamil memerlukan perhatian khusus karena dapat berdampak pada janin. Kesalahan dalam pemberian obat dapat menyebabkan efek teratogenik maupun komplikasi kehamilan lainnya. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus mempertimbangkan keamanan obat berdasarkan kategori risiko kehamilan serta memastikan indikasi yang tepat sebelum pemberian obat.

Pendekatan berbasis keselamatan dalam farmakoterapi kehamilan mencakup prinsip *right patient, right drug, right dose, right time, dan right route*, serta edukasi kepada ibu hamil mengenai penggunaan obat yang aman.

G. Patient Safety pada Persalinan

1. Keselamatan Ibu dan Bayi Selama Proses Persalinan

Persalinan merupakan periode kritis yang memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya komplikasi yang mengancam jiwa ibu dan bayi. Keselamatan dalam proses persalinan sangat bergantung pada keterampilan tenaga kesehatan, kesiapan fasilitas pelayanan, serta sistem rujukan yang efektif.

Menurut penelitian terbaru, sebagian besar kematian ibu dan bayi terjadi selama proses persalinan dan periode segera setelah kelahiran, namun banyak dari kejadian tersebut sebenarnya dapat dicegah melalui pelayanan yang aman dan berkualitas .

2. Pencegahan Kesalahan Tindakan Obstetri

Kesalahan dalam tindakan obstetri, seperti kesalahan penggunaan alat bantu persalinan atau keterlambatan tindakan, dapat menyebabkan komplikasi serius. Pencegahan kesalahan dapat dilakukan melalui penerapan standar operasional prosedur, penggunaan checklist keselamatan, serta pelatihan tenaga kesehatan secara berkala.

Pendekatan sistem seperti *early warning system* juga terbukti efektif dalam mendeteksi kondisi kegawatdaruratan secara dini sehingga dapat segera ditangani (Borem et al., 2025).

3. Monitoring Persalinan yang Aman

Monitoring persalinan yang aman meliputi pemantauan kondisi ibu dan janin secara kontinu, seperti penggunaan partograf, pemantauan denyut jantung janin, serta evaluasi kemajuan persalinan. Monitoring yang tepat dapat membantu tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan klinis secara cepat dan tepat.

Kegagalan dalam monitoring dapat menyebabkan keterlambatan penanganan komplikasi seperti asfiksia janin maupun partus lama, yang berpotensi meningkatkan risiko kematian neonatal.

4. Penanganan Kegawatdaruratan Obstetri

Kegawatdaruratan obstetri seperti perdarahan postpartum, eklampsia, dan sepsis memerlukan penanganan yang cepat dan tepat. Pelayanan obstetri darurat yang komprehensif (*Emergency Obstetric and Neonatal Care/EmONC*) merupakan komponen penting dalam sistem keselamatan pasien.

Implementasi program pelayanan obstetri darurat terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan keselamatan ibu dan bayi, terutama melalui peningkatan koordinasi, sumber daya, dan sistem pelayanan kesehatan (Cholifah & Arcellya, 2024).

H. Patient Safety pada Masa Nifas

1. Pencegahan Komplikasi Masa Nifas

Masa nifas merupakan periode yang rawan terhadap berbagai komplikasi, seperti perdarahan, infeksi, dan gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, pemantauan kondisi ibu secara berkala sangat penting dalam mencegah komplikasi.

Pelayanan nifas yang berkualitas mencakup pemeriksaan fisik, pemantauan tanda vital, serta edukasi kepada ibu mengenai tanda bahaya masa nifas.

2. Deteksi Dini Infeksi Postpartum

Infeksi postpartum merupakan salah satu penyebab utama morbiditas ibu. Deteksi dini infeksi dapat dilakukan melalui pemantauan suhu tubuh, kondisi luka, serta gejala klinis lainnya.

Pencegahan infeksi dilakukan melalui praktik kebersihan yang baik, penggunaan teknik aseptik, serta edukasi kepada ibu mengenai perawatan diri selama masa nifas.

3. Pencegahan Perdarahan Postpartum

Perdarahan postpartum merupakan penyebab utama kematian ibu di seluruh dunia. Upaya pencegahan meliputi manajemen aktif kala III persalinan, pemantauan kontraksi uterus, serta deteksi dini tanda-tanda perdarahan.

Penelitian menunjukkan bahwa deteksi dini dan penanganan cepat terhadap perdarahan postpartum dapat secara signifikan menurunkan angka kematian ibu (Borem et al., 2025).

4. Edukasi Keselamatan Ibu Nifas

Edukasi merupakan bagian penting dalam patient safety pada masa nifas. Ibu perlu diberikan informasi mengenai tanda bahaya, perawatan diri, serta pentingnya kunjungan ulang ke fasilitas kesehatan.

Selain aspek fisik, perhatian juga perlu diberikan pada kesehatan mental ibu, terutama pada ibu yang mengalami stres atau depresi postpartum (Ramirez et al., 2024).

I. Patient Safety pada Bayi Baru Lahir

1. Identifikasi Bayi Baru Lahir

Identifikasi bayi baru lahir merupakan langkah penting dalam mencegah kesalahan pelayanan. Kesalahan identifikasi dapat menyebabkan tertukarnya bayi atau kesalahan dalam pemberian tindakan medis.

Prosedur identifikasi bayi harus dilakukan secara sistematis, seperti penggunaan gelang identitas serta verifikasi identitas oleh tenaga kesehatan.

2. Pencegahan Infeksi Neonatal

Infeksi neonatal merupakan salah satu penyebab utama kematian bayi baru lahir. Pencegahan infeksi dilakukan melalui praktik kebersihan tangan, penggunaan alat steril, serta perawatan tali pusat yang benar.

Infeksi dan komplikasi neonatal masih menjadi penyebab utama kematian bayi di seluruh dunia, namun sebagian besar dapat dicegah melalui pelayanan yang aman dan berkualitas.

3. Keamanan Pemberian Obat dan Imunisasi

Pemberian obat dan imunisasi pada bayi baru lahir harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena sensitivitas fisiologis bayi yang tinggi. Kesalahan dosis atau jenis obat dapat berdampak serius terhadap kesehatan bayi.

Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus memastikan ketepatan dosis, jenis obat, serta waktu pemberian sesuai dengan standar pelayanan neonatal.

4. Pencegahan Kesalahan Identifikasi Bayi

Kesalahan identifikasi bayi dapat dicegah melalui penerapan sistem verifikasi ganda, penggunaan teknologi identifikasi, serta keterlibatan orang tua dalam proses identifikasi bayi.

Pendekatan sistematis dalam keselamatan neonatal terbukti dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta menurunkan risiko kesalahan medis dalam pelayanan bayi baru lahir (Bai et al., 2024).

J. Komunikasi Efektif dalam Patient Safety

1. Teknik Komunikasi SBAR

Komunikasi merupakan elemen kunci dalam keselamatan pasien (*patient safety*), karena sebagian besar insiden keselamatan pasien berakar dari kegagalan komunikasi antar tenaga kesehatan. Salah satu teknik komunikasi yang banyak digunakan dalam praktik klinis adalah SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation). Metode ini membantu tenaga kesehatan dalam menyampaikan informasi secara sistematis, jelas, dan terstruktur.

SBAR terbukti efektif dalam meningkatkan kejelasan komunikasi klinis, terutama dalam situasi kritis seperti rujukan pasien, pergantian shift, maupun penanganan kegawatdaruratan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa implementasi SBAR dapat menurunkan kesalahan komunikasi serta meningkatkan keselamatan pasien secara signifikan (Müller et al., 2018). Dengan pendekatan ini, informasi penting tidak terlewatkan, sehingga keputusan klinis dapat diambil secara tepat dan cepat.

Dalam praktik kebidanan, SBAR sangat penting digunakan pada kondisi seperti persalinan risiko tinggi, komplikasi kehamilan, maupun kondisi neonatal yang membutuhkan penanganan segera. Penggunaan SBAR juga mendukung kolaborasi antar tenaga kesehatan dalam tim maternal dan neonatal.

2. Edukasi Pasien dan Keluarga

Edukasi pasien dan keluarga merupakan bagian integral dari komunikasi efektif dalam patient safety. Pasien yang memiliki pemahaman yang baik tentang kondisi kesehatannya cenderung lebih mampu berpartisipasi aktif dalam proses perawatan serta mengidentifikasi tanda bahaya secara dini.

Dalam pelayanan kebidanan, edukasi meliputi informasi mengenai kehamilan, persalinan, masa nifas, serta perawatan bayi baru lahir. Edukasi yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap anjuran medis serta mengurangi risiko terjadinya komplikasi. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pasien dan keluarga dalam perawatan kesehatan berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan pasien (O'Hara et al., 2019).

Selain itu, pendekatan komunikasi yang berpusat pada pasien (*patient-centered care*) menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan

kesehatan. Pendekatan ini menekankan pentingnya empati, kejelasan informasi, serta penghargaan terhadap nilai dan preferensi pasien.

3. Komunikasi Antar Tenaga Kesehatan

Komunikasi antar tenaga kesehatan merupakan faktor krusial dalam menjaga keselamatan pasien. Pelayanan kebidanan melibatkan berbagai profesi seperti bidan, dokter, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya, sehingga koordinasi yang baik sangat diperlukan.

Kegagalan komunikasi dalam tim kesehatan dapat menyebabkan kesalahan diagnosis, keterlambatan penanganan, serta kesalahan tindakan medis. Oleh karena itu, diperlukan standar komunikasi yang jelas, seperti penggunaan checklist, briefing tim, serta handover yang terstruktur.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa komunikasi tim yang efektif dapat meningkatkan keselamatan pasien serta menurunkan insiden medis yang dapat dicegah (Rosen et al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya aspek teknis, tetapi juga bagian dari budaya keselamatan pasien.

4. Dokumentasi Pelayanan Kebidanan

Dokumentasi merupakan bagian penting dalam komunikasi klinis serta keselamatan pasien. Dokumentasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu dapat membantu tenaga kesehatan dalam memahami kondisi pasien serta mengambil keputusan klinis yang tepat.

Dalam pelayanan kebidanan, dokumentasi mencakup catatan antenatal, partograf, catatan persalinan, serta catatan masa nifas dan neonatal. Kesalahan atau kelalaian dalam dokumentasi dapat menyebabkan kesalahan pelayanan yang berdampak pada keselamatan pasien.

Selain itu, dokumentasi juga memiliki aspek legal dan menjadi bukti dalam evaluasi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan didokumentasikan dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku.

K. Sistem Pelaporan dan Evaluasi Insiden

1. Jenis Insiden Keselamatan Pasien

Insiden keselamatan pasien merupakan kejadian yang tidak disengaja yang dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera pada pasien. Insiden ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), Kejadian Nyaris Cedera (KNC), Kejadian Tidak Cedera (KTC), serta Kondisi Potensial Cedera (KPC).

Klasifikasi ini penting untuk membantu tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi, melaporkan, serta menganalisis insiden keselamatan pasien secara sistematis. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar insiden keselamatan pasien sebenarnya dapat dicegah melalui sistem pelaporan yang efektif (Shojania, 2021).

2. Sistem Pelaporan Insiden

Sistem pelaporan insiden merupakan komponen penting dalam implementasi patient safety. Sistem ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk melaporkan insiden secara terbuka tanpa rasa takut terhadap sanksi (*non-punitive reporting system*).

Pelaporan insiden bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kesalahan serta mengembangkan strategi pencegahan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak tenaga kesehatan yang enggan melaporkan insiden karena adanya budaya menyalahkan (*blame culture*).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki budaya pelaporan yang baik cenderung memiliki tingkat keselamatan pasien yang lebih tinggi (Reyes Ramos & Costa Abós, 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun budaya keselamatan pasien yang mendukung pelaporan insiden secara terbuka.

3. Analisis Akar Masalah

Analisis akar masalah (*Root Cause Analysis/RCA*) merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab utama dari suatu insiden keselamatan pasien. RCA tidak hanya berfokus pada kesalahan individu, tetapi juga pada faktor sistem yang berkontribusi terhadap terjadinya insiden.

Melalui RCA, organisasi pelayanan kesehatan dapat memahami faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan serta mengembangkan solusi yang tepat untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Pendekatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan keselamatan pasien serta kualitas pelayanan kesehatan (Bates & Singh, 2018).

4. Tindak Lanjut Perbaikan Sistem Pelayanan

Setelah dilakukan analisis terhadap insiden, langkah selanjutnya adalah melakukan perbaikan sistem pelayanan. Perbaikan ini dapat berupa revisi prosedur operasional standar, pelatihan tenaga kesehatan, maupun peningkatan sistem komunikasi dan koordinasi.

Pendekatan perbaikan berkelanjutan (*continuous quality improvement*) menjadi strategi penting dalam patient safety. Melalui pendekatan ini, organisasi dapat secara sistematis meningkatkan kualitas pelayanan serta mengurangi risiko terjadinya insiden keselamatan pasien.

L. Peran Bidan dalam Implementasi Patient Safety

1. Tanggung Jawab Profesional Bidan

Bidan memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan ibu dan bayi dalam setiap tahap pelayanan kebidanan. Tanggung jawab profesional bidan mencakup pemberian asuhan yang aman, kompeten, serta sesuai dengan standar praktik kebidanan.

Sebagai tenaga kesehatan garis depan, bidan harus mampu mengidentifikasi risiko, mengambil keputusan klinis yang tepat, serta melakukan tindakan yang sesuai dengan kondisi pasien. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi tenaga kesehatan berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan pasien (Zaitoun et al., 2023).

2. Etika dan Keselamatan Pasien

Etika profesi merupakan landasan dalam praktik kebidanan, termasuk dalam penerapan patient safety. Prinsip etika seperti *non-maleficence* (tidak membahayakan), *beneficence* (berbuat baik), serta *autonomy* (menghormati keputusan pasien) harus diterapkan dalam setiap tindakan pelayanan kesehatan.

Bidan juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan pasien, memberikan informasi yang jujur, serta melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan. Penerapan etika yang baik akan mendukung terciptanya pelayanan yang aman dan berkualitas.

3. Kolaborasi Interprofesional

Pelayanan kebidanan tidak dapat dilakukan secara mandiri, tetapi memerlukan kolaborasi dengan berbagai tenaga kesehatan lainnya. Kolaborasi interprofesional memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, koordinasi tindakan, serta pengambilan keputusan yang lebih komprehensif.

Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi tim kesehatan yang baik dapat meningkatkan keselamatan pasien serta kualitas pelayanan kesehatan (Rosen et al., 2018). Oleh karena itu, bidan harus memiliki kemampuan komunikasi dan kerja sama tim yang baik.

4. Peningkatan Kompetensi Bidan

Peningkatan kompetensi merupakan aspek penting dalam implementasi patient safety. Bidan perlu terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan berkelanjutan, pelatihan klinis, serta pembelajaran berbasis pengalaman.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan menuntut bidan untuk selalu mengikuti perkembangan terbaru agar dapat memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas. Program pelatihan seperti

simulasi klinis dan pelatihan kegawatdaruratan terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan serta keselamatan pasien (Shojania, 2021).

M.PENUTUP

1. Kesimpulan

Keselamatan pasien (*patient safety*) merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pelayanan kebidanan yang berkualitas. Pelayanan kebidanan tidak hanya berfokus pada keberhasilan proses kehamilan dan persalinan, tetapi juga pada upaya sistematis untuk mencegah terjadinya cedera, kesalahan medis, serta kejadian tidak diharapkan yang dapat membahayakan ibu dan bayi. Berbagai bukti ilmiah menunjukkan bahwa sebagian besar komplikasi maternal dan neonatal sebenarnya dapat dicegah melalui penerapan prinsip keselamatan pasien yang efektif dan terintegrasi dalam sistem pelayanan kesehatan (Zaitoun et al., 2023).

Pentingnya penerapan *patient safety* dalam pelayanan kebidanan semakin meningkat seiring dengan kompleksitas pelayanan kesehatan serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang aman dan berkualitas. Kesalahan dalam pelayanan kebidanan, seperti keterlambatan diagnosis, kesalahan tindakan, maupun kegagalan komunikasi, dapat berdampak serius terhadap keselamatan ibu dan bayi. Oleh karena itu, penerapan *patient safety* harus menjadi prioritas dalam setiap aspek pelayanan kebidanan, mulai dari pelayanan antenatal, persalinan, masa nifas, hingga pelayanan bayi baru lahir.

Integrasi *patient safety* dalam praktik kebidanan memerlukan pendekatan sistem yang komprehensif. Pendekatan ini mencakup penerapan standar operasional prosedur, penguatan komunikasi antar tenaga kesehatan, penggunaan sistem pelaporan insiden, serta pengembangan budaya keselamatan pasien dalam organisasi pelayanan kesehatan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan yang memiliki budaya keselamatan pasien yang kuat cenderung memiliki tingkat insiden yang lebih rendah serta kualitas pelayanan yang lebih baik (Reyes Ramos & Costa Abós, 2024).

Selain itu, upaya peningkatan mutu pelayanan maternal dan neonatal tidak dapat dilepaskan dari implementasi *patient safety*. Pendekatan berbasis keselamatan pasien memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi risiko secara dini, melakukan intervensi yang tepat, serta mencegah terjadinya komplikasi yang dapat dicegah. Hal ini sejalan dengan konsep *quality of care*

yang menekankan bahwa pelayanan kesehatan harus aman, efektif, dan berpusat pada pasien (Shojania, 2021).

Dengan demikian, patient safety tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan kesalahan, tetapi juga sebagai strategi utama dalam meningkatkan mutu pelayanan kebidanan serta menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi.

2. Rekomendasi

Peningkatan keselamatan pasien dalam pelayanan kebidanan memerlukan upaya yang terencana dan berkelanjutan. Salah satu rekomendasi utama adalah penguatan budaya keselamatan pasien dalam organisasi pelayanan kesehatan. Budaya keselamatan pasien yang kuat ditandai dengan adanya komunikasi terbuka, kerja sama tim yang baik, serta dukungan manajemen terhadap pelaporan insiden tanpa adanya budaya menyalahkan (*non-punitive culture*). Penelitian menunjukkan bahwa budaya keselamatan pasien yang positif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (Rosen et al., 2018).

Selain itu, pengembangan sistem pelaporan insiden merupakan langkah penting dalam meningkatkan patient safety. Sistem pelaporan yang efektif memungkinkan tenaga kesehatan untuk melaporkan kejadian secara terbuka, sehingga organisasi dapat melakukan analisis dan perbaikan sistem pelayanan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat hambatan seperti kurangnya kesadaran tenaga kesehatan serta adanya kekhawatiran terhadap sanksi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung pelaporan insiden secara aman dan transparan.

Peningkatan kompetensi tenaga kebidanan juga menjadi rekomendasi penting dalam implementasi patient safety. Bidan sebagai tenaga kesehatan yang berperan langsung dalam pelayanan maternal dan neonatal harus memiliki kompetensi klinis yang memadai serta kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko. Program pendidikan berkelanjutan, pelatihan simulasi klinis, serta pelatihan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kompetensi tenaga kebidanan (Bates & Singh, 2018).

Selain itu, dukungan kebijakan dan manajemen fasilitas kesehatan sangat diperlukan dalam implementasi patient safety. Manajemen fasilitas kesehatan harus menyediakan sumber daya yang memadai, mengembangkan kebijakan keselamatan pasien, serta memastikan bahwa seluruh tenaga kesehatan memahami dan menerapkan prinsip patient safety dalam praktik sehari-hari. Dukungan ini juga mencakup penguatan sistem rujukan serta integrasi pelayanan kesehatan yang berkesinambungan.

3. Implikasi Pengembangan Pelayanan Kebidanan

Penerapan patient safety memiliki implikasi yang luas terhadap pengembangan pelayanan kebidanan, baik dalam praktik klinik maupun dalam sistem pendidikan dan manajemen pelayanan kesehatan. Dalam praktik klinik, penerapan patient safety menuntut tenaga kesehatan untuk bekerja secara sistematis, berbasis standar, serta berorientasi pada pencegahan risiko. Hal ini mencakup penggunaan checklist keselamatan pasien, penerapan komunikasi efektif, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan.

Pengembangan pendidikan kebidanan berbasis keselamatan pasien juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kesehatan di masa depan. Kurikulum pendidikan kebidanan perlu mengintegrasikan konsep patient safety secara komprehensif, termasuk pembelajaran mengenai manajemen risiko, komunikasi efektif, serta analisis insiden keselamatan pasien. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berbasis keselamatan pasien dapat meningkatkan kesadaran serta kompetensi mahasiswa dalam memberikan pelayanan yang aman (Shojania, 2021).

Selain itu, penguatan sistem mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi menjadi implikasi penting dari penerapan patient safety. Sistem mutu yang baik mencakup pemantauan indikator keselamatan pasien, evaluasi kinerja pelayanan, serta implementasi perbaikan berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk secara konsisten meningkatkan kualitas pelayanan serta mengurangi risiko terjadinya insiden keselamatan pasien.

Dalam konteks global, penguatan patient safety dalam pelayanan kebidanan juga berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan kesehatan, termasuk penurunan angka kematian ibu dan bayi. Oleh karena itu, implementasi patient safety harus menjadi bagian integral dari kebijakan kesehatan nasional serta strategi pembangunan kesehatan secara keseluruhan.

Dengan demikian, pengembangan pelayanan kebidanan yang berbasis patient safety tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap keselamatan ibu dan bayi serta kesejahteraan masyarakat secara luas.

Referensi

- Agbar, F., Zhang, S., Wu, Y., & Mustafa, M. (2023). Effect of patient safety education interventions on patient safety culture of health care professionals: Systematic review and meta-analysis. *Nurse Education in Practice*, 67, 103565.
- Bai, J., Lu, Y., Liu, H., He, F., & Guo, X. (2024). New technologies improve maternal and newborn safety. In *Frontiers in Medical Technology* (Vol. 6, p. 1372358). Frontiers Media SA.
- Bates, D. W., & Singh, H. (2018). Two decades since to err is human: an assessment of progress and emerging priorities in patient safety. *Health Affairs*, 37(11), 1736–1743.
- Borem, P., Gushken, A. K. F., Gushken, A. P., Pacagnella, R. de C., Petenate, A. J., Tuma, P., Pedrillo, L. S., Nariño, S., Barker, P., & Barros, C. G. de. (2025). A comprehensive strategy to mitigate institutional maternal mortality: lessons from a quality improvement initiative in Brazilian maternity hospitals. *Global Health: Science and Practice*, 13(2), e2400130.
- Cholifah, C., & Arcellya, R. S. (2024). Key Determinants of the Comprehensive Neonatal Emergency Obstetric Services Policy. *Indonesian Journal of Public Policy Review*.
- DeSisto, C. L., Kroelinger, C. D., Levecke, M., Akbarali, S., Pliska, E., & Barfield, W. D. (2023). Maternal and neonatal risk-appropriate care: gaps, strategies, and areas for further research. *Journal of Perinatology*, 43(6), 817–822.
- Djajasasana, C. N., Listyani, N. K., & Sihombing, V. D. (2024). Pengaruh Penerapan IPSG (International Patient Safety Goals) terhadap Kepuasan Pasien Layanan Home Care Smartcare Jakarta. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 14934–14949.
- Ferorelli, D., Goffredo, V. M., Graziano, E., Mastrapasqua, M., Telegrafo, M., Vinci, A., Visci, P., Benevento, M., Zotti, F., & Foglianese, A. (2024). Quality improvement in neonatal care through enhanced patient safety and clinical risk management: a before-and-after study about neonatal sepsis. *Frontiers in Medicine*, 11, 1430853.
- Hassan, N. A. H., Rahman, H. A., Knights, J., Hashim, S., Sharbini, S., & Abdul-Mumin, K. H. (2024). Cultivating patient safety culture in midwifery practices through incident reporting. *British Journal of Midwifery*, 32(7), 388–394.
- Moller, A., Patten, J. H., Hanson, C., Morgan, A., Say, L., Diaz, T., & Moran, A. C. (2019). Monitoring maternal and newborn health outcomes globally: a brief history of key events and initiatives. *Tropical Medicine & International Health*, 24(12), 1342–1368.

- Müller, M., Jürgens, J., Redaelli, M., Klingberg, K., Hautz, W. E., & Stock, S. (2018). Impact of the communication and patient hand-off tool SBAR on patient safety: a systematic review. *BMJ Open*, 8(8), e022202.
- O'Hara, J. K., Aase, K., & Waring, J. (2019). Scaffolding our systems? Patients and families 'reaching in' as a source of healthcare resilience. In *BMJ Quality & Safety* (Vol. 28, Issue 1, pp. 3–6). BMJ Publishing Group Ltd.
- Ramirez, J. D., Sarik, D. A., Matsuda, Y., & Ortiz, J. (2024). Best practices to support maternal mental health during the transition from neonatal intensive care unit to home: A scoping review. *Critical Care Nursing Clinics*, 36(2), 261–280.
- Reyes Ramos, M. J., & Costa Abós, S. (2024). Patient safety culture: nurses' perspective in the hospital setting. *Healthcare*, 12(10), 1010.
- Rosen, M. A., DiazGranados, D., Dietz, A. S., Benishek, L. E., Thompson, D., Pronovost, P. J., & Weaver, S. J. (2018). Teamwork in healthcare: Key discoveries enabling safer, high-quality care. *American Psychologist*, 73(4), 433.
- Shojania, K. G. (2021). Incident reporting systems: what will it take to make them less frustrating and achieve anything useful? *Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety*, 47(12), 755–758.
- Wiegmann, D. A., Wood, L. J., Cohen, T. N., & Shappell, S. A. (2022). Understanding the "Swiss Cheese Model" and its application to patient safety. *Journal of Patient Safety*, 18(2), 119–123.
- World Health Organization. (2021). *Global patient safety action plan 2021–2030: Towards eliminating avoidable harm in health care*. WHO.
- Zaitoun, R. A., Said, N. B., & de Tantillo, L. (2023). Clinical nurse competence and its effect on patient safety culture: a systematic review. *BMC Nursing*, 22(1), 173.

Glosarium

Antenatal Care (ANC)

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama masa kehamilan untuk memantau kondisi ibu dan janin.

Budaya Keselamatan Pasien

Nilai, sikap, dan perilaku dalam organisasi pelayanan kesehatan yang mendukung keselamatan pasien.

Evidence-Based Practice

Praktik pelayanan kesehatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia.

Insiden Keselamatan Pasien

Kejadian yang tidak disengaja yang dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera pada pasien.

Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)

Insiden yang menyebabkan cedera pada pasien akibat pelayanan kesehatan.

Kejadian Nyaris Cedera (KNC)

Insiden yang berpotensi menyebabkan cedera tetapi berhasil dicegah sebelum mencapai pasien.

Kejadian Tidak Cedera (KTC)

Insiden yang terjadi tetapi tidak menimbulkan cedera pada pasien.

Kondisi Potensial Cedera (KPC)

Situasi yang berpotensi menimbulkan cedera jika tidak ditangani.

Maternal dan Neonatal

Berkaitan dengan kesehatan ibu dan bayi baru lahir.

Patient Safety

Sistem yang bertujuan untuk membuat pelayanan kesehatan lebih aman dengan mencegah cedera akibat kesalahan medis.

Root Cause Analysis (RCA)

Metode analisis untuk mengidentifikasi penyebab utama suatu insiden keselamatan pasien.

SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation)

Metode komunikasi terstruktur dalam pelayanan kesehatan.

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Panduan tertulis yang menjelaskan langkah-langkah kerja secara sistematis.

Swiss Cheese Model

Model keselamatan pasien yang menjelaskan bahwa kesalahan terjadi akibat celah dalam sistem yang berlapis.

BAB 2

IDENTIFIKASI FAKTOR RESIKO MATERNAL DAN NEONATAL

A. Pendahuluan

Kesehatan maternal dan neonatal merupakan indikator penting dalam menilai derajat kesehatan suatu negara, karena mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Neonatal (AKN) masih menjadi tantangan global, khususnya di negara berkembang. Menurut World Health Organization (2020), lebih dari 80% kematian ibu dan bayi baru lahir dapat dicegah melalui intervensi yang tepat, termasuk deteksi dini terhadap faktor risiko yang ada sejak masa kehamilan hingga persalinan.

Identifikasi faktor risiko maternal dan neonatal merupakan suatu proses sistematis untuk mengenali kondisi atau karakteristik yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi pada ibu maupun bayi. Faktor risiko maternal mencakup aspek usia, status gizi, penyakit penyerta, riwayat obstetri, serta kondisi sosial ekonomi, sedangkan faktor risiko neonatal meliputi prematuritas, berat badan lahir rendah, asfiksia, dan infeksi (Cunningham et al., 2018). Proses identifikasi ini menjadi dasar dalam menentukan intervensi yang tepat guna mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat.

Secara global, penyebab utama kematian maternal meliputi perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, dan infeksi, sedangkan kematian neonatal banyak disebabkan oleh prematuritas, asfiksia lahir, dan infeksi neonatal (World Health Organization, 2020). Kondisi tersebut sering kali berawal dari faktor risiko yang tidak terdeteksi atau tidak ditangani secara adekuat. Keterlambatan dalam mengenali risiko ini dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan penanganan yang dikenal sebagai konsep *three delays*, yaitu keterlambatan dalam pengambilan keputusan, keterlambatan dalam mencapai fasilitas kesehatan, dan keterlambatan dalam mendapatkan pelayanan yang memadai (UNICEF, 2021).

Di Indonesia, pendekatan identifikasi faktor risiko telah diintegrasikan dalam pelayanan antenatal terpadu yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022). Pendekatan ini menggunakan prinsip skrining berbasis risiko untuk mengelompokkan ibu hamil ke dalam kategori risiko rendah, tinggi, dan sangat tinggi, sehingga memungkinkan pemberian pelayanan yang lebih terarah dan efektif. Selain itu, penggunaan alat bantu seperti Kartu Skor Poedji Rochjati

(KSPR) membantu tenaga kesehatan dalam mendeteksi secara dini kehamilan berisiko di tingkat pelayanan primer (Saifuddin, 2014).

Dengan demikian, identifikasi faktor risiko maternal dan neonatal tidak hanya berfungsi sebagai proses skrining, tetapi juga sebagai dasar dalam perencanaan asuhan kebidanan, pengambilan keputusan klinis, serta penguatan sistem rujukan. Implementasi identifikasi risiko yang optimal diharapkan mampu menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi, serta mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan nasional dan global.

B. Konsep Dasar Faktor Risiko Maternal Neonatal

Faktor risiko maternal dan neonatal merupakan konsep fundamental dalam upaya peningkatan kesehatan ibu dan bayi. Faktor risiko didefinisikan sebagai kondisi atau karakteristik individu yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang merugikan, seperti komplikasi kehamilan, persalinan, maupun gangguan pada bayi baru lahir. Dalam konteks kesehatan ibu dan anak, faktor risiko tidak selalu menyebabkan masalah secara langsung, namun keberadaannya meningkatkan probabilitas terjadinya komplikasi jika tidak diidentifikasi dan ditangani secara tepat (Cunningham et al., 2018).

Secara konseptual, faktor risiko maternal mencakup berbagai aspek yang melekat pada ibu sebelum dan selama kehamilan. Faktor tersebut meliputi faktor biologis (seperti usia dan status gizi), faktor medis (penyakit penyerta), faktor obstetri (riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya), serta faktor sosial ekonomi dan lingkungan. Sementara itu, faktor risiko neonatal berkaitan dengan kondisi yang memengaruhi bayi sejak dalam kandungan hingga periode neonatal (0–28 hari), termasuk prematuritas, berat badan lahir rendah, asfiksia, dan infeksi neonatal (World Health Organization, 2020).

Pendekatan konsep faktor risiko dalam kesehatan maternal dan neonatal didasarkan pada prinsip *continuum of care*, yaitu pelayanan kesehatan yang berkesinambungan sejak masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, hingga masa nifas dan neonatal. Pendekatan ini menekankan bahwa faktor risiko dapat muncul pada setiap tahap kehidupan ibu dan bayi, sehingga deteksi dini harus dilakukan secara berkelanjutan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022), pelayanan antenatal terpadu merupakan strategi utama dalam mengidentifikasi dan mengelola faktor risiko secara komprehensif.

Selain itu, konsep faktor risiko juga berkaitan erat dengan pendekatan pencegahan dalam kesehatan masyarakat, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer bertujuan menghindari munculnya faktor risiko, seperti

melalui edukasi kesehatan dan perbaikan gizi. Pencegahan sekunder dilakukan melalui deteksi dini dan penanganan cepat terhadap faktor risiko yang sudah ada. Sementara itu, pencegahan tersier bertujuan mengurangi dampak komplikasi yang telah terjadi agar tidak menimbulkan kecacatan atau kematian (UNICEF, 2021).

Dalam praktik klinis, identifikasi faktor risiko maternal dan neonatal dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), yaitu dengan mengelompokkan ibu hamil ke dalam kategori risiko rendah, tinggi, atau sangat tinggi. Pendekatan ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk memberikan intervensi yang lebih tepat sasaran, termasuk penentuan kebutuhan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Salah satu metode yang digunakan di Indonesia adalah sistem skoring, seperti Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR), yang membantu dalam mendeteksi kehamilan berisiko secara lebih sistematis (Saifuddin, 2014).

Lebih lanjut, konsep faktor risiko juga tidak terlepas dari determinan sosial kesehatan, seperti kemiskinan, pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan. Faktor-faktor ini berkontribusi terhadap terjadinya keterlambatan dalam penanganan komplikasi, yang dikenal sebagai konsep *three delays*, yaitu keterlambatan dalam pengambilan keputusan, keterlambatan dalam mencapai fasilitas kesehatan, dan keterlambatan dalam mendapatkan pelayanan yang adekuat (UNICEF, 2021). Oleh karena itu, pendekatan dalam mengidentifikasi faktor risiko harus bersifat holistik, tidak hanya berfokus pada aspek klinis, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial dan lingkungan.

Dengan demikian, konsep dasar faktor risiko maternal dan neonatal menekankan pentingnya identifikasi dini, pemantauan berkelanjutan, serta intervensi yang tepat dalam setiap tahap pelayanan kesehatan. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep ini menjadi landasan dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal secara keseluruhan.

C. Faktor Risiko Maternal

Faktor risiko maternal merupakan segala kondisi atau karakteristik yang terdapat pada ibu sebelum maupun selama kehamilan yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Identifikasi faktor risiko maternal menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan ibu karena sebagian besar komplikasi dapat dicegah melalui deteksi dini dan intervensi yang tepat. Menurut World Health Organization (2020), faktor risiko

maternal berkontribusi besar terhadap kejadian morbiditas dan mortalitas ibu, terutama di negara berkembang.

Secara umum, faktor risiko maternal dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok utama, yaitu faktor demografi, faktor medis, faktor obstetri, serta faktor sosial ekonomi dan lingkungan. Faktor demografi meliputi usia ibu, paritas, dan jarak kehamilan. Kehamilan pada usia <20 tahun dan >35 tahun diketahui memiliki risiko lebih tinggi terhadap komplikasi seperti preeklamsia, perdarahan, dan persalinan prematur. Selain itu, paritas tinggi (≥ 4) serta jarak kehamilan yang terlalu dekat (<2 tahun) juga meningkatkan risiko kehamilan dan persalinan bermasalah (Cunningham et al., 2018).

Faktor medis atau penyakit penyerta merupakan determinan penting dalam risiko maternal. Beberapa kondisi yang sering ditemukan antara lain hipertensi dalam kehamilan, diabetes melitus, anemia, serta penyakit infeksi seperti Tuberkulosis dan HIV. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kesehatan ibu secara langsung maupun berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan janin. Misalnya, anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko perdarahan postpartum dan kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) (World Health Organization, 2020).

Selain itu, faktor obstetri yang berkaitan dengan riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya juga berperan penting dalam menentukan risiko kehamilan saat ini. Riwayat komplikasi seperti abortus berulang, persalinan prematur, perdarahan antepartum, atau persalinan dengan tindakan (sectio caesarea) dapat menjadi prediktor terjadinya komplikasi pada kehamilan berikutnya. Menurut Saifuddin (2014), riwayat obstetri yang buruk merupakan salah satu indikator utama dalam penilaian kehamilan risiko tinggi.

Faktor sosial ekonomi dan lingkungan juga memiliki kontribusi signifikan terhadap risiko maternal. Rendahnya tingkat pendidikan, status ekonomi yang kurang, serta keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dapat menyebabkan keterlambatan dalam mendapatkan pelayanan yang adekuat. Hal ini sejalan dengan konsep *three delays*, yaitu keterlambatan dalam pengambilan keputusan, keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan, dan keterlambatan mendapatkan pelayanan yang sesuai (UNICEF, 2021). Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan paparan zat berbahaya juga dapat memperburuk kondisi kesehatan ibu selama kehamilan.

Dalam praktik pelayanan kesehatan, identifikasi faktor risiko maternal dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang mencakup anamnesis, pemeriksaan fisik, serta pemeriksaan penunjang. Pendekatan ini bertujuan untuk mengelompokkan ibu hamil ke dalam kategori risiko rendah, tinggi,

atau sangat tinggi, sehingga intervensi yang diberikan dapat disesuaikan dengan tingkat risiko yang dimiliki. Di Indonesia, pendekatan ini telah diintegrasikan dalam pelayanan antenatal terpadu yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022).

Dengan demikian, faktor risiko maternal merupakan konsep multidimensional yang mencakup aspek biologis, medis, obstetri, serta sosial ekonomi. Pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor ini sangat penting bagi tenaga kesehatan dalam melakukan deteksi dini, perencanaan asuhan, serta pengambilan keputusan klinis yang tepat guna menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu.

D. Faktor Risiko Neonatal

Faktor risiko neonatal merupakan kondisi atau karakteristik yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan kesehatan atau kematian pada bayi baru lahir dalam periode neonatal, yaitu sejak lahir hingga usia 28 hari. Periode ini merupakan fase paling rentan dalam siklus kehidupan manusia karena bayi harus beradaptasi secara cepat dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin. Menurut World Health Organization (2020), sebagian besar kematian neonatal disebabkan oleh kondisi yang sebenarnya dapat dicegah melalui identifikasi dini faktor risiko dan intervensi yang tepat.

Secara umum, faktor risiko neonatal dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu faktor maternal, faktor kehamilan dan persalinan, serta faktor neonatal langsung. Faktor maternal berkaitan erat dengan kondisi ibu selama kehamilan, seperti status gizi yang buruk, penyakit kronis, serta infeksi. Ibu dengan anemia, diabetes melitus, atau infeksi selama kehamilan memiliki risiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), prematuritas, maupun infeksi neonatal. Selain itu, paparan zat berbahaya seperti rokok, alkohol, dan obat-obatan tertentu juga dapat memengaruhi perkembangan janin (Cunningham et al., 2018).

Faktor kehamilan dan persalinan juga memiliki kontribusi signifikan terhadap risiko neonatal. Prematuritas (kelahiran sebelum usia kehamilan 37 minggu) merupakan salah satu penyebab utama kematian neonatal di dunia. Bayi prematur memiliki organ yang belum matang, terutama paru-paru, sehingga rentan mengalami gangguan pernapasan. Selain itu, berat badan lahir rendah (BBLR <2500 gram) juga menjadi faktor risiko penting karena berkaitan dengan rendahnya cadangan energi dan sistem imun yang belum optimal. Kondisi lain seperti asfiksia lahir, persalinan lama, serta tindakan obstetri juga dapat meningkatkan risiko komplikasi pada bayi baru lahir (World Health Organization, 2020).

Selanjutnya, faktor neonatal langsung mencakup kondisi yang terjadi pada bayi setelah lahir, seperti kelainan kongenital, infeksi neonatal (sepsis), serta gangguan adaptasi pernapasan. Kelainan kongenital dapat memengaruhi fungsi organ vital dan berpotensi menyebabkan kematian jika tidak ditangani secara cepat. Infeksi neonatal sering terjadi akibat paparan mikroorganisme selama proses persalinan atau dari lingkungan setelah lahir, terutama pada bayi dengan sistem imun yang belum matang (Saifuddin, 2014).

Selain faktor klinis, determinan sosial dan lingkungan juga berperan dalam meningkatkan risiko neonatal. Keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan ibu, serta kondisi lingkungan yang tidak sehat dapat memperburuk kondisi bayi baru lahir. Hal ini berkaitan dengan konsep *three delays*, yang meliputi keterlambatan dalam mengenali tanda bahaya, keterlambatan dalam mencapai fasilitas kesehatan, dan keterlambatan dalam mendapatkan pelayanan yang adekuat (UNICEF, 2021).

Dalam praktik pelayanan kesehatan, identifikasi faktor risiko neonatal dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang dimulai sejak masa antenatal hingga postnatal. Pelayanan antenatal terpadu memungkinkan tenaga kesehatan untuk mendeteksi faktor risiko sejak dini, sedangkan pemantauan selama persalinan dan setelah lahir bertujuan untuk mengidentifikasi komplikasi yang muncul secara cepat. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022), integrasi pelayanan ibu dan bayi baru lahir sangat penting dalam menurunkan angka kematian neonatal.

Dengan demikian, faktor risiko neonatal merupakan hasil interaksi kompleks antara kondisi ibu, proses kehamilan dan persalinan, serta kondisi bayi itu sendiri. Pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor tersebut sangat penting dalam upaya deteksi dini, pencegahan, dan penatalaksanaan yang tepat guna meningkatkan kelangsungan hidup dan kualitas kesehatan bayi baru lahir.

E. Metode Identifikasi Faktor Risiko

Identifikasi faktor risiko maternal dan neonatal merupakan langkah awal yang krusial dalam upaya pencegahan komplikasi pada ibu dan bayi. Proses ini dilakukan secara sistematis melalui pendekatan klinis dan berbasis risiko (*risk-based approach*) untuk mendeteksi secara dini kondisi yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Menurut World Health Organization (2020), deteksi dini faktor risiko melalui pelayanan kesehatan yang terintegrasi dapat secara signifikan menurunkan angka kesakitan dan kematian maternal serta neonatal.

Metode identifikasi faktor risiko dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, serta penggunaan

sistem skoring risiko. Keempat komponen ini saling melengkapi dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ibu dan bayi.

1. Anamnesis (Pengkajian Riwayat)

Anamnesis merupakan tahap awal dalam identifikasi faktor risiko yang dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan ibu. Informasi yang dikumpulkan meliputi:

- a. Riwayat kesehatan ibu (penyakit kronis, infeksi, alergi)
- b. Riwayat obstetri (jumlah kehamilan, persalinan, komplikasi sebelumnya)
- c. Riwayat kehamilan saat ini (usia kehamilan, keluhan)
- d. Riwayat sosial ekonomi (pendidikan, pekerjaan, akses pelayanan kesehatan)

Anamnesis yang komprehensif memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi faktor risiko sejak dini, termasuk faktor yang tidak tampak secara klinis (Cunningham et al., 2018).

2. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan fisik bertujuan untuk menilai kondisi umum dan status kesehatan ibu secara objektif. Pemeriksaan yang dilakukan antara lain:

- a. Pengukuran tekanan darah (deteksi hipertensi/preeklamsia)
- b. Penilaian status gizi (Indeks Massa Tubuh/IMT dan Lingkar Lengan Atas/LILA)
- c. Pemeriksaan tinggi fundus uteri (pertumbuhan janin)
- d. Pemeriksaan tanda-tanda anemia atau infeksi

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022), pemeriksaan fisik merupakan bagian integral dari pelayanan antenatal terpadu untuk mendeteksi dini kehamilan berisiko.

3. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk melengkapi hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jenis pemeriksaan meliputi:

- a. Pemeriksaan laboratorium (Hb untuk anemia, gula darah untuk diabetes, urin untuk proteinuria)
- b. Ultrasonografi (USG) untuk menilai kondisi janin dan usia kehamilan
- c. Skrining penyakit infeksi seperti HIV, sifilis, dan Tuberkulosis

Pemeriksaan ini membantu dalam mendeteksi kondisi yang tidak dapat diidentifikasi hanya melalui pemeriksaan klinis (WHO, 2020).

4. Sistem Skoring Risiko

Sistem skoring digunakan untuk mengelompokkan tingkat risiko kehamilan berdasarkan faktor-faktor yang telah diidentifikasi. Salah satu metode yang lebar digunakan di Indonesia adalah: Kartu Skor Poedji Rochjati (KSPR). Melalui sistem ini, ibu hamil diklasifikasikan menjadi:

- a. Risiko rendah
- b. Risiko tinggi
- c. Risiko sangat tinggi

Menurut Saifuddin (2014), penggunaan skoring risiko mempermudah tenaga kesehatan dalam menentukan kebutuhan rujukan dan intervensi yang sesuai.

5. Pendekatan Continuum of Care

Identifikasi faktor risiko tidak hanya dilakukan pada satu tahap, tetapi secara berkelanjutan mulai dari:

- a. Masa prakonsepsi
- b. Kehamilan (antenatal)
- c. Persalinan (intranatal)
- d. Masa nifas dan neonatal (postnatal)

Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perubahan kondisi ibu dan bayi dapat terdeteksi secara dini. UNICEF (2021) menekankan bahwa kesinambungan pelayanan sangat penting dalam menurunkan risiko komplikasi dan kematian.

6. Pendekatan Berbasis Risiko (Risk-Based Approach)

Pendekatan ini menekankan pada pengelompokan pasien berdasarkan tingkat risiko yang dimiliki, sehingga:

- a. Ibu dengan risiko rendah mendapatkan pelayanan standar
- b. Ibu dengan risiko tinggi mendapatkan pemantauan lebih intensif
- c. Ibu dengan risiko sangat tinggi dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan

Pendekatan ini meningkatkan efisiensi pelayanan serta efektivitas intervensi (Kemenkes RI, 2022).

F. Dampak Faktor Risiko

Faktor risiko maternal dan neonatal memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan ibu dan bayi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak tersebut tidak hanya berkaitan dengan meningkatnya angka kesakitan (morbidity), tetapi juga berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian neonatal (AKN). Menurut World Health Organization (2020), sebagian

besar komplikasi yang menyebabkan kematian ibu dan bayi berawal dari faktor risiko yang tidak teridentifikasi atau tidak ditangani secara adekuat sejak dini.

1. Dampak pada Ibu (Maternal)

Faktor risiko maternal dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Salah satu dampak utama adalah terjadinya perdarahan, baik antepartum maupun postpartum, yang merupakan penyebab utama kematian ibu di dunia. Selain itu, hipertensi dalam kehamilan seperti preeklamsia dan eklamsia dapat menyebabkan gangguan organ vital hingga kematian jika tidak ditangani dengan cepat (Cunningham et al., 2018).

Infeksi juga menjadi dampak penting dari faktor risiko maternal, terutama pada kondisi dengan status gizi buruk atau penyakit penyerta. Infeksi dapat terjadi selama kehamilan maupun setelah persalinan, dan berpotensi menyebabkan sepsis. Selain itu, anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko kelelahan, perdarahan, serta memperburuk kondisi ibu selama persalinan (World Health Organization, 2020).

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah komplikasi obstetri seperti persalinan lama, ruptur uteri, serta kebutuhan tindakan operatif seperti sectio caesarea. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan risiko medis, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis dan sosial ibu, termasuk stres dan trauma pasca persalinan (Saifuddin, 2014).

2. Dampak pada Bayi (Neonatal)

Faktor risiko maternal dan kondisi selama kehamilan sangat memengaruhi kesehatan bayi yang dilahirkan. Salah satu dampak utama adalah kelahiran prematur, yaitu bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu. Bayi prematur memiliki organ yang belum matang, sehingga rentan mengalami gangguan pernapasan, infeksi, dan gangguan perkembangan (World Health Organization, 2020).

Selain itu, berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan dampak lain yang sering terjadi akibat faktor risiko seperti malnutrisi ibu atau penyakit selama kehamilan. Bayi dengan BBLR memiliki risiko lebih tinggi mengalami hipotermia, hipoglikemia, serta gangguan sistem imun. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko kematian neonatal maupun gangguan tumbuh kembang di masa mendatang (Cunningham et al., 2018).

Asfiksia lahir juga merupakan dampak penting yang dapat terjadi akibat komplikasi selama persalinan. Kondisi ini ditandai dengan gangguan pernapasan pada bayi saat lahir, yang dapat menyebabkan kerusakan otak permanen atau kematian jika tidak segera ditangani. Selain itu, infeksi neonatal seperti sepsis juga

menjadi penyebab utama kematian bayi baru lahir, terutama pada lingkungan dengan sanitasi yang buruk (Saifuddin, 2014).

3. Dampak Jangka Panjang

Dampak faktor risiko tidak hanya dirasakan pada periode kehamilan dan neonatal, tetapi juga dapat berlanjut dalam jangka panjang. Pada ibu, komplikasi kehamilan seperti hipertensi dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular di kemudian hari. Sementara itu, pada bayi, kondisi seperti prematuritas dan BBLR dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang, keterlambatan perkembangan kognitif, serta peningkatan risiko penyakit kronis di masa dewasa (UNICEF, 2021).

4. Dampak Sosial dan Ekonomi

Faktor risiko maternal dan neonatal juga memiliki dampak luas terhadap aspek sosial dan ekonomi. Komplikasi kehamilan dan persalinan dapat meningkatkan biaya perawatan kesehatan, baik bagi keluarga maupun sistem kesehatan. Selain itu, kematian atau kecacatan pada ibu dan bayi dapat memengaruhi kualitas hidup keluarga serta produktivitas masyarakat secara keseluruhan.

Konsep *three delays* yang dikemukakan oleh UNICEF (2021) menunjukkan bahwa dampak faktor risiko sering kali diperparah oleh keterlambatan dalam pengambilan keputusan, akses layanan, dan pemberian pelayanan kesehatan yang memadai.

G. Upaya Pencegahan dan Penatalaksanaan

Upaya pencegahan dan penatalaksanaan faktor risiko maternal dan neonatal merupakan strategi kunci dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi. Pendekatan ini dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan, mulai dari masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, hingga periode nifas dan neonatal. Menurut World Health Organization (2020), intervensi yang tepat pada setiap tahap pelayanan kesehatan dapat mencegah sebagian besar komplikasi yang mengancam keselamatan ibu dan bayi.

Upaya pencegahan dan penatalaksanaan faktor risiko maternal dan neonatal merupakan strategi kunci dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi. Pendekatan ini dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan, mulai dari masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, hingga periode nifas dan neonatal. Menurut World Health Organization (2020), intervensi yang tepat pada setiap tahap pelayanan kesehatan dapat mencegah sebagian besar komplikasi yang mengancam keselamatan ibu dan bayi.

1. Upaya Pencegahan

Pencegahan faktor risiko maternal dan neonatal dilakukan melalui tiga tingkat pencegahan, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier.

a. Pencegahan Primer

Pencegahan primer bertujuan untuk menghindari munculnya faktor risiko sebelum terjadi kehamilan maupun selama kehamilan awal. Upaya yang dilakukan meliputi:

- 1) Edukasi kesehatan reproduksi
- 2) Perbaikan status gizi ibu (suplementasi zat besi dan asam folat)
- 3) Perencanaan kehamilan yang sehat (usia ideal 20–35 tahun)
- 4) Imunisasi sebelum dan selama kehamilan
- 5) Pengendalian penyakit kronis sebelum konsepsi

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2022), pelayanan prakonsepsi merupakan langkah awal yang penting dalam menyiapkan kehamilan yang sehat.

b. Pencegahan Sekunder

Pencegahan sekunder dilakukan melalui deteksi dini dan penanganan cepat terhadap faktor risiko yang telah ada. Upaya ini meliputi:

- 1) Pelayanan antenatal care (ANC) terpadu secara rutin
- 2) Skrining faktor risiko (anemia, hipertensi, diabetes, infeksi)
- 3) Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan janin
- 4) Identifikasi kehamilan risiko tinggi melalui sistem skoring

Deteksi dini memungkinkan intervensi yang lebih cepat sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat (Cunningham et al., 2018).

c. Pencegahan Tersier

Pencegahan tersier bertujuan untuk mengurangi dampak komplikasi yang telah terjadi agar tidak menimbulkan kecacatan atau kematian. Upaya ini meliputi:

- 1) Penatalaksanaan komplikasi secara adekuat di fasilitas kesehatan
- 2) Rujukan tepat waktu ke fasilitas yang lebih lengkap
- 3) Perawatan intensif pada ibu dan bayi berisiko tinggi

UNICEF (2021) menekankan bahwa sistem rujukan yang efektif sangat penting dalam mengurangi dampak komplikasi maternal dan neonatal.

2. Penatalaksanaan Faktor Risiko Maternal

Penatalaksanaan faktor risiko maternal dilakukan sesuai dengan jenis dan tingkat risiko yang dimiliki ibu, antara lain:

- a. Hipertensi dalam kehamilan: pemantauan tekanan darah, pemberian obat antihipertensi, dan rujukan bila diperlukan

- b. Anemia: suplementasi zat besi, perbaikan gizi, dan pemantauan kadar hemoglobin
- c. Diabetes gestasional: pengaturan diet, aktivitas fisik, dan terapi insulin bila diperlukan
- d. Infeksi (misalnya Tuberkulosis): pengobatan sesuai standar dan pemantauan ketat

Penatalaksanaan ini bertujuan untuk menjaga kondisi ibu tetap stabil serta mencegah komplikasi pada janin (World Health Organization, 2020).

3. Penatalaksanaan Faktor Risiko Neonatal

Penatalaksanaan pada bayi baru lahir berfokus pada stabilisasi kondisi dan pencegahan komplikasi lebih lanjut, antara lain:

- a. Bayi prematur: perawatan metode kanguru (PMK), pemantauan suhu, dan dukungan pernapasan
- b. BBLR: pemenuhan nutrisi adekuat dan pencegahan infeksi
- c. Asfiksia lahir: resusitasi neonatal segera setelah lahir
- d. Infeksi neonatal: pemberian antibiotik dan perawatan intensif

Penanganan yang cepat dan tepat sangat menentukan keberlangsungan hidup bayi baru lahir (Saifuddin, 2014).

4. Pendekatan Continuum of Care

Upaya pencegahan dan penatalaksanaan dilakukan secara berkesinambungan melalui:

- a. Pelayanan prakonsepsi
- b. Pelayanan antenatal (ANC)
- c. Pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih
- d. Pelayanan nifas dan neonatal

Pendekatan ini memastikan bahwa setiap faktor risiko dapat terdeteksi dan ditangani pada setiap tahap pelayanan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

5. Penguatan Sistem Kesehatan dan Edukasi

Selain intervensi klinis, diperlukan dukungan sistem kesehatan yang kuat, meliputi:

- a. Peningkatan akses layanan kesehatan
- b. Edukasi ibu dan keluarga tentang tanda bahaya
- c. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
- d. Penguatan sistem rujukan

Upaya ini penting untuk mengatasi hambatan yang berkaitan dengan konsep three delays (UNICEF, 2021).

H. Penutup

Identifikasi faktor risiko maternal dan neonatal merupakan komponen esensial dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Melalui proses identifikasi yang sistematis dan komprehensif, berbagai kondisi yang berpotensi menimbulkan komplikasi dapat dikenali sejak dini, sehingga memungkinkan dilakukannya intervensi yang tepat dan *своевaktu*. Hal ini sejalan dengan rekomendasi World Health Organization (2020) yang menekankan pentingnya deteksi dini dan penanganan terintegrasi dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi. Pemahaman terhadap faktor risiko maternal dan neonatal, baik yang bersifat biologis, medis, obstetri, maupun sosial ekonomi, menjadi landasan dalam perencanaan asuhan yang efektif dan berorientasi pada keselamatan pasien. Pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*) serta penerapan *continuum of care* memungkinkan pelayanan kesehatan dilakukan secara berkesinambungan sejak masa prakonsepsi hingga periode neonatal.

Dalam konteks ini, peran tenaga kesehatan menjadi sangat penting dalam melakukan skrining, edukasi, serta pengambilan keputusan klinis yang tepat.

Selain itu, keberhasilan upaya pencegahan dan penatalaksanaan faktor risiko tidak hanya ditentukan oleh aspek klinis, tetapi juga oleh dukungan sistem kesehatan yang kuat, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, sistem rujukan yang efektif, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat. UNICEF (2021) menegaskan bahwa faktor sosial dan keterlambatan dalam mendapatkan pelayanan (*konsep three delays*) masih menjadi tantangan utama dalam menurunkan angka kematian maternal dan neonatal.

Dengan demikian, upaya peningkatan kesehatan maternal dan neonatal memerlukan pendekatan yang holistik, terintegrasi, dan berkelanjutan. Implementasi identifikasi faktor risiko yang optimal, disertai dengan intervensi yang tepat dan sistem pelayanan yang responsif, diharapkan dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas serta meningkatkan kualitas hidup ibu dan bayi.

Oleh karena itu, sinergi antara tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan, baik di tingkat nasional maupun global.

Referensi

- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Spong, C. Y., & Dashe, J. S. (2018). Williams obstetrics (25th ed.). McGraw-Hill Education.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Pedoman pelayanan antenatal terpadu. Jakarta: Kemenkes RI.
- Saifuddin, A. B. (2014). Buku acuan nasional pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka.
- UNICEF. (2021). Neonatal health report. New York: UNICEF.
- World Health Organization. (2020). Maternal and neonatal health guidelines. Geneva: WHO.

BAB 3

MANAJEMEN KEGAWATDARURATAN OBSTETRI DAN NEONATAL

A. Pendahuluan

Kesehatan ibu dan anak merupakan indikator utama kesejahteraan suatu bangsa. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian serius. Sebagian besar kematian maternal dan neonatal terjadi pada masa di sekitar persalinan, di mana kondisi klinis dapat berubah menjadi fatal hanya dalam hitungan menit.

Kegawatdaruratan obstetri dan neonatal sering kali datang tanpa peringatan. Kondisi seperti perdarahan hebat, kejang eklampsia, atau bayi yang tidak bernapas saat lahir memerlukan respons medis yang tidak hanya cepat, tetapi juga presisi. Keterlambatan dalam mengenali tanda bahaya (*the first delay*), keterlambatan mencapai fasilitas kesehatan (*the second delay*), dan keterlambatan mendapatkan penanganan adekuat di fasilitas kesehatan (*the third delay*) sering kali menjadi rantai penyebab kematian yang harus diputus.

B. Prinsip Dasar Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal

Prinsip dasar dalam penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal berfokus pada penyelamatan nyawa melalui tindakan yang cepat, tepat, dan tenang. Filosofi utamanya adalah "*time saving is life saving*", di mana efektivitas waktu sangat menentukan keberlangsungan hidup ibu dan bayi. (Kemenkes RI 2021). Berikut adalah pilar utama dalam prinsip dasar kegawatdaruratan:

1. Penilaian Awal dan Prioritas Vital (ABC)

Langkah pertama adalah melakukan penilaian awal secara cepat untuk menentukan diagnosis dan memprioritaskan fungsi vital. Urutan tindakan harus mengikuti standar resusitasi ABC: (Association of Women's Health, Obstetric and Neonatal Nurses (AWHONN) (2020)

- a. Airway (Jalan Napas): Memastikan saluran napas bersih dan tidak terhambat.
- b. Breathing (Pernapasan): Memperbaiki fungsi respirasi jika terjadi sesak atau henti napas.
- c. Circulation (Sirkulasi): Menjamin sirkulasi darah melalui terapi cairan dan penanganan perdarahan.

2. Etika dan Hak Pasien dalam Kondisi Kritis

Meskipun dalam situasi darurat, pelayanan harus tetap mengedepankan aspek kemanusiaan:

- a. Menghormati Hak Pasien: Setiap pasien harus diperlakukan dengan rasa hormat tanpa memandang status ekonomi atau golongan.
- b. Gentleness (Kelembutan): Pemeriksaan dan pengobatan dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk meminimalkan rasa sakit.
- c. Komunikatif: Petugas kesehatan wajib menjelaskan prosedur yang dilakukan kepada keluarga atau pendamping pasien untuk menjaga transparansi dan kerja sama.
- d. Privasi dan Dignitas: Menjaga kerahasiaan dan privasi pasien selama pemeriksaan medis berlangsung.

3. Stabilisasi dan Manajemen Rujukan

Stabilisasi adalah kunci sebelum pasien dipindahkan ke fasilitas yang lebih mampu:

- a. Prinsip Kecepatan dan Ketepatan: Tindakan rujukan harus efisien, efektif, dan sesuai dengan kewenangan fasilitas pelayanan.
- b. Sistem Rujukan Terpadu: Pengalihan tanggung jawab secara timbal balik antara unit yang kurang mampu ke unit yang lebih mampu secara vertikal.
- c. Pencegahan "Tiga Terlambat": Deteksi dini sangat krusial untuk mencegah keterlambatan dalam mengenali tanda bahaya, mencapai fasilitas, dan mendapatkan penanganan adekuat.

4. Empat Penyebab Utama Kematian Gawat Darurat

Penanganan difokuskan pada pengenalan segera kondisi kritis yang sering mengakibatkan kematian maternal dan neonatal: [23]

- a. Perdarahan: Memerlukan penghentian perdarahan dan penggantian cairan tubuh segera.
- b. Infeksi dan Sepsis: Membutuhkan pemberian antibiotik intravena yang cepat.
- c. Hipertensi (Preeklampsia/Eklampsia): Melibatkan penggunaan antikonvulsan intravena (seperti MgSO₄).
- d. Persalinan Macet: Memerlukan evaluasi kemajuan persalinan dan intervensi yang tepat.

C. Kegawatdaruratan kehamilan

Kegawatdaruratan kehamilan merujuk pada kondisi klinis yang mengancam nyawa ibu maupun janin selama masa gestasi. Secara garis besar, kegawatdaruratan ini dikelompokkan berdasarkan usia kehamilan karena penyebab dan gejalanya yang berbeda.

1. Kegawatdaruratan Kehamilan Muda (<22 Minggu)

Fokus utama pada periode ini adalah perdarahan pervaginam dan nyeri perut hebat.

- a. Kehamilan Ektopik Terganggu (KET): Kehamilan di luar rahim yang pecah. Gejala khasnya adalah nyeri perut akut yang sangat hebat disertai tanda syok (pucat, nadi cepat).
- b. Abortus Inkomplit: Keguguran di mana sebagian jaringan masih tertinggal di dalam rahim, menyebabkan perdarahan masif dan risiko infeksi (sepsis).
- c. Mola Hidatidosa (Hamil Anggur): Pertumbuhan jaringan trofoblas yang abnormal. Bahaya utamanya adalah perdarahan hebat atau munculnya preeklampsia dini (sebelum 20 minggu).

2. Kegawatdaruratan Kehamilan Lanjut (>22 Minggu)

Kondisi pada trimester kedua akhir dan ketiga yang sering kali memerlukan terminasi (persalinan segera).

- a. Preeklampsia Berat (PEB) & Eklampsia: Ditandai dengan tekanan darah sangat tinggi ($\geq 160/110$ mmHg). Jika terjadi kejang, kondisi ini disebut eklampsia dan merupakan penyebab utama kematian ibu di Indonesia [9].
- b. Solusio Plasenta: Terlepasnya plasenta sebelum waktunya. Gejala utamanya adalah nyeri perut hebat yang menetap dan rahim terasa tegang/keras seperti papan.
- c. Plasenta Previa: Plasenta yang menutupi jalan lahir. Ditandai dengan perdarahan merah segar tanpa rasa nyeri. Penting: Dilarang melakukan pemeriksaan dalam (VT) pada kasus ini sebelum dipastikan letak plasentanya.

3. Kegawatdaruratan Ketuban

- a. Ketuban Pecah Dini (KPD): Pecahnya ketuban sebelum tanda persalinan dimulai. Risiko utamanya adalah infeksi (amnionitis) dan prolaps tali pusat (tali pusat keluar mendahului bayi).
- b. Emboli Air Ketuban: Masuknya air ketuban ke sirkulasi darah ibu. Kondisi ini sangat langka namun memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi karena menyebabkan gagal napas dan henti jantung mendadak.

Prinsip Penanganan Umum

Setiap kasus kegawatdaruratan kehamilan harus ditangani dengan prinsip Stabilisasi sebelum rujukan:

1. Airway & Breathing: Pastikan jalan napas terbuka dan berikan oksigen.
2. Circulation: Pasang infus jalur besar (misal: jarum nomor 18) untuk mengganti volume cairan yang hilang akibat perdarahan.
3. Specific Treatment: Berikan obat spesifik (seperti MgSO₄ untuk eklampsia) sesuai protokol medis.

D. Kegawatdaruratan Persalinan

Kegawatdaruratan persalinan adalah kondisi kritis yang mengancam nyawa ibu maupun janin selama proses melahirkan atau segera setelahnya. Kondisi ini memerlukan intervensi medis segera untuk mencegah kematian atau kecacatan permanen. Keberhasilan penanganan sangat bergantung pada ketepatan waktu tanggap (*response time*) dan kesiapan fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK).

Kasus kegawatdaruratan dapat terjadi pada berbagai tahapan persalinan, mulai dari pembukaan hingga setelah bayi lahir.

1. Distosia (Persalinan Macet): Gangguan kemajuan persalinan akibat faktor kekuatan kontraksi (*power*), kondisi janin (*passenger*), atau jalan lahir (*passage*).
2. Distosia Bahu: Kepala bayi sudah lahir tetapi bahu anterior tersangkut pada simfisis pubis ibu.
3. Emboli Air Ketuban: Masuknya cairan ketuban ke sirkulasi darah ibu yang dapat menyebabkan gagal jantung dan paru secara mendadak.
4. Ketuban Pecah Dini (KPD): Pecahnya ketuban sebelum tanda-tanda persalinan muncul, yang meningkatkan risiko infeksi dan gawat janin.
5. Perdarahan Pasca-Salin (HPP): Perdarahan melebihi 500 ml setelah persalinan pervaginam yang sering disebabkan oleh atonia uteri atau robekan jalan lahir.
6. Eklampsia: Kondisi kejang pada ibu yang memiliki riwayat preeklampsia.

Penanganan kegawatdaruratan dilakukan secara sistematis dengan memprioritaskan fungsi vital melalui protokol stabilisasi.

1. Airway (Jalan Napas): Memastikan dan menjamin kelancaran jalan napas pasien.
2. Breathing (Pernapasan): Memberikan bantuan oksigenasi dan memastikan ventilasi paru berjalan normal.
3. Circulation (Sirkulasi): Mengontrol perdarahan, memasang infus jalur besar, dan memantau status hemodinamik.

4. Tindakan Definitif: Melakukan tindakan khusus seperti resusitasi neonatal, manual plasenta, atau persiapan operasi sesar darurat (Sectio Caesarea) yang idealnya dilakukan dalam waktu kurang dari 30 menit sejak keputusan diambil.

E. Kegawatdaruratan Pascapersalinan

Kegawatdaruratan pascapersalinan (masa nifas) adalah kondisi kritis yang terjadi setelah bayi lahir hingga 6 minggu setelahnya. Periode ini sangat krusial karena sebagian besar kematian ibu terjadi pada 24 jam pertama setelah persalinan.

Penyebab kegawatdaruratan ini sering dirangkum dalam kategori berikut:

1. Perdarahan Pascapersalinan (Hemorrhagia Postpartum/HPP): Penyebab utama kematian ibu. Dapat disebabkan oleh:
 - a. Atonia Uteri: Rahim tidak berkontraksi setelah plasenta lahir (penyebab tersering).
 - b. Retensio Plasenta: Plasenta atau sisa plasenta masih tertinggal di dalam rahim.
 - c. Robekan Jalan Lahir: Luka pada perineum, vagina, atau serviks.
 - d. Gangguan Pembekuan Darah: Darah sulit membeku.
2. Infeksi dan Sepsis Puerperalis: Infeksi pada saluran reproduksi setelah persalinan, sering ditandai dengan demam tinggi, nyeri perut bawah, dan cairan vagina berbau busuk.
3. Preklampsia dan Eklampsia Pascapersalinan: Tekanan darah tinggi dan kejang yang dapat terjadi meskipun bayi sudah lahir.
4. Inversio Uteri: Kondisi langka di mana rahim terbalik ke dalam atau keluar vagina, biasanya akibat tarikan tali pusat yang dipaksakan.
5. Tromboemboli: Pembekuan darah di pembuluh darah kaki yang dapat lepas ke paru-paru (emboli paru), menyebabkan sesak napas mendadak.

Tanda Bahaya yang Harus Segera Ditangani:

1. Perdarahan Hebat: Darah keluar sangat banyak secara tiba-tiba atau terus-menerus.
2. Pusing Hebat dan Penglihatan Kabur: Tanda tekanan darah tinggi yang sangat berbahaya.
3. Nyeri Perut Hebat: Melebihi rasa mulas normal pascasalin.
4. Sesak Napas atau Nyeri Dada: Potensi emboli atau gagal jantung.
5. Demam Tinggi dan Menggigil: Tanda infeksi berat.
6. Kesadaran Menurun: Ibu tampak sangat lemas, bingung, atau pingsan (tanda syok).

Prinsip Penanganan Awal

1. Hentikan Perdarahan: Melalui masase fundus uteri (pijat rahim) atau pemberian obat penguat kontraksi (oksitosin).

2. Resusitasi Cairan: Pemasangan infus jalur besar untuk mengganti darah yang hilang guna mencegah syok hipovolemik.
3. Stabilisasi: Memberikan oksigen dan menjaga suhu tubuh ibu agar tidak kedinginan.
4. Rujukan Cepat: Jika kondisi tidak membaik, ibu harus segera dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas PONEK yang lengkap.

F. Kegawatdaruratan Neonatal

Kegawatdaruratan neonatal adalah situasi medis kritis yang mengancam nyawa atau berisiko menyebabkan kecacatan pada bayi baru lahir (usia 0–28 hari). Kondisi ini membutuhkan penilaian dan penanganan yang sangat cepat, tepat, dan sistematis karena waktu yang terbatas untuk menyelamatkan nyawa bayi. Keberhasilan pertolongan sangat ditentukan oleh waktu tanggap (*response time*) dari penolong.

Beberapa kondisi patologis yang paling sering memicu keadaan gawat darurat pada bayi baru lahir meliputi:

1. Asfiksia Neonatorum: Ketidakmampuan bayi untuk bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir.
2. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) & Prematuritas: Bayi yang lahir dengan berat <2.500 gram atau sebelum usia kehamilan 37 minggu.
3. Infeksi & Sepsis: Infeksi bakteri sistemik yang dapat berkembang menjadi kritis dengan sangat cepat.
4. Gangguan Pernapasan: Seperti sindrom gawat napas yang sering terjadi pada bayi prematur.
5. Kelainan Kongenital: Kelainan struktur atau fungsi tubuh yang ada sejak lahir.
6. Hipotermia: Penurunan suhu tubuh di bawah normal yang dapat menyebabkan gangguan metabolik serius.
7. Tanda-Tanda Bahaya
8. Sianosis (Bibir Biru): Kulit atau bibir tampak kebiruan, menandakan kekurangan oksigen.
9. Kejang atau Spasme: Gerakan tubuh yang tidak terkontrol atau kekakuan otot.
10. Gangguan Kesadaran: Bayi tampak sangat lemas, sulit dibangunkan, atau tidak merespons rangsangan.
11. Gawat Napas: Napas megap-megap, terlalu cepat, atau adanya tarikan dinding dada yang dalam.
12. Suhu Tubuh Tidak Normal: Demam tinggi ($>38^{\circ}\text{C}$) atau suhu tubuh yang sangat dingin.

13. Sangat Kuning (Ikterus Berat): Warna kuning pada kulit yang memburuk dengan cepat.

Penanganan awal dilakukan dengan memprioritaskan fungsi vital melalui langkah-langkah terstruktur:

1. Resusitasi: Melakukan langkah awal bantuan napas seperti pengisapan lendir, pemanasan, dan pemberian stimulasi taktil.
2. Stabilisasi: Menjaga suhu tubuh bayi tetap hangat dan memastikan kebutuhan cairan atau nutrisi minimal terpenuhi.
3. Tindakan Definitif: Memberikan terapi spesifik seperti antibiotik untuk sepsis atau oksigenasi untuk gangguan napas.
4. Rujukan: Jika fasilitas tidak memadai, bayi harus segera dirujuk ke rumah sakit dengan fasilitas PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) menggunakan metode rujukan yang aman.

G. Prosedur Tindakan Operatif Gawat Darurat

Langkah-langkah teknis intervensi bedah dan manual yang harus dilakukan secara cepat untuk mengatasi ancaman nyawa pada ibu dan bayi.

Manual Plasenta :Tindakan pelepasan plasenta secara manual dari dinding rahim.

1. Indikasi: Plasenta belum lahir >30 menit setelah bayi lahir atau terjadi perdarahan hebat sebelum plasenta lahir.
2. Prosedur Kunci:
 - a. Tangan dalam masuk secara obstetrik mengikuti tali pusat.
 - b. Tangan luar menahan fundus uteri untuk mencegah inversio uteri.
 - c. Lakukan penyisiran dengan sisi kelingking tangan hingga seluruh plasenta terlepas.
 - d. Eksplorasi ulang untuk memastikan tidak ada jaringan yang tertinggal.

Kompresi Bimanual (Internal dan Eksternal) :Tindakan mekanis untuk menghentikan perdarahan akibat atonia uteri.

1. Kompresi Bimanual Internal (KBI): Tangan kanan masuk mengepal di forniks anterior vagina, tangan kiri menekan uterus dari luar melalui dinding perut. Tekan selama 5 menit.
2. Kompresi Bimanual Eksternal (KBE): Menekan rahim di antara kedua tangan dari luar dinding perut. Sering dilakukan saat menyiapkan tindakan KBI atau rujukan.
3. Kompresi Aorta Abdominalis: Penekanan pada arteri aorta di atas umbilikus untuk menghentikan aliran darah ke rahim dalam kondisi perdarahan masif.

Penjahitan Robekan Jalan Lahir

1. Indikasi: Perdarahan dari luka pada perineum, vagina, atau serviks setelah plasenta lahir lengkap.
2. Prinsip: Pastikan visualisasi yang baik dengan pencahayaan cukup. Jahit lapis demi lapis (mukosa, otot, kulit) untuk memastikan hemostasis (penghentian darah) yang sempurna.

Sectio Caesarea (SC) Darurat

Persalinan bedah yang harus dilakukan segera karena ancaman nyawa.

1. Target Waktu: *Decision-to-delivery interval* (DDI) idealnya <30 menit.
2. Kondisi Kritis: Ruptur uteri, prolaps tali pusat, gawat janin berat, atau perdarahan antepartum hebat.
3. Tindakan Pra-Operatif: Pasang infus jalur ganda (*double line*), pasang kateter urin, dan siapkan stok darah.

H. Penutup

Manajemen kegawatdaruratan obstetri dan neonatal bukanlah sekadar penguasaan atas algoritma medis atau keterampilan teknis di ruang operasi. Ia adalah sebuah seni menjaga kehidupan yang menuntut perpaduan antara kecepatan berpikir, ketajaman klinis, dan ketenangan batin di tengah krisis. Setiap detik yang kita lalui dalam menangani ibu dan bayi yang kritis adalah pertarungan nyawa yang membutuhkan dedikasi penuh dan standar keilmuan yang tidak dapat ditawar.

Berbagai spektrum komplikasi, mulai dari deteksi dini perdarahan pada kehamilan muda, penanganan kritis hipertensi, hingga penyelamatan "menit emas" bagi bayi baru lahir. Namun, ilmu pengetahuan bersifat dinamis. Oleh karena itu, seorang praktisi kesehatan yang kompeten adalah mereka yang tidak pernah berhenti belajar dan selalu memperbarui kemampuannya sesuai dengan perkembangan teknologi kesehatan dan pedoman klinis terbaru yang berbasis bukti (*evidence-based medicine*).

Akhir kata, setiap upaya yang kita lakukan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah investasi jangka panjang bagi masa depan generasi bangsa. Semoga buku ini tidak hanya menjadi sekumpulan teori di atas kertas, tetapi menjelma menjadi keterampilan nyata yang menyelamatkan nyawa di garis terdepan pelayanan.

Referensi

- American Academy of Pediatrics & American Heart Association. (2021). *Textbook of Neonatal Resuscitation (8th Edition)*. Itasca, IL: American Academy of Pediatrics.
- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2020). *Practice Bulletin No. 222: Gestational Hypertension and Preeclampsia*. Obstetrics & Gynecology, 135(6).
- Adhi, M. S., dkk. (2020). "Analisis Implementasi Audit Maternal Perinatal (AMP) dalam Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8(4), 452-460.
- Baskett, T. F. (2019). "The Management of Postpartum Haemorrhage." *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 61, 75-87. doi:10.1016/j.bpobgyn.2019.04.004.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2022). *Williams Obstetrics (26th Edition)*. New York: McGraw-Hill Education.
- International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO). (2022). *Postpartum Hemorrhage Care Bundle*. London: FIGO Office.
- Indrayani, T., & Riani, A. (2021). "Hubungan Pengetahuan Bidan tentang Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dengan Keterampilan Resusitasi Neonatus." *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 12(1), 15-22.
- Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). (2022). *Konsensus Nasional Resusitasi Neonatus*. Jakarta: Badan Penerbit IDAI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK): Tata Laksana Pre-Eklampsia*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Audit Maternal Perinatal (AMP) Terpadu*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Nugroho, A. S., dkk. (2019). "Manajemen Kejadian Inversio Uteri pada Persalinan Normal: Sebuah Laporan Kasus." *Indonesian Journal of Obstetrics and Gynecology*, 7(2), 115-119.

- Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI). (2021). *Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran: Tata Laksana Perdarahan Pascapersalinan*. Jakarta: POGI.
- Plowman, R. S., et al. (2017). "The Final Frontier: Implementation of Evidence-Based Neonatal Resuscitation." *Seminars in Fetal and Neonatal Medicine*, 22(4), 220-226.
- Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). (2020). *Green-top Guideline No. 42: Shoulder Dystocia*. London: RCOG.
- Widiastuti, A. (2020). "Studi Literatur: Pencegahan Hipotermia pada Bayi Baru Lahir dengan Metode Kanguru." *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Tradisional*, 5(2), 88-95.
- World Health Organization (WHO). (2022). *Abortion Care Guideline*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization (WHO). (2017). *Managing Complications in Pregnancy and Childbirth: A Guide for Midwives and Doctors*. Geneva: WHO Press.

Glosarium

A

1. Amenorea adalah Kondisi tidak terjadinya menstruasi atau terlambat haid, sering menjadi tanda awal kehamilan.
2. Apnea adalah Hentinya proses pernapasan untuk sementara waktu (lebih dari 20 detik pada neonatus).
3. Asfiksia Neonatorum adalah Kegagalan bayi baru lahir untuk bernapas secara spontan dan teratur segera setelah lahir.
4. Atonia Uteri adalah Kegagalan otot rahim untuk berkontraksi setelah persalinan, merupakan penyebab utama perdarahan pascasalin.

B

1. BAKSOKU: Akronim persiapan rujukan di Indonesia (Bidan, Alat, Keluarga, Surat, Obat, Kendaraan, Uang).
2. Bradikardia: Frekuensi denyut jantung yang lebih lambat dari rentang normal (pada janin/bayi <100 kali/menit).

D

Distosia Bahu adalah Kondisi gawat darurat saat kepala bayi sudah lahir namun bahu anterior terjepit di simfisis pubis ibu

H

Hemoragia Postpartum (HPP): Perdarahan pascapersalinan dengan volume >500 ml (pervaginam) atau >1000 ml (Sectio Caesarea).

Hipoglikemia: Kondisi kadar gula darah yang rendah (pada neonatus <45 mg/dL).

Hipotermia: Penurunan suhu tubuh di bawah rentang normal (pada neonatus <36,5°C).

BAB 4

PENCEGAHAN INFEKSI DALAM PRAKTIK KEBIDANAN

A. Pendahuluan

Pencegahan infeksi merupakan salah satu pilar utama keselamatan ibu dan bayi dalam praktik kebidanan. Setiap tindakan kebidanan, mulai dari pemeriksaan antenatal, pertolongan persalinan, penjahitan luka perineum, perawatan nifas, hingga perawatan bayi baru lahir, selalu membawa kemungkinan terjadinya kontak dengan darah, cairan ketuban, sekret, jaringan, alat medis, dan permukaan lingkungan yang berpotensi tercemar. Oleh sebab itu, pencegahan infeksi bukan sekadar prosedur teknis, melainkan fondasi mutu asuhan kebidanan. (Marshall, 2020), (Philippi. J, 2023), (WHO, 2021).

World Health Organization (WHO) menegaskan bahwa maternal sepsis masih menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu secara global dan berkontribusi signifikan terhadap mortalitas maternal. Di sisi lain, infeksi neonatal seperti sepsis, pneumonia, dan meningitis juga masih menyebabkan ratusan ribu kematian setiap tahunnya. Sebagian besar kondisi ini sebenarnya dapat dicegah melalui pencegahan infeksi, deteksi dini, serta penanganan yang tepat. (WHO, 2017)

Praktik kebidanan merupakan area berisiko tinggi karena mencakup fase-fase kritis kehidupan, yaitu kehamilan, persalinan, nifas, dan neonatal. Selama fase-fase tersebut, ibu dan bayi sering kali memerlukan tindakan yang melibatkan kontak erat, prosedur invasif, serta manipulasi jaringan. Bahkan pada persalinan normal, WHO menegaskan bahwa ada banyak tindakan yang membutuhkan kewaspadaan standar dan teknik aseptik, misalnya pemeriksaan vaginal, penjepitan tali pusat, pemasangan infus, penjahitan laserasi, atau penanganan bayi baru lahir. (Kemenkes, 2020)

Relevansi bab ini tidak hanya terkait praktik klinik individual, tetapi juga berkaitan dengan mutu layanan, akreditasi, keselamatan pasien, dan tata kelola fasilitas kesehatan. Program pencegahan dan pengendalian infeksi yang baik akan membantu fasilitas kesehatan menurunkan angka infeksi terkait pelayanan kesehatan, meningkatkan kepercayaan masyarakat, melindungi tenaga kesehatan, dan membangun budaya keselamatan. Bagi bidan, penguasaan prinsip pencegahan infeksi adalah bagian tak terpisahkan dari profesionalisme dan akuntabilitas praktik. (CDC, 2024)

Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, tenaga kesehatan, pengunjung, serta masyarakat di sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Pedoman teknis tersebut menempatkan PPI sebagai bagian integral dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan, sehingga implementasinya tidak hanya terbatas pada rumah sakit, tetapi juga mencakup fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, termasuk praktik mandiri bidan dan layanan kebidanan komunitas. Lebih lanjut, Kemenkes RI menyatakan bahwa pelaksanaan PPI bertujuan untuk melindungi seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, menurunkan angka kejadian infeksi terkait pelayanan kesehatan, meningkatkan efisiensi pembiayaan, serta memberikan indikator terhadap mutu pelayanan yang diberikan. Dengan demikian, pencegahan infeksi dalam praktik kebidanan tidak hanya dipahami sebagai aspek klinis semata, tetapi juga sebagai bagian dari strategi keselamatan pasien dan manajemen mutu pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, PPI merupakan komponen esensial dalam sistem manajemen mutu dan keselamatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. (Kemenkes, 2020)

B. Konsep Dasar Pencegahan Infeksi dalam Kebidanan

Pencegahan infeksi dalam kebidanan adalah rangkaian tindakan sistematis untuk mengurangi, menghambat, atau memutus penularan mikroorganisme yang dapat menyebabkan penyakit pada ibu, bayi baru lahir, tenaga kesehatan, maupun lingkungan sekitar pelayanan. Dalam pelayanan kesehatan, infeksi yang timbul selama pasien menerima asuhan dan bukan sedang diderita pada saat pertama datang disebut sebagai *health care-associated infection* (HAI). Di area maternal-neonatal, HAI dapat muncul dalam bentuk endometritis, infeksi luka operasi, sepsis puerperalis, omfalitis, pneumonia neonatal, atau sepsis neonatal. (WHO, 2021)

Dalam praktik kebidanan, bidan perlu memahami beberapa istilah teknis yang kerap digunakan antara lain : (CDC, 2024), (Wilson, 2018)

1. Asepsis adalah upaya mencegah kontaminasi mikroorganisme ke area tubuh atau alat yang harus tetap bersih.
2. Antisepsis adalah penggunaan bahan kimia pada jaringan hidup, misalnya kulit atau mukosa, untuk menurunkan jumlah mikroorganisme.
3. Dekontaminasi adalah proses awal untuk mengurangi beban kontaminasi pada alat atau permukaan sebelum pembersihan lebih lanjut dilakukan.
4. Desinfeksi adalah proses membunuh sebagian besar mikroorganisme patogen pada benda mati, tetapi tidak selalu memusnahkan spora.

5. Disinfeksi tingkat tinggi atau *high-level disinfection* dilakukan terutama pada alat semikritis yang bersentuhan dengan mukosa atau kulit tidak utuh.
6. Sterilisasi adalah proses penghancuran seluruh bentuk mikroorganisme, termasuk spora, pada alat kritis.

Pemahaman terminologi ini penting karena menentukan pilihan prosedur yang sesuai untuk alat, permukaan, dan tindakan klinik. Misalnya, spekulum vaginal yang digunakan berulang harus menjalani pemrosesan ulang sesuai tingkat risikonya, sedangkan alat kritis yang masuk ke jaringan steril harus dipastikan benar-benar steril. Kesalahan dalam membedakan antara desinfeksi, DTT, dan sterilisasi dapat menyebabkan alat yang seharusnya aman justru tetap menjadi sumber penularan. (Kemenkes, 2020)

Secara epidemiologis, penularan infeksi terjadi melalui rantai penularan infeksi yang terdiri atas agen infeksius, *reservoir*, pintu keluar, cara transmisi, pintu masuk, dan pejamu rentan. Agen infeksi dapat berupa bakteri, virus, jamur, atau parasit. Reservoir dapat berupa darah, sekret, cairan ketuban, tangan petugas, instrumen, linen, atau permukaan lingkungan. Pintu keluar dapat berupa darah, cairan tubuh, urin, atau sekret. Transmisi dapat terjadi melalui kontak langsung, kontak tidak langsung melalui alat, droplet, atau benda yang terkontaminasi. Pintu masuk dapat berupa kulit yang luka, mukosa, tali pusat, atau lokasi prosedur invasif. Pejamu rentan adalah ibu hamil, ibu nifas, bayi baru lahir, atau tenaga kesehatan yang terpajan. (WHO, 2021)

Upaya pencegahan infeksi pada dasarnya adalah upaya memutus satu atau lebih mata rantai penularan tersebut. Cuci tangan memutus transmisi melalui tangan petugas; penggunaan APD mengurangi pajanan dan pintu masuk; teknik aseptik mencegah kuman masuk ke jaringan rentan; pemrosesan alat dan pembersihan lingkungan menurunkan reservoir serta transmisi tidak langsung; pengelolaan limbah dan benda tajam mencegah pajanan baru; sedangkan edukasi ibu dan keluarga memperluas pencegahan ke rumah dan komunitas. (WHO, 2021)

PPI sebagai serangkaian upaya untuk mencegah dan meminimalkan kejadian infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Pedoman ini juga memperkenalkan beberapa istilah penting yang relevan untuk praktik kebidanan, seperti bundles sebagai seperangkat praktik berbasis bukti yang diterapkan bersama untuk memperbaiki luaran pelayanan, surveillance sebagai proses pengumpulan dan analisis data kejadian infeksi secara berkelanjutan, serta infection control risk assessment (ICRA) sebagai penilaian risiko multidisiplin untuk mengurangi risiko infeksi dalam proses pelayanan. Dengan memasukkan konsep-konsep ini ke dalam praktik kebidanan, pencegahan infeksi

tidak hanya dipahami pada level tindakan individual, tetapi juga pada level sistem dan tata kelola mutu. (Kemenkes, 2020)

Tabel 4. 1 Istilah teknis penting dalam pencegahan infeksi

Istilah	Pengertian singkat	Contoh dalam kebidanan
Asepsis	Upaya mencegah kontaminasi mikroorganisme selama tindakan	Menjaga area steril saat penjahitan perineum
Antisepsis	Penggunaan bahan kimia pada jaringan hidup untuk menurunkan kuman	Persiapan kulit sebelum pemasangan infus
Dekontaminasi	Proses awal menurunkan kontaminasi pada alat/permukaan	Merendam alat bekas pakai sebelum dicuci
DTT/HLD	Disinfeksi tingkat tinggi untuk alat semikritis	Pemrosesan alat yang menyentuh mukosa
Sterilisasi	Penghancuran seluruh mikroorganisme termasuk spora	Instrumen tindakan invasif disterilkan sebelum dipakai

C. Risiko Infeksi pada Ibu, Bayi, dan Tenaga Kesehatan

1. Risiko pada Ibu

Ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas merupakan kelompok yang rentan mengalami infeksi, terutama bila terdapat faktor predisposisi atau intervensi klinik yang meningkatkan peluang invasi kuman. Faktor risiko maternal yang umum adalah anemia, malnutrisi, diabetes, ketuban pecah lama, persalinan lama, pemeriksaan vaginal berulang, perdarahan, retensi plasenta, luka jalan lahir, pemasangan alat atau prosedur invasif, dan tindakan bedah seperti seksio sesarea. Maternal sepsis dapat muncul selama kehamilan, persalinan, pascaaborsi, maupun masa nifas, dan dapat berkembang menjadi kegagalan organ bila tidak dikenali serta ditangani tepat waktu. Seksio sesarea menjadi faktor risiko penting karena tindakan ini melibatkan sayatan pada jaringan, penggunaan alat bedah, dan masa penyembuhan luka. Martin dkk. (2018) menunjukkan bahwa

pencegahan infeksi luka operasi pada seksio sesarea membutuhkan strategi perioperatif yang terintegrasi, termasuk profilaksis antibiotik sebelum insisi, persiapan antiseptik yang adekuat, dan langkah pencegahan lain yang berbasis bukti. (WHO, 2021), (Manaf. S.A, 2025)

2. Risiko pada Bayi Baru Lahir

Bayi baru lahir sangat rentan terhadap infeksi karena sistem imunnya belum matang. Risiko ini meningkat pada bayi prematur, bayi berat badan lahir rendah, bayi dari ibu dengan infeksi atau ketuban pecah lama, bayi yang memerlukan resusitasi, serta bayi yang menjalani prosedur invasif. Lingkungan persalinan dan perawatan awal yang tidak aman juga menjadi faktor penting dalam penularan kuman. Salah satu penyebab tingginya angka kematian neonatus adalah sepsis neonatorum. Terdapat beberapa faktor risiko yang menyebabkan sepsis neonatorum, antara lain bayi berat lahir rendah (BBLR) dan prematuritas, BBLR memiliki kemungkinan 3,8 kali mengalami sepsis dibandingkan dengan tanpa risiko BBLR. (Virly Isella, 2023)

BBLR dan prematur tidak hanya meningkatkan risiko terjadinya sepsis neonatorum, namun juga memiliki beberapa dampak negatif lain. Studi lain didapatkan bahwa bayi BBLR prematur yang mengalami sepsis memiliki risiko 2,5 kali untuk mengalami gangguan perkembangan neuromotorik. (Ferreira RC, 2014) Studi lain oleh Kardana, mendapatkan bahwa bayi dengan faktor risiko prematur BBLR meningkatkan risiko mortalitas pada bayi dengan sepsis neonatorum. (I.M, 2011)

WHO menyebut bahwa infeksi neonatal terutama berupa sepsis, pneumonia, dan meningitis. Banyak infeksi ini dapat dicegah melalui praktik persalinan yang bersih, kebersihan tangan sebelum menyentuh bayi, pemrosesan alat resusitasi yang benar, perawatan tali pusat yang aman, deteksi dini, serta rujukan cepat bila muncul tanda bahaya. Setiap tahunnya, infeksi berkontribusi terhadap sekitar 25% dari 2,8 juta kematian neonatal di seluruh dunia. Lebih dari 95% kematian neonatal terkait sepsis terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Kebersihan tangan merupakan metode yang murah dan hemat biaya untuk mencegah infeksi pada neonatus, menjadikannya intervensi yang terjangkau dan praktis di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Oleh karena itu, praktik kebersihan tangan berpotensi besar untuk mengurangi kejadian infeksi dan penyakit terkait infeksi. (WHO, 2021), (Kuti BP, 2023)

3. Risiko pada Bidan dan Tenaga Kesehatan

Bidan dan tenaga kesehatan juga memiliki risiko tinggi terhadap paparan darah dan cairan tubuh. Cedera tertusuk jarum, luka benda tajam, atau percikan sekret ke mata dan mukosa dapat menjadi jalan penularan infeksi. Karena itu, pencegahan infeksi harus melindungi pasien sekaligus tenaga kesehatan. CDC menekankan bahwa core practices of infection prevention berlaku untuk seluruh setting pelayanan dan bertujuan melindungi semua pihak yang terlibat dalam proses asuhan (CDC, 2024)

Risiko pada petugas meningkat ketika alur kerja tidak tertata, APD tidak tersedia, benda tajam tidak langsung dibuang ke safety box, atau ketika budaya keselamatan lemah. Dalam praktik sehari-hari, keselamatan tenaga kesehatan tidak boleh dipisahkan dari keselamatan ibu dan bayi. (CDC, 2024), (Kemenkes, 2020)

Tabel 4. 2 Ringkasan faktor risiko infeksi

Kelompok	Faktor risiko utama	Implikasi klinik
Ibu	Anemia, KPD lama, persalinan lama, tindakan invasif, seksio sesarea	Meningkatkan risiko endometritis, infeksi luka, dan sepsis
Bayi	Prematuritas, BBLR, prosedur invasif, lingkungan tercemar	Meningkatkan risiko sepsis, pneumonia, omfalitis
Tenaga kesehatan	Paparan darah/cairan tubuh, needle stick injury, alat tajam	Meningkatkan risiko cedera kerja dan transmisi penyakit

Faktor risiko yang tidak boleh diabaikan :

1. Ketuban pecah lebih dari 18 jam
 2. Demam intrapartum atau postpartum
 3. Pemeriksaan vaginal berulang tanpa indikasi kuat
 4. Operasi sesar atau tindakan obstetri operatif
- BBLR/prematur dan tali pusat dirawat tidak bersih

D. Kewaspadaan Standar dalam Praktik Kebidanan

Kewaspadaan standar adalah seperangkat praktik pencegahan infeksi yang harus diterapkan pada semua pasien, di semua setting pelayanan, tanpa memandang status infeksi yang sudah diketahui atau belum. CDC menempatkan kebersihan tangan, penggunaan APD, *respiratory hygiene*, injeksi aman, pengelolaan sharps, pembersihan lingkungan, penanganan linen, serta pemrosesan alat sebagai core practices yang harus tersedia di seluruh fasilitas Kesehatan. (CDC, 2024), (Kemenkes, 2020)

Pada layanan maternitas, WHO menekankan bahwa *standard precautions* harus diterapkan sejak kontak pertama dengan ibu hingga perawatan bayi baru lahir. Hal ini penting karena petugas sering berpindah cepat antara ibu, bayi, instrumen, dan lingkungan, sehingga risiko kontaminasi silang meningkat bila kewaspadaan standar tidak diterapkan dengan disiplin (WHO, 2021)

1. Kebersihan Tangan

Kebersihan tangan merupakan salah satu cara untuk membersihkan tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau handrub, bertujuan untuk menghilangkan kotoran dari kulit. Manfaat kebersihan tangan meliputi pengurangan risiko infeksi, pengurangan penyebaran mikroorganisme selama tindakan perawatan, dan pencegahan infeksi nosokomial pada pasien. Untuk mencegah penularan infeksi nosokomial, penting menjaga kebersihan tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan, dengan menggunakan teknik enam langkah dan five moment hand hygiene. Infeksi pada luka operasi, infeksi saluran kemih, dan infeksi aliran darah primer sering terjadi akibat kurangnya kepatuhan tenaga kesehatan dalam melaksanakan five moment hand hygiene. (M. Ernawati, 2021)

Berdasarkan data dari WHO, sekitar 8,70% dari 55 rumah sakit yang tersebar di 14 negara di Asia Tenggara, Eropa, Timur Tengah, dan Pasifik melaporkan prevalensi infeksi nosokomial. Insiden infeksi nosokomial tertinggi ditemukan di kawasan Mediterania Timur (11,80%) dan Asia Tenggara (10%), sementara di Eropa (7,70%) dan Pasifik Barat (9%) angkanya lebih rendah (M. Ernawati, 2021). Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2017), prevalensi infeksi nosokomial di Indonesia mencapai sekitar 15,74%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju, yang berkisar antara 4,8% hingga 15,5% (Kemenkes, 2020)

WHO mengadaptasi Your 5 Moments for Hand Hygiene untuk unit maternitas, yaitu: sebelum menyentuh ibu atau bayi; sebelum prosedur bersih atau aseptik; setelah risiko pajanan cairan tubuh; setelah menyentuh ibu atau bayi;

dan setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Dalam praktik kebidanan, momen hand hygiene mencakup sebelum pemeriksaan vaginal, sebelum penjepitan tali pusat, sebelum pengambilan darah, setelah pemeriksaan vaginal, setelah melahirkan plasenta, setelah memegang peralatan invasif, dan setelah menyentuh area sekitar ibu atau bayi. Penggunaan sarung tangan tidak menggantikan kebersihan tangan. (WHO, 2021)

Kebersihan tangan dengan sabun dan air mengalir terutama dilakukan ketika tangan tampak kotor, setelah terpajan bahan yang mengandung protein, atau ketika terdapat kontaminasi yang jelas. Sebaliknya, handrub berbahan dasar alkohol digunakan ketika tangan tidak tampak kotor dan diperlukan tindakan cepat di titik pelayanan. Pedoman tersebut juga menekankan pentingnya fasilitas pendukung, seperti ketersediaan air mengalir, sabun dalam dispenser, pengering tangan sekali pakai, handrub, serta audit kepatuhan kebersihan tangan secara berkala. Bagi praktik kebidanan, penegasan ini penting karena kebersihan tangan tidak hanya bergantung pada pengetahuan bidan, tetapi juga pada tersedianya sarana yang memadai di ruang ANC, ruang bersalin, ruang nifas, dan area perawatan bayi. (Kemenkes, 2020)

Dalam sebuah penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku petugas kesehatan terhadap kepatuhan mencuci tangan yaitu faktor individu, organisasi dan lingkungan (9). Ketiga faktor tersebut mempunyai ketergantungan dalam mempengaruhi kepatuhan dalam melaksanakan hand hygiene. Faktor individu yang mempengaruhi yaitu pengetahuan, sikap, beban kerja, dan motivasi. Faktor organisasi meliputi ada tidaknya prosedur tetap, sanksi, penghargaan, dukungan, pelatihan dan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan hand hygiene. Faktor lingkungan meliputi air dan arsitektur bangunan. (Neila Fauzia, 2014)

Penelitian Gon dkk menunjukkan bahwa kepatuhan kebersihan tangan petugas di ruang persalinan di banyak fasilitas negara berpendapatan rendah menengah masih belum optimal. Kepatuhan dipengaruhi bukan hanya oleh pengetahuan, tetapi juga oleh ketersediaan fasilitas, ergonomi ruangan, alur kerja, dan budaya keselamatan. (Gon, 2020), (de Barra, 2021)

2. Penggunaan Alat Pelindung Diri Berbasis Risiko

APD seperti sarung tangan, masker, pelindung mata, face shield, apron, dan gaun harus digunakan berdasarkan penilaian risiko. Sarung tangan digunakan untuk kontak dengan darah, sekret, mukosa, atau saat melakukan prosedur invasif. Masker dan pelindung mata diperlukan bila ada risiko percikan. APD harus dipakai dengan benar, dilepas dengan teknik yang aman, dan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebersihan tangan. (Kemenkes, 2020)

Penggunaan APD berbasis risiko penting dalam kebidanan karena tiap tindakan memiliki tingkat pajanan yang berbeda. Menolong persalinan kala II, menangani plasenta, atau membersihkan alat bekas pakai memiliki kebutuhan APD yang berbeda dari konseling antenatal. (Wilson, 2018), (WHO, 2021)

Pemilihan APD harus didasarkan pada potensi pajanan, dampak yang mungkin ditimbulkan, dan kesesuaian jenis APD dengan tindakan yang dilakukan. Pedoman ini merinci penggunaan penutup kepala, masker, pelindung wajah, gaun, celemek, sarung tangan, dan pelindung kaki sesuai tingkat risiko. Dalam praktik kebidanan, prinsip ini dapat diterjemahkan secara operasional: konseling antenatal umumnya memerlukan APD minimal, sedangkan pertolongan persalinan, penanganan plasenta, penjahitan, atau pengolahan alat membutuhkan APD yang lebih lengkap untuk melindungi petugas sekaligus mencegah kontaminasi silang. (Kemenkes, 2020)

3. Etika Batuk dan Higienitas Pernapasan

Etika batuk dan higienitas pernapasan harus diterapkan pada petugas, ibu, keluarga, dan pengunjung. Menutup mulut saat batuk atau bersin, memakai masker bila bergejala respiratori, menjaga jarak seperlunya, dan membersihkan tangan setelah kontak dengan sekret pernapasan merupakan bagian dari kewaspadaan standar. (Kemenkes, 2020)

4. Keamanan Benda Tajam dan Injeksi Aman

Prinsip satu jarum, satu spuit, satu pasien, satu kali pakai. Jarum dan spuit yang telah digunakan tidak boleh dipakai kembali pada pasien lain dan tidak boleh dimasukkan kembali ke vial obat. Pada kebidanan, prinsip ini berlaku untuk semua injeksi, misalnya uterotonika, anestesi lokal, antibiotik, vitamin K, dan imunisasi (CDC, 2024)

Benda tajam harus dibuang segera ke safety box tanpa praktik berisiko seperti recapping yang tidak perlu. Penundaan pembuangan benda tajam menjadi salah satu penyebab tersering cedera tusuk jarum pada petugas. (CDC, 2024), (Kemenkes, 2020)

5. Pengelolaan Limbah Infeksius, Linen, dan Lingkungan

Limbah terkontaminasi harus dipilah, dikemas, disimpan sementara, dan dimusnahkan sesuai kategori. Linen yang terkena darah atau cairan tubuh harus diperlakukan sebagai linen terkontaminasi, dipindahkan dengan aman, dan dicuci sesuai prosedur. Kebersihan lingkungan meliputi pembersihan dan desinfeksi meja persalinan, troli, tempat tidur, alat resusitasi, dan seluruh permukaan berisiko tinggi. (WHO, 2021)

WHO juga menekankan pentingnya *water, sanitation, and hygiene* (WASH) dalam fasilitas kesehatan. Tanpa air bersih, sabun, sanitasi, dan tempat

pembuangan limbah yang memadai, penerapan pencegahan infeksi akan sulit dicapai secara konsisten.

Sejalan dengan itu, Kemenkes memasukkan pengelolaan lingkungan, limbah, linen, dan peralatan sebagai bagian tidak terpisahkan dari kewaspadaan standar. Limbah harus dipilah sesuai kategori, linen terkontaminasi ditangani dengan aman, dan lingkungan pelayanan dibersihkan secara terjadwal maupun segera setelah terjadi kontaminasi. Bagi pelayanan kebidanan, penekanan ini penting karena meja persalinan, troli alat, alat resusitasi bayi, tempat tidur nifas, dan permukaan berisiko tinggi lain sering menjadi titik kritis kontaminasi bila tidak dikelola secara konsisten. (Kemenkes, 2020)

Kesalahan yang Harus Dihindari

- a. Memakai sarung tangan tanpa cuci tangan pada momen yang diperlukan
- b. Menaruh alat steril di permukaan yang belum didesinfeksi
- c. Menggunakan satu spuit untuk lebih dari satu pasien
- d. Tidak segera membuang jarum ke safety box
- e. Menganggap tugas kebersihan lingkungan bukan bagian dari keselamatan pasien

E. Teknik Aseptik pada Tindakan Kebidanan

Teknik aseptik adalah metode kerja untuk menjaga agar prosedur klinik tidak menjadi jalur masuk mikroorganisme ke tubuh pasien. Dalam kebidanan, teknik aseptik diperlukan pada pemeriksaan vaginal, pengambilan darah, pemasangan infus, kateterisasi, penjahitan luka perineum, perawatan luka operasi, penanganan tali pusat, dan tindakan awal pada bayi baru lahir. WHO menyatakan bahwa pada persalinan normal sekalipun banyak tindakan yang membutuhkan prinsip aseptik yang tepat (WHO, 2021)

Keberhasilan teknik aseptik sangat bergantung pada fase persiapan, pelaksanaan, dan penutupan tindakan. Banyak kegagalan aseptik justru terjadi sebelum tindakan dimulai, misalnya karena alat tidak siap, area bersih dan kotor tidak dipisah, atau petugas menyentuh permukaan tercemar ketika sedang menyiapkan instrumen. (Wilson, 2018), (WHO, 2017)

Pendekatan ini sejalan dengan pedoman teknis Kemenkes yang menempatkan kewaspadaan standar dan pencegahan infeksi prosedural sebagai satu rangkaian kerja, mulai dari persiapan petugas, kebersihan tangan, pemilihan APD, penyiapan instrumen, pelaksanaan tindakan, hingga dekontaminasi dan pembuangan bahan terkontaminasi setelah prosedur selesai. Dalam penulisan buku referensi kebidanan,

integrasi alur ini penting agar pembaca memahami bahwa teknik aseptik bukan hanya keterampilan individual, melainkan bagian dari sistem kerja klinik yang aman.

1. Prinsip Aseptik Sebelum Tindakan

Sebelum tindakan, bidan harus memastikan indikasi prosedur jelas, menyiapkan alat steril atau alat DTT sesuai kebutuhan, melakukan kebersihan tangan, memakai APD yang sesuai, serta menyiapkan antiseptik bila diperlukan. Pemeriksaan pra-tindakan yang teliti dapat mencegah terjadinya improvisasi saat prosedur sedang berlangsung. (Kemenkes, 2020)

Persiapan kulit atau area tindakan harus dilakukan dengan antiseptik yang sesuai. Area yang sudah dipersiapkan harus dipertahankan agar tidak tersentuh benda tidak steril. (Wilson, 2018)

2. Menjaga Area Steril dan Mencegah Kontaminasi Silang

Area steril harus dijaga agar tidak terkena sentuhan dari tangan, alat, atau permukaan yang tidak steril. Alat steril harus diletakkan pada bidang bersih yang sudah dipersiapkan. Bila sterilitas diragukan, alat harus dianggap tidak steril dan diganti. (Wilson, 2018)

Kontaminasi silang dapat terjadi bila petugas berpindah dari area kotor ke area bersih tanpa hand hygiene, atau bila alat bersih bercampur dengan alat kotor. Dalam praktik dengan ruang sempit, risiko ini sering kali lebih tinggi, sehingga penataan ruang dan alur kerja sangat penting. (de Barra, 2021)

3. Penutupan Tindakan dan Dekontaminasi Pascaprosedur

Setelah tindakan, benda tajam harus dibuang aman, alat bekas pakai didekontaminasi, permukaan kerja dibersihkan, APD dilepas dengan teknik yang benar, dan tangan dibersihkan kembali. Tahap ini penting untuk melindungi petugas, pasien berikutnya, dan lingkungan. (Kemenkes, 2020)

CDC menekankan bahwa alat harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum menjalani DTT atau sterilisasi. Sisa darah dan jaringan yang mengering dapat menghambat proses pemusnahan kuman bila pembersihan awal tidak dilakukan dengan benar (CDC, 2024)

Tips untuk Bidan Praktik Mandiri

- a. Pisahkan area bersih dan area kotor secara nyata, meski ruang terbatas.
- b. Sediakan tray tindakan lengkap agar tidak bolak-balik mengambil alat.
- c. Pasang checklist pra-tindakan dan pasca-tindakan di dekat meja praktik.
- d. Letakkan handrub di titik pelayanan, bukan hanya di wastafel utama.

F. Pencegahan Infeksi Menurut Tahap Pelayanan Kebidanan

1. Pada Pelayanan Antenatal

Pencegahan infeksi pada pelayanan antenatal dimulai dari skrining faktor risiko, identifikasi tanda-tanda infeksi pada ibu, edukasi kebersihan diri, dan penggunaan alat yang aman. Tindakan seperti pengambilan sampel darah atau pemberian imunisasi harus mengikuti prinsip injeksi aman dan kebersihan tangan. (WHO, 2021)

Pedoman Kemenkes menegaskan bahwa PPI di fasilitas kesehatan tingkat pertama diterapkan baik pada pelayanan dalam gedung maupun luar gedung, termasuk kegiatan UKP dan UKM. Bagi kebidanan, prinsip ini menunjukkan bahwa pencegahan infeksi tidak hanya relevan di ruang bersalin atau klinik, tetapi juga saat kunjungan rumah, pelayanan komunitas, skrining, konseling, imunisasi, dan kegiatan promotif preventif lain yang melibatkan ibu, bayi, maupun keluarga. Dengan demikian, bidan perlu menerapkan prinsip PPI secara adaptif sesuai konteks pelayanan tanpa menurunkan standar keselamatan. (Kemenkes, 2020)

Ruang periksa, meja tindakan, tensimeter, doppler, dan alat lain yang digunakan berulang harus dibersihkan antar pasien. Bidan juga perlu mengedukasi ibu mengenai kebersihan genital, cuci tangan, tanda bahaya infeksi, pentingnya nutrisi, dan kepatuhan kontrol kehamilan. (Marshall, 2020)

2. Pada Kala Persalinan

Pada kala persalinan, pencegahan infeksi harus dimulai dari persiapan ruang bersalin yang bersih, penyediaan alat yang siap pakai, ketersediaan APD, serta hand hygiene yang mudah dilakukan. Pemeriksaan vaginal harus dibatasi sesuai indikasi, karena pemeriksaan berulang dapat meningkatkan risiko infeksi, terutama bila ketuban sudah pecah. (WHO, 2021)

Pengendalian terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja dapat dilakukan melalui berbagai upaya, salah satunya adalah penggunaan alat pelindung diri (APD). Ketentuan mengenai APD telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/VII/2010. Dalam konteks pelayanan kebidanan, peran bidan dalam pencegahan infeksi juga diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017, yang menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional, termasuk pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Salah satu bentuk penerapannya adalah penggunaan APD oleh bidan saat memberikan pelayanan. Kurniawidjaja (2010) menjelaskan bahwa ketidaklengkapan penggunaan APD dalam pertolongan persalinan dapat meningkatkan risiko bagi tenaga kesehatan, seperti paparan bahaya fisik, kimia,

dan biologis, termasuk Hepatitis, HIV/AIDS, serta Tuberkulosis. (Nurhayati SH, 2017)

Saat menolong persalinan, bidan harus menerapkan teknik bersih dan aseptik, mengelola darah serta cairan tubuh secara aman, dan mencegah alat atau permukaan bersih tercemar. Penanganan kala III dan penjahitan laserasi juga memerlukan perhatian khusus terhadap aseptik. (Maharani, 2022)

3. Pada Tindakan Obstetri Tertentu

Tindakan obstetri tertentu seperti seksio sesarea, *operative vaginal birth*, *manual removal of placenta*, dan penjahitan laserasi memiliki risiko infeksi lebih tinggi. WHO merekomendasikan antibiotik profilaksis pada seksio sesarea, persiapan antiseptik praoperatif, dan vaginal preparation dengan antiseptik pada kondisi tertentu untuk mengurangi infeksi maternal pascapersalinan. Pada setiap prosedur, bidan atau tim harus memastikan indikasi jelas, alat steril tersedia, alur tindakan efisien, dan pemantauan pascatindakan dilakukan secara memadai. Persiapan vagina sebelum operasi sesar terbukti dapat menurunkan risiko kejadian infeksi pascaoperasi, seperti endometritis, demam pascaoperasi, dan infeksi luka. Di antara berbagai jenis antiseptik yang digunakan, povidone-iodine 1% dinilai memiliki efektivitas yang sangat baik dalam menurunkan risiko infeksi tersebut. (Liu, 2023)

4. Pada Masa Nifas

Masa nifas adalah fase penting untuk mendeteksi dini infeksi pada ibu. Pemantauan harus meliputi suhu tubuh, nyeri abdomen, kondisi lochea, status luka perineum atau luka operasi, dan tanda sistemik lain. Ibu juga perlu diedukasi mengenai kebersihan perineum, penggantian pembalut yang teratur, cara merawat luka, dan tanda bahaya yang memerlukan pertolongan segera. Maternal sepsis postpartum dapat berkembang cepat. Oleh karena itu, keterlambatan dalam mengenali gejala atau memberi rujukan dapat berakibat fatal. (Marshall, 2020)

5. Pada Bayi Baru Lahir

Pencegahan infeksi pada bayi baru lahir meliputi *hand hygiene* sebelum menyentuh bayi, penggunaan alat resusitasi yang telah diproses benar, pencegahan hipotermia, dan perawatan tali pusat bersih dan kering. WHO merekomendasikan *clean, dry cord care* untuk bayi yang lahir di fasilitas kesehatan, sedangkan penggunaan chlorhexidine memiliki rekomendasi kontekstual pada setting tertentu (WHO, 2021)

Kebersihan tangan sebelum dan sesudah kontak dengan bayi baru lahir merupakan langkah penting dalam pencegahan infeksi neonatus, karena tangan

tenaga kesehatan, ibu, maupun pengasuh dapat menjadi media perpindahan mikroorganisme penyebab infeksi. (Kuti, 2023)

Bayi prematur, bayi dengan berat lahir rendah, atau bayi yang tampak sakit memerlukan pemantauan lebih ketat karena risiko sepsis lebih tinggi, sedangkan gejala awalnya sering tidak khas, seperti malas menyusu, letargi, suhu tubuh tidak stabil, hipotermia, demam, apnea, atau tampak lemah. (Singh, 2022)

G. Intervensi Khusus Berbasis Rekomendasi

Pencegahan infeksi dalam kebidanan tidak hanya bergantung pada kewaspadaan standar, tetapi juga pada intervensi khusus yang telah direkomendasikan secara ilmiah. Salah satu intervensi dengan bukti kuat adalah pemberian antibiotik profilaksis pada seksio sesarea. WHO merekomendasikan antibiotik profilaksis untuk semua perempuan yang menjalani seksio sesarea, baik elektif maupun emergensi, guna menurunkan risiko infeksi pascaoperasi seperti infeksi luka operasi dan endometritis postpartum (WHO, 2021)

Pencegahan infeksi dalam praktik kebidanan tidak hanya dilakukan melalui penerapan kewaspadaan standar, tetapi juga melalui intervensi klinis yang memiliki dasar bukti ilmiah kuat. Pada tindakan seksio sesarea, salah satu intervensi utama adalah pemberian antibiotik profilaksis. WHO merekomendasikan antibiotik profilaksis bagi seluruh perempuan yang menjalani seksio sesarea, baik secara elektif maupun emergensi, sebagai upaya untuk menurunkan risiko infeksi maternal pascaoperasi, khususnya infeksi luka operasi dan endometritis postpartum. (WHO, 2021). (Temuan systematic review juga menunjukkan bahwa antibiotik profilaksis efektif mengurangi kejadian endometritis, infeksi luka, dan morbiditas demam setelah seksio sesarea. (Smaill, 2014)

Intervensi lain yang penting dalam pencegahan infeksi pasca seksio sesarea adalah persiapan kulit praoperatif menggunakan antiseptik yang sesuai, serta *vaginal preparation* dengan antiseptik pada kondisi tertentu sebelum tindakan operasi. Tinjauan sistematis menunjukkan bahwa strategi perioperatif yang diterapkan secara terpadu sebagai *bundle* lebih efektif dibandingkan intervensi tunggal dalam menurunkan risiko infeksi luka operasi setelah seksio sesarea. (Martin, 2018)

Tidak semua tindakan rutin dalam pelayanan kebidanan memberikan manfaat klinis. WHO menekankan bahwa pelayanan persalinan harus berbasis bukti dan menghindari intervensi yang tidak diperlukan, karena intervensi berlebihan dapat menurunkan kualitas pengalaman persalinan serta berpotensi meningkatkan risiko yang tidak perlu bagi ibu dan bayi. (WHO, 2018)

Penggunaan antibiotik secara berlebihan pada layanan maternal dan neonatal dapat menjadi masalah serius karena berkontribusi terhadap meningkatnya resistensi antimikroba dan melemahkan efektivitas pengendalian infeksi di fasilitas Kesehatan. (Kakolwa, 2021)

H. Pengolahan Alat dan Lingkungan Praktik

Keamanan instrumen dan lingkungan praktik merupakan komponen penting dalam keberhasilan pencegahan infeksi. CDC menegaskan bahwa proses pembersihan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum disinfeksi tingkat tinggi maupun sterilisasi, sebab alat yang tampak bersih secara visual belum tentu bebas dari darah, jaringan, atau bahan organik. Sisa bahan organik tersebut dapat menghambat kerja disinfektan maupun proses sterilisasi, sehingga meningkatkan risiko penularan mikroorganisme kepada pasien maupun tenaga kesehatan (CDC, 2024)

Pengolahan alat kesehatan perlu dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari pengumpulan alat kotor secara aman, dekontaminasi, pencucian menggunakan deterjen, pembilasan, pengeringan, disinfeksi tingkat tinggi atau sterilisasi sesuai jenis alat, hingga penyimpanan pada tempat yang bersih dan terlindung. Berdasarkan klasifikasi Spaulding, alat kritis yang masuk ke jaringan steril atau sistem vaskular harus disterilkan sebelum digunakan; alat semikritis yang kontak dengan membran mukosa memerlukan minimal disinfeksi tingkat tinggi; sedangkan alat nonkritis yang hanya kontak dengan kulit utuh harus dibersihkan dan didisinfeksi sesuai kebutuhan (Kemenkes, 2020)

Kebersihan lingkungan praktik kebidanan perlu dikelola secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Area seperti meja persalinan, troli tindakan, lampu tindakan, area resusitasi bayi, serta permukaan yang sering disentuh harus dibersihkan secara rutin sesuai jadwal dan segera dibersihkan setiap kali terjadi kontaminasi. WHO menekankan bahwa pembersihan lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dari pencegahan dan pengendalian infeksi, sehingga fasilitas perlu memiliki prosedur kerja, pembagian tanggung jawab, serta alat bantu seperti *checklist* untuk memastikan area prioritas, frekuensi pembersihan, bahan pembersih/disinfektan, dan petugas yang bertanggung jawab tercatat dengan jelas (Kemenkes, 2020).

WHO juga menegaskan bahwa layanan maternitas memerlukan dukungan WASH, yaitu ketersediaan air bersih, sanitasi, kebersihan tangan, dan pengelolaan limbah yang aman. Komponen ini bukan hanya aspek logistik, tetapi prasyarat dasar untuk menjaga keselamatan ibu, bayi baru lahir, keluarga, dan tenaga kesehatan.

Dalam konteks pelayanan primer, pedoman nasional juga menekankan bahwa fasilitas kesehatan harus menyesuaikan tata kelola lingkungan, sarana, prasarana, dan sumber daya agar program pencegahan dan pengendalian infeksi dapat dilaksanakan secara konsisten. (WHO, 2017)

Tabel 4. 3 Tabel Checklist Singkat Pengolahan Alat

Tahap	Pertanyaan kendali	Status (✓/X)
Dekontaminasi	Apakah alat segera diproses setelah digunakan?	
Pencucian	Apakah alat dicuci dengan deterjen dan disikat bila perlu?	
DTT/Sterilisasi	Apakah metode yang dipilih sesuai jenis alat?	
Penyimpanan	Apakah alat disimpan dalam kondisi bersih dan terlindung?	
Pemantauan	Apakah ada pencatatan proses dan tanggal pemrosesan?	

I. Edukasi Ibu dan Keluarga

Edukasi kepada ibu dan keluarga merupakan bagian penting dalam pencegahan infeksi, karena perawatan ibu dan bayi tidak hanya berlangsung di fasilitas kesehatan, tetapi juga berlanjut di rumah. Keluarga perlu diberikan informasi yang jelas mengenai kebersihan tangan sebelum menyentuh ibu atau bayi, menjaga kebersihan lingkungan rumah, merawat luka perineum maupun luka operasi, serta mengenali tanda bahaya infeksi pada ibu dan bayi. WHO menekankan bahwa konseling pascanatal harus mencakup edukasi kepada ibu, keluarga, dan komunitas mengenai tanda bahaya serta pentingnya segera mencari pertolongan bila muncul gejala yang mengarah pada komplikasi. (WHO, 2013)

Edukasi ibu dan keluarga merupakan komponen penting dalam pencegahan infeksi karena sebagian besar perawatan ibu dan bayi berlangsung di rumah. Keluarga perlu diajarkan mencuci tangan sebelum menyentuh ibu atau bayi, menjaga kebersihan lingkungan rumah, merawat luka perineum atau luka operasi, serta mengenali tanda bahaya infeksi pada ibu dan bayi. Edukasi tersebut perlu diberikan secara sederhana, berulang, praktis, dan sesuai konteks budaya keluarga

agar ibu dan keluarga memahami kapan harus kembali ke fasilitas kesehatan atau segera mencari pertolongan. (Marshall, 2020)

Untuk bayi baru lahir, keluarga perlu memahami prinsip perawatan tali pusat bersih dan kering, tidak mengoleskan bahan tradisional yang tidak steril, menjaga kebersihan tangan, serta segera mencari pertolongan apabila bayi tampak malas menyusu, demam atau hipotermia, napas cepat, kejang, tampak lemah, atau terdapat nanah di sekitar tali pusat. WHO merekomendasikan *clean, dry cord care* sebagai prinsip perawatan tali pusat bayi baru lahir, sedangkan penggunaan chlorhexidine dipertimbangkan pada konteks tertentu, terutama untuk menggantikan praktik tradisional yang berisiko menyebabkan infeksi. (WHO, 2021)

Edukasi kesehatan dalam pelayanan kebidanan sebaiknya disampaikan secara sederhana, berulang, aplikatif, dan memperhatikan konteks sosial budaya keluarga. Bidan juga berperan memastikan bahwa ibu dan keluarga memahami tanda bahaya serta mengetahui kapan harus kembali ke fasilitas kesehatan atau mendapatkan rujukan lebih lanjut. (Marshall, 2020)

Pesan Edukasi untuk Ibu dan Keluarga

- a. Cuci tangan sebelum menyentuh ibu atau bayi.
- b. Jaga luka perineum/luka operasi tetap bersih dan kering.
- c. Jangan mengoleskan bahan tradisional pada tali pusat.
- d. Segera ke fasilitas kesehatan bila ibu demam atau bayi malas menyusu.

J. Audit Mutu, Supervisi, dan Budaya Keselamatan

Pencegahan infeksi tidak dapat berjalan secara berkelanjutan apabila hanya mengandalkan kepatuhan individu. Diperlukan sistem mutu yang terstruktur, meliputi ketersediaan SOP tertulis, pelatihan berkala, supervisi, audit kepatuhan, pelaporan insiden, serta tindak lanjut perbaikan. CDC menegaskan bahwa pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sumber daya, kebijakan, dan dukungan organisasi yang memadai agar praktik pencegahan dan pengendalian infeksi dapat diterapkan secara konsisten dalam setiap pelayanan Kesehatan. Audit mutu dapat dilakukan secara sederhana tetapi rutin, misalnya melalui pengamatan kepatuhan kebersihan tangan, ketersediaan alat pelindung diri, ketepatan proses pengolahan instrumen, kebersihan ruang pelayanan, serta pencatatan kejadian pajanan benda tajam. Hasil audit sebaiknya tidak hanya digunakan sebagai penilaian administratif, tetapi juga dikembalikan kepada petugas sebagai umpan balik untuk memperbaiki praktik pelayanan dan meningkatkan budaya keselamatan kerja. (CDC, 2024), (Kemenkes, 2020)

Supervisi klinik penting untuk memastikan bidan baru, mahasiswa, atau tenaga pendukung memahami dan menerapkan pencegahan infeksi dengan benar. Pembinaan perlu membangun budaya keselamatan, yaitu lingkungan kerja yang mendukung pelaporan insiden, pembelajaran dari kesalahan, dan saling mengingatkan dalam suasana yang tidak menyalahkan (CDC, 2024).

Studi nasional pada praktik mandiri bidan menunjukkan bahwa pelaksanaan PPI dalam pelayanan kesehatan reproduksi masih memerlukan penguatan melalui pengelolaan lingkungan, supervisi, dan audit mutu berkelanjutan. Oleh karena itu, budaya keselamatan dan audit mutu perlu dipandang sebagai kebutuhan nyata dalam menjaga mutu serta keamanan pelayanan kebidanan, bukan sebagai beban tambahan. (Sulistyorini, 2021)

Tabel 4. 4 Contoh indikator mutu pencegahan infeksi

Indikator	Cara pemantauan	Tujuan
Kepatuhan <i>hand hygiene</i>	Observasi langsung/ <i>checklist</i>	Meningkatkan kepatuhan pada 5 momen
Ketersediaan APD	Pemeriksaan stok berkala	Menjamin kesiapan pelayanan aman
Pengolahan alat	Audit alur alat dan log proses	Mencegah alat tidak aman dipakai ulang
Kebersihan ruang	<i>Checklist</i> harian dan supervisi	Menjaga lingkungan pelayanan tetap aman
Insiden pajanan darah	Pelaporan dan review kasus	Mengurangi cedera kerja dan pembelajaran sistem

K. Studi Kasus dan Refleksi

1. Kasus 1 – Ibu Nifas Demam

Seorang ibu hari ke-4 postpartum datang dengan demam 38,8°C, lochea berbau, dan nyeri perut bawah. Saat persalinan, ibu mengalami ketuban pecah lama dan dilakukan beberapa kali pemeriksaan vaginal. Kasus ini menggambarkan kombinasi faktor risiko postpartum infection yang perlu diidentifikasi dan ditangani cepat. Faktor risiko infeksi apa yang tampak pada kasus ini?

- Tindakan pencegahan apa yang seharusnya diperkuat pada saat intrapartum?
- Tanda apa yang mengarahkan kecurigaan ke maternal sepsis?
- Kapan ibu harus dirujuk?

2. Kasus 2 – Bayi Baru Lahir dengan Tanda Infeksi

Bayi usia 5 hari tampak malas menyusui, suhu tidak stabil, dan pangkal tali pusat kemerahan dengan sekret. Keluarga mengoleskan ramuan tradisional pada stump tali pusat. Kasus ini menggambarkan tanda bahaya infeksi neonatal dan pentingnya perawatan tali pusat yang aman.

- Tanda bahaya apa yang terlihat pada bayi?
- Bagaimana edukasi perawatan tali pusat yang benar?
- Langkah awal apa yang harus dilakukan bidan?

3. Kasus 3 – Pajanan Darah pada Petugas

Seorang bidan tertusuk jarum setelah pemberian obat injeksi karena jarum tidak segera dibuang ke safety box. Bidan sedang terburu-buru karena ruang persalinan sedang sibuk. Kasus ini menunjukkan risiko pajanan kerja akibat pengelolaan benda tajam yang tidak aman.

- Di mana letak kesalahan prosedur?
- Apa langkah awal pascapajanan yang harus dilakukan?
- Sistem apa yang perlu diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang?

L. Penutup

Pencegahan infeksi merupakan fondasi keselamatan ibu dan bayi dalam praktik kebidanan. Infeksi maternal dan neonatal masih menjadi penyebab penting kematian dan kesakitan, namun sebagian besar dapat dicegah melalui kebersihan tangan, penggunaan APD sesuai risiko, teknik aseptik, pemrosesan alat yang benar, pengelolaan lingkungan, dan edukasi yang memadai. Prinsip dasar pencegahan infeksi adalah memutus rantai penularan. Dalam praktik kebidanan, hal ini harus diterapkan pada semua tahap pelayanan—antenatal, persalinan, nifas, dan neonatal. Penerapan kewaspadaan standar tidak boleh bergantung pada dugaan status infeksi.

pasien, karena setiap asuhan berpotensi menimbulkan pajanan. Bab ini juga menegaskan bahwa pencegahan infeksi tidak berhenti pada tindakan individu. Dibutuhkan audit mutu, supervisi, SOP tertulis, pelaporan insiden, dan budaya keselamatan agar praktik yang aman dapat terjaga secara konsisten.

Pesan Kunci Bab

- a. Kebersihan tangan adalah intervensi paling sederhana dan paling penting.
- b. Gunakan kewaspadaan standar pada semua pasien.
- c. Teknik aseptik harus diterapkan bahkan pada tindakan yang tampak rutin.
- d. Alat yang terlihat bersih belum tentu aman bila belum diproses dengan benar.
- e. Edukasi keluarga adalah bagian dari pencegahan infeksi.
- f. Audit mutu dan budaya keselamatan menentukan konsistensi praktik.

Referensi

- Marshall, J. R. (2020). *Myles textbook for Midwives (17th ed)*. Amsterdam, Belanda: Elsevier.
- Philippi, J, K. G. (2023). *Varney's Midwifery (7th ed)*. Burlington: Jones & Bartlett Learning.
- WHO. (2021). *Infection Prevention and Control in Maternal and Neonatal Care: Module 1*. Geneva: World Health Organization.
- WHO. (2017). *Recommendations for prevention and treatment of maternal peripartum infections*. Geneva: World Health Organization.
- CDC. (2024). *CDC's Core Infection Prevention and Control Practices for Safe Healthcare Delivery in All Settings*. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention.
- WHO. (2021). *Infection prevention and control in maternal and neonatal care: Module 1*. . Geneva: World Health Organization.
- Wilson, J. (2018). *Infection Control in Clinical Practice Updated Edition (3rd ed)*. Amsterdam, Belanda: Elsevier.
- Manaf. S.A, F. N. (2025). *Buku Ajar Ketrampilan Dasar Praktik Kebidanan*. Cilacap, Jawa Tengah: PT. MEDIA PUSTAKA INDO.
- Virly Isella, I. W. (2023). Hubungan bayi berat lahir rendah dan prematuritas dengan kejadian sepsis neonatorum di RSUD Wangaya, Denpasar, Bali, Indonesia. *Intisari Sains Medis*, 5-9.
- Ferreira RC, M. R. (2014). Neonatal sepsis as a risk factor for neurodevelopmental changes in preterm infants with very low birth weight. *J Pediatr (Rio J)*, 293-299.
- IM, K. (2011). Incidence and Factors Associated With Mortality of Neonatal Sepsis. *Paediatrica Indonesiana*, 144-148. .
- Kuti BP, O. T. (2023). Hand hygiene for the prevention of infections in neonates. *Cochrane Library*, 1-56.
- M. Ernawati, N. J. (2021). Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Perawat Dalam Pelaksanaan Hand Hygiene Sebelum Tindakan Keperawatan di BLUD RS Konawe Utara,. *Keperawatan Univ. Muhammadiyah*, 8-16.

- Gon, G. d. (2020). Birth attendants' hand hygiene compliance in healthcare facilities in low- and middle-income countries: A systematic review. *BMC Health Services Research*.
- de Barra, M. G.-K. (2021). Understanding infection prevention behaviour in maternity wards: A mixed-methods analysis of hand hyg. *Social Science & Medicine*.
- Neila Fauzia, A. A. (2014). Kepatuhan Standar Prosedur Operasional Hand Hygiene pada Perawat di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*.
- Nurhayati SH, S. R. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Penggunaan Alat pelindung Diri Pada Bidan Saat Melakukan Pertolongan Persalinan Normal. . *Universitas Lampung Mangkurat*.
- Maharani, R. (2022). Perilaku bidan dalam penatalaksanaan pencegahan infeksi terhadap kejadian infeksi pada pertolongan persalinan di wilayah kerja Puskesmas Natam Kutacane. *Excellent Midwifery Journal*, 27-37.
- Liu, G. L. (2023). Different methods of vaginal preparation before cesarean delivery to prevent postoperative infection: A systematic review and network meta-analysis. *American Journal of Obstetrics & Gynecology MFM*.
- Kuti, B. P. (2023). Hand hygiene for the prevention of infections in neonatus. . *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Singh, M. A. (2022). Neonatal sepsis. *StatPearls Publishing*.
- WHO. (2021). *WHO recommendation on prophylactic antibiotics for women undergoing caesarean section*. . Geneva: World Health Organization.
- Smaill, F. M. (2014). Antibiotic prophylaxis versus no prophylaxis for preventing infection after cesarean section. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Martin, E. K. (2018). Best practice perioperative strategies and surgical techniques for preventing caesarean section surgical site infections: A systematic review of. *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*.
- WHO. (2018). *WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth*. Geneva: World Health Organization.
- Kakolwa, M. A. (2021). Overuse of antibiotics in maternity and neonatal wards, a descriptive report from public hospitals in Dar es Salaam, Tanzania. Antimicrobial Resistance & Infection Control. *Antimicrobial Resistance & Infection Control*.

- Kemenkes. (2020). *Pedoman Teknis Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- WHO. (2017). *WASH in health care facilities: Links with the Network for Improving Quality of Care for Maternal, Newborn and Child Health*. . Geneva: World Health Organization.
- WHO. (2013). *WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn*. Geneva: orld Health Organization.
- Sulistyorini, E. M. (2021). Implementasi pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) pada praktik mandiri bidan (PMB) dalam pelayanan kesehatan reproduksi pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 119–134.

Glosarium

A

Antenatal

Masa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama kehamilan sebelum proses persalinan.

Antibiotik profilaksis

Pemberian antibiotik sebelum tindakan tertentu, misalnya seksio sesarea, untuk mencegah terjadinya infeksi pascaoperasi.

Antisepsis

Penggunaan bahan kimia pada jaringan hidup, seperti kulit atau mukosa, untuk menurunkan jumlah mikroorganisme.

APD / Alat Pelindung Diri

Perlengkapan yang digunakan tenaga kesehatan untuk melindungi diri dari paparan darah, cairan tubuh, sekret, atau bahan infeksius lainnya.

Asepsis

Upaya untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke area tubuh, alat, atau lingkungan yang harus tetap bersih atau steril.

Audit mutu

Kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kepatuhan prosedur pelayanan, seperti hand hygiene, penggunaan APD, pengolahan alat, dan kebersihan lingkungan.

B

Bayi Berat Lahir Rendah / BBLR

Bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram dan memiliki risiko lebih tinggi mengalami infeksi serta komplikasi neonatal.

Budaya keselamatan

Kebiasaan kerja di fasilitas kesehatan yang mendorong petugas untuk saling mengingatkan, melaporkan insiden, belajar dari kesalahan, dan menjaga keselamatan pasien maupun tenaga kesehatan.

Bundle

Sekumpulan praktik berbasis bukti yang diterapkan secara bersama-sama untuk meningkatkan hasil pelayanan dan menurunkan risiko infeksi.

D

Dekontaminasi

Proses awal untuk mengurangi kontaminasi pada alat atau permukaan sebelum dilakukan pencucian, disinfeksi, atau sterilisasi.

Disinfeksi

Proses membunuh sebagian besar mikroorganisme patogen pada benda mati, tetapi tidak selalu memusnahkan spora.

Disinfeksi Tingkat Tinggi / DTT

Proses disinfeksi yang digunakan untuk alat semikritis yang bersentuhan dengan mukosa atau kulit tidak utuh.

E

Endometritis

Infeksi atau peradangan pada lapisan dalam rahim yang dapat terjadi setelah persalinan atau tindakan obstetri.

H

Hand hygiene / Kebersihan tangan

Tindakan membersihkan tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau handrub berbasis alkohol untuk mencegah penularan mikroorganisme.

Health Care-Associated Infection / HAI

Infeksi yang terjadi selama pasien menerima pelayanan kesehatan dan tidak sedang diderita saat pasien pertama kali datang.

High-Level Disinfection / HLD

Istilah lain dari disinfeksi tingkat tinggi, yaitu proses pemusnahan sebagian besar mikroorganisme pada alat semikritis.

I

ICRA / Infection Control Risk Assessment

Penilaian risiko infeksi secara sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi risiko penularan infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan.

Infeksi neonatal

Infeksi yang terjadi pada bayi baru lahir, seperti sepsis neonatal, pneumonia, meningitis, atau omfalitis.

Injeksi aman

Praktik pemberian suntikan dengan prinsip satu jarum, satu spuit, satu pasien, dan satu kali pakai.

K

Ketuban pecah lama

Kondisi ketika selaput ketuban pecah dalam waktu lama sebelum persalinan, biasanya lebih dari 18 jam, sehingga meningkatkan risiko infeksi pada ibu dan bayi.

Kewaspadaan standar

Praktik pencegahan infeksi yang harus diterapkan pada semua pasien tanpa memandang status infeksi.

L

Linen terkontaminasi

Kain, sprei, atau bahan tekstil pelayanan kesehatan yang terkena darah, cairan tubuh, atau bahan infeksius.

M

Maternal sepsis

Kondisi infeksi berat pada ibu selama kehamilan, persalinan, pascaaborsi, atau masa nifas yang dapat menyebabkan gangguan organ dan kematian bila tidak ditangani segera.

N

Neonatus

Bayi baru lahir sampai usia 28 hari.

O

Omfalitis

Infeksi pada tali pusat bayi baru lahir yang dapat ditandai dengan kemerahan, bengkak, sekret, atau nanah di sekitar pangkal tali pusat.

P

Pemeriksaan vaginal

Pemeriksaan jalan lahir melalui vagina untuk menilai kemajuan persalinan atau kondisi obstetri tertentu.

Pemrosesan alat

Rangkaian kegiatan pengolahan alat kesehatan setelah digunakan, mulai dari dekontaminasi, pencucian, pembilasan, pengeringan, disinfeksi atau sterilisasi, hingga penyimpanan.

Pencegahan dan Pengendalian Infeksi / PPI

Serangkaian upaya untuk mencegah dan meminimalkan kejadian infeksi pada pasien, tenaga kesehatan, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan.

Perawatan tali pusat bersih dan kering

Prinsip perawatan tali pusat bayi baru lahir dengan menjaga tali pusat tetap bersih, kering, dan tidak diberi bahan yang tidak steril.

Postpartum

Masa setelah persalinan atau masa nifas.

Povidone-iodine

Bahan antiseptik yang digunakan untuk menurunkan jumlah mikroorganisme pada kulit atau mukosa sebelum tindakan tertentu.

Prematur

Bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu dan memiliki risiko lebih tinggi mengalami infeksi.

R

Rantai penularan infeksi

Urutan proses terjadinya infeksi yang meliputi agen infeksius, reservoir, pintu keluar, cara transmisi, pintu masuk, dan pejamu rentan.

Reservoir

Tempat hidup atau sumber mikroorganisme, seperti darah, sekret, cairan tubuh, tangan petugas, alat medis, linen, atau permukaan lingkungan.

S

Safety box

Wadah khusus tahan tusuk yang digunakan untuk membuang jarum, spuit, atau benda tajam bekas pakai.

Sekret

Cairan yang keluar dari tubuh, misalnya lendir atau cairan dari saluran reproduksi, saluran napas, atau luka.

Seksio sesarea

Tindakan persalinan melalui pembedahan dengan membuat sayatan pada dinding perut dan rahim.

Sepsis neonatal

Infeksi berat pada bayi baru lahir yang dapat ditandai dengan gejala tidak spesifik seperti malas menyusu, suhu tidak stabil, lemah, napas cepat, atau kejang.

Sharps

Benda tajam medis, seperti jarum, pisau bedah, atau ampul pecah, yang dapat menyebabkan luka tusuk atau pajanan darah.

SOP / Standar Operasional Prosedur

Panduan tertulis yang mengatur langkah-langkah kerja agar pelayanan dilakukan secara aman, konsisten, dan sesuai standar.

Sterilisasi

Proses penghancuran seluruh bentuk mikroorganisme, termasuk spora, pada alat kesehatan.

Surveillance / Surveilans

Pengumpulan, analisis, dan pemantauan data kejadian infeksi secara berkelanjutan untuk mendukung perbaikan mutu layanan.

T

Teknik aseptic

Metode kerja untuk menjaga agar tindakan klinik tidak menjadi jalur masuk mikroorganisme ke tubuh pasien.

V

Vaginal preparation

Persiapan vagina menggunakan antiseptik sebelum tindakan tertentu, misalnya sebelum seksio sesarea, untuk menurunkan risiko infeksi pascaoperasi.

W

WASH / Water, Sanitation, and Hygiene

Komponen air bersih, sanitasi, dan kebersihan yang diperlukan untuk mendukung pencegahan infeksi di fasilitas kesehatan.

BAB 5

MANAJEMEN RISIKO DALAM PRAKTIK MANDIRI BIDAN

A. Pendahuluan

Manajemen risiko merupakan suatu proses yang sistematis, yang mencakup pengidentifikasian, penilaian, dan penetapan prioritas risiko. Proses ini bertujuan untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Salah satu tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk mengidentifikasi potensi risiko yang mungkin muncul dalam lingkungan kesehatan, dengan harapan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan dan risiko lainnya yang dapat membahayakan pasien. Proses ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap potensi risiko, pengembangan rencana mitigasi, serta pelaksanaan langkah-langkah preventif. Selain itu, proses ini juga mencakup pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa strategi yang diimplementasikan efektif dalam mengurangi risiko. Manajemen risiko berperan krusial dalam menjaga kualitas pelayanan dan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Menciptakan kepercayaan di antara pasien dan masyarakat, serta meningkatkan hasil kesehatan secara keseluruhan (Wahyuningsih et al., 2024).

Dalam perannya sebagai salah satu tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan, bidan memiliki tanggung jawab khusus dalam memberikan layanan kesehatan, terutama dalam bidang kesehatan ibu dan anak (KIA). Oleh karena itu, penting bagi bidan untuk memiliki kompetensi yang memadai agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Pendekatan manajerial ini mencakup pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan kebidanan yang dilakukan. Dengan demikian, diharapkan bidan dapat memberikan pelayanan yang tidak hanya memenuhi standar kesehatan, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan pasien, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Pengetahuan dan sikap bidan sangat penting dalam penerapan manajemen risiko. Bidan yang memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen risiko persalinan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat, oleh karena itu, Analisis mengenai sejauh mana pengetahuan dan sikap bidan dalam mengaplikasikan manajemen risiko sangat dibutuhkan untuk memastikan pelayanan yang optimal bagi ibu dan bayi (Saleh et al., 2023).

Bidan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya di daerah dengan akses terbatas ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Praktik mandiri bidan menjadi pilihan utama masyarakat dalam memperoleh layanan antenatal, persalinan, dan postnatal yang terjangkau dan berkualitas.

Risiko klinis meliputi komplikasi persalinan, sedangkan risiko non-klinis mencakup kesalahan komunikasi, keterbatasan alat, dan kegagalan sistem yang harus dikelola secara proaktif.

Angka Kematian Ibu (AKI) masih menjadi salah satu indikator penting dalam menilai derajat kesehatan suatu negara. World Health Organization (WHO) melaporkan pada tahun 2023, Sekitar 287.000 perempuan meninggal selama kehamilan dan persalinan. Berdasarkan data tersebut, 94% kematian terjadi di negara berkembang, dimana sebagian besar kematian ini sebenarnya dapat dicegah melalui manajemen risiko yang tepat dan penanganan komplikasi yang adekuat (WHO, 2023).

Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam menurunkan AKI. Data Kementerian Kesehatan RI tahun 2023 menunjukkan AKI sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih jauh dari target Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030. Penyebab utama kematian ibu di Indonesia meliputi perdarahan (28%), hipertensi dalam kehamilan (24%), infeksi (11%), komplikasi persalinan (11%), dan penyebab tidak langsung lainnya (26%), dari banyaknya kasus penyebab kematian tersebut maka pentingnya penerapan manajemen risiko untuk mengidentifikasi, menilai, dan menetapkan prioritas risiko (Kemenkes RI, 2023).

Provinsi Jawa Timur mencatat AKI sebesar 89,81 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2023, dengan Kota Surabaya menyumbang angka yang signifikan. Data Dinas Kesehatan Kota Surabaya menunjukkan bahwa pada tahun 2023, dari total persalinan yang terjadi di Surabaya, 30% dilakukan di Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB). Data surveilans menunjukkan bahwa 15% dari kasus kematian ibu terjadi di TPMB, dengan penyebab utama keterlambatan deteksi risiko dan penanganan komplikasi, salah satu cara yang diutamakan adalah penerapan manajemen risiko dalam persalinan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi faktor risiko yang dapat menyebabkan komplikasi selama proses kelahiran atau persalinan (Dinkes Surabaya, 2023).

Berdasarkan Penelitian (Edozien, 2017), menyimpulkan bahwa penerapan kerangka kerja Radical, yang mencakup peningkatan kesadaran, desain untuk keselamatan, keterlibatan pengguna, pengumpulan data, serta pembelajaran dari insiden, dapat secara signifikan mengurangi risiko selama proses intrapartum dan

meningkatkan keselamatan ibu dan bayi dengan SOP yang terintegrasi serta pelatihan berbasis bukti bagi tenaga kesehatan. Penelitian lain oleh (Halimatussakdiah, 2019), menyimpulkan juga bahwa sebagian besar fungsi manajemen dari aspek perencanaan persalinan berada pada kategori efektif (66,7%), pengorganisasian persalinan berada pada kategori efektif (72,7%), penggerakan dan pelaksanaan persalinan berada pada kategori efektif (54,5%), pengawasan dan pengendalian persalinan berada pada kategori efektif (63,6%) dan fungsi manajemen persalinan berada pada kategori efektif sebanyak 19 responden (57,6%). Oleh karena dari itu, pentingnya implementasi

Manajemen resiko persalinan untuk menurunkan AKI, Penelitian sebelumnya dilakukan di lingkungan rumah sakit dan klinik, selain itu penelitian sebelumnya cenderung fokus pada faktor individual (seperti implementasi

manajemen resiko persalinan) tanpa menggabungkan dengan pengetahuan dan sikap bidan, dengan demikian belum adanya penelitian yang secara khusus mengukur tingkat pengetahuan dan sikap bidan terhadap implementasi manajemen risiko dalam persalinan.

Pelayanan kesehatan (medis) termasuk praktik bidan merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan Bidan dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha yang membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh pengguna layanan Bidan praktik, dan supaya sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki Bidan praktek. Hal ini dikarenakan terkait dengan masalah reproduksi di Indonesia yang mempunyai dua laten yaitu kematian Ibu dan kematian Bayi. Bidan berperan membantu menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, sehingga Bidan harus bekerja secara profesional sesuai standar profesi, standar kompetensi, dan kode etik yang berlaku sehingga terhindar dari perbuatan melawan hukum.

Praktik mandiri bidan merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang memiliki peran strategis dalam upaya peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak. Bidan sebagai tenaga kesehatan profesional memiliki kewenangan dalam memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif, mulai dari masa prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, hingga pelayanan kesehatan reproduksi perempuan.

Dalam pelaksanaan praktik mandiri, bidan dihadapkan pada berbagai situasi klinis yang kompleks dan berpotensi menimbulkan risiko, baik bagi pasien maupun bagi bidan itu sendiri. Risiko tersebut dapat berupa kesalahan dalam pengambilan

keputusan klinis, keterlambatan dalam penanganan komplikasi, ketidaksesuaian dengan standar operasional prosedur (SOP), serta risiko hukum akibat kelalaian atau malpractice.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan, aspek keselamatan pasien (*patient safety*) menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko dalam praktik mandiri bidan menjadi sangat penting. Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko guna meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi.

Penerapan manajemen risiko tidak hanya bertujuan untuk melindungi pasien dari kejadian yang tidak diharapkan (*adverse events*), tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga profesionalisme bidan, serta memberikan perlindungan hukum dalam praktik kebidanan. Dengan demikian, pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko sangat diperlukan oleh setiap bidan dalam menjalankan praktik mandiri secara aman, efektif, dan sesuai dengan standar profesi.

B. Definisi Manajemen Risiko Klinis dalam Kebidanan

Manajemen risiko klinis adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan memitigasi potensi bahaya dalam pelayanan kesehatan demi meningkatkan keselamatan pasien. Tujuan utamanya adalah meningkatkan keselamatan pasien dan mengurangi insiden yang tidak diinginkan. Implementasinya merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, yang menjadi landasan hukum bagi seluruh aktivitas bidan di Indonesia.



Gambar 5. 1 manajemen risiko

Ketiga tahap ini membentuk siklus yang berkelanjutan dan harus diintegrasikan dalam setiap aspek pelayanan kebidanan sehari-hari.

C. Identifikasi Risiko dalam Praktik Mandiri Bidan

Identifikasi risiko merupakan langkah pertama dan paling fundamental dalam manajemen risiko. Bidan harus mampu mengenali berbagai potensi bahaya yang spesifik dalam setiap tahapan pelayanan kebidanan.

1. Risiko Kehamilan

Usia ibu ekstrem, riwayat medis buruk, kondisi janin tidak normal, anemia, hipertensi gestasional

2. Risiko Persalinan

Letak sungsang, distosia, perdarahan antepartum, tali pusat menumbung, rupture uteri

3. Risiko Bayi Baru Lahir

Asfiksia neonatorum, hipotermia, infeksi neonatal, BBLR, kelainan kongenital.

4. Risiko Pascapersalinan

Perdarahan postpartum, infeksi nifas, trombosis, depresi pascapersalinan.

D. Studi Kasus Persalinan Letak Sungsang

Angka kematian prenatal pada persalinan letak sungsang berkisar 16,8–38,5% di Indonesia — salah satu risiko tertinggi yang dihadapi bidan praktik mandiri. Persalinan letak sungsang merupakan salah satu kondisi paling kritis yang dapat terjadi di praktik mandiri bidan. Bidan wajib memahami batas kewenangannya dengan sangat jelas, karena tindakan persalinan letak sungsang yang dilakukan di luar kewenangan dapat berujung pada konsekuensi serius

1. Sanksi Administratif Pencabutan izin praktik dan penghentian operasional.

2. Sanksi Pidana

Proses hukum atas kelalaian medis yang mengakibatkan kematian.

3. Sanksi Perdata

Gugatan ganti rugi dari keluarga pasien yang dirugikan.

E. Asuhan Keperawatan Penilaian Risiko dan Seberapa Besar Potensinya

Setelah risiko teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah menilai seberapa besar potensi dampaknya. Penilaian dilakukan berdasarkan dua dimensi utama: probabilitas (kemungkinan kejadian) dan dampak (keparahan konsekuensi).



Gambar 5. 2 diagram analisis SWOT

Contoh praktis: Penilaian risiko perdarahan pascapersalinan mempertimbangkan riwayat perdarahan sebelumnya, jumlah paritas, kondisi plasenta, dan durasi persalinan sebagai faktor penentu kategori risiko.

Mitigasi Risiko Strategi Pencegahan dan Penanganan

1. Strategi Proaktif
 - a. Pelatihan rutin pembaruan pengetahuan
 - b. Kepatuhan standar klinis dan kode etik
 - c. Komunikasi tim yang efektif
 - d. Pemeriksaan antenatal komprehensif
 - e. Pemeliharaan peralatan secara berkala
2. Strategi Reaktif
 - a. Penanganan komplikasi sesuai protap
 - b. Rujukan tepat waktu ke faskes lebih tinggi
 - c. Dokumentasi insiden yang akurat
 - d. Tindak lanjut pasca-insiden
 - e. Evaluasi dan perbaikan prosedur

F. Peran Bidan Delima Dalam Manajemen Risiko

Program Bidan Delima merupakan ikon praktik mandiri bidan yang mengedepankan mutu layanan dan standar profesionalisme. Keanggotaan organisasi penting, namun pengembangan diri yang aktif dan konsisten tetap menjadi kunci utama keberhasilan manajemen risiko.

Manajemen risiko harus diintegrasikan secara mulus dalam setiap tahapan asuhan kebidanan, bukan diperlakukan sebagai prosedur terpisah. Pendekatan ini memastikan keselamatan pasien terjaga di setiap titik kontak pelayanan.

1. Kehamilan : Skrining risiko, ANC terpadu, konseling komprehensif
2. Persalinan : Pemantauan partograf, kesiapan emergensi, informed consent
3. Nifas: Pemantauan perdarahan, infeksi, laktasi, dan psikologis ibu
4. Bayi Baru Lahir: Resusitasi siaga, penilaian APGAR, skrining neonatal

Dokumentasi SOAP (Subjektif, Objektif, Analisa, Penatalaksanaan) menjadi instrumen kunci dalam mengelola setiap interaksi klinis secara terstruktur dan akuntabel. (Nursyahri Sapriani & Selia Juita, 2023)

G. Studi Kasus Asuhan Kebidanan Komprehensif

Pelaksanaan asuhan kebidanan secara continuity of care di praktik mandiri bidan memberikan gambaran nyata tentang pentingnya manajemen risiko berkelanjutan. Studi menunjukkan bahwa ibu dan bayi dapat berada dalam keadaan normal jika asuhan dilaksanakan sesuai standar.

Hasil Positif yang Dicapai

- a. Ibu dan bayi dalam kondisi normal pascapersalinan
- b. Tidak ada komplikasi serius yang terlewat
- c. Dokumentasi asuhan yang terstruktur
- d. Kepuasan pasien dan keluarga terjaga

Kesenjangan dengan Teori

- a. Ketidakesesuaian prosedur di beberapa Langkah
- b. Pencatatan yang belum optimal
- c. Perlu peningkatan koordinasi rujukan
- d. Keterbatasan fasilitas pendukung

Studi ini menekankan bahwa pelayanan yang baik saja belum cukup — kepatuhan terhadap standar dan teori harus selalu menjadi acuan utama. (Nursyahri Sapriani & Selia Juita, 2023).

Tantangan Dalam Implementasi Manajemen Risiko

1. Budaya Pelaporan Lemah : Kurangnya budaya pelaporan insiden membuat pembelajaran dari kesalahan sulit dilakukan. Banyak bidan enggan melaporkan insiden karena takut sanksi.
2. Keterbatasan Sumber Daya: Dana operasional terbatas, peralatan medis yang belum memadai, serta minimnya tenaga pendukung menjadi hambatan nyata di lapangan.

3. Kebutuhan Pelatihan Berkelanjutan: Ilmu kebidanan terus berkembang, sehingga bidan membutuhkan akses pelatihan yang konsisten namun seringkali terhambat biaya dan waktu.
4. Jiwa Kewirausahaan: Mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan manajerial sambil tetap fokus pada kualitas klinis menjadi tantangan tersendiri bagi bidan mandiri.

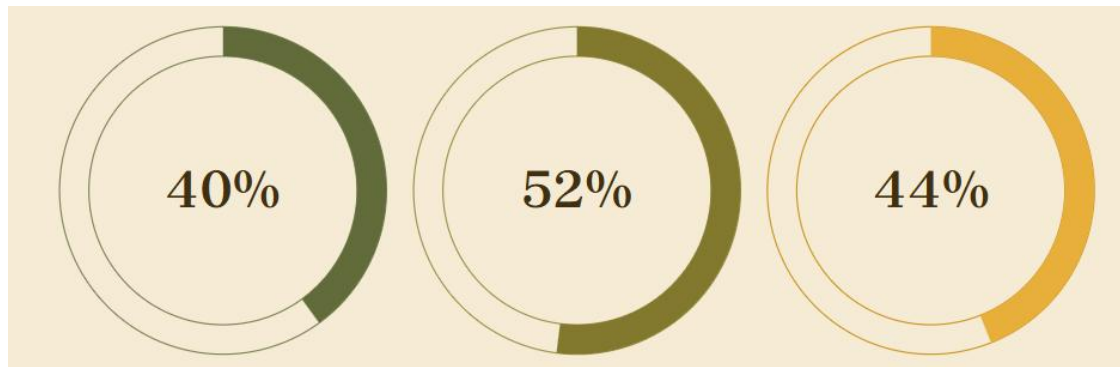
Organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI) memainkan peran vital dalam memastikan standar praktik mandiri bidan terjaga dan terus berkembang. Komitmen pimpinan dan partisipasi aktif seluruh staf kebidanan menjadi fondasi sistem pembinaan yang efektif.

1. Komitmen Pimpinan : Dukungan aktif dari pengurus organisasi profesi dalam menetapkan dan menegakkan standar.
2. Pengawasan Berkelanjutan: Monitoring rutin terhadap praktik mandiri untuk memastikan kepatuhan standar pelayanan
3. Konseling dan Bantuan: Memberikan dukungan teknis, psikologis, dan administratif kepada bidan yang menghadapi kesulitan. (Yully Asmariana & U. Evi Nasla, 2025)

Bidan harus bertindak sesuai kewenangan, kemampuan, pendidikan, dan pengalaman yang dimilikinya — tidak lebih, tidak kurang. Kewenangan bidan diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Tindakan kebidanan wajib sesuai dengan prosedur tetap (protap) dan standar profesi yang berlaku. Pemahaman mendalam tentang batas kewenangan ini adalah elemen inti manajemen risiko hukum bagi bidan.

1. Kenali Batas Kewenangan: Pahami dengan baik tindakan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku
2. Patuhi Protap dan Standar: Setiap tindakan harus mengikuti prosedur tetap yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi dan Kementerian Kesehatan
3. Waspada Konsekuensi Pelanggaran: Pelanggaran kewenangan dapat berujung pada sanksi administratif, pidana, dan perdata yang merugikan karier dan kehidupan bidan.

Penelitian di wilayah Surabaya Selatan memberikan gambaran kuantitatif yang kuat tentang kondisi nyata implementasi manajemen risiko di kalangan bidan praktik mandiri. Temuan ini menjadi dasar penting untuk merancang intervensi yang tepat sasaran.



Gambar 5. 3 implementasi manajemen risiko

1. 40 % Pengetahuan Cukup Bidan dengan pengetahuan manajemen risiko pada kategori cukup
2. 52 % Sikap Baik Bidan dengan sikap positif terhadap penerapan manajemen risiko
3. 44 % Implementasi Baik Bidan yang menerapkan manajemen risiko dengan baik dalam praktik

Korelasi signifikan ditemukan: pengetahuan implementasi ($r=0.693$, $p<0.001$) dan sikap implementasi ($r=0.582$, $p=0.002$). (Marsheila Salvinia Amanitia Setiawan et al., 2025)

H. Inovasi dan Strategi dalam Praktik Kebidanan

Penerapan kerangka manajemen risiko klinis secara proaktif merupakan langkah inovatif yang membedakan bidan unggul dari yang biasa. Inovasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang pola pikir dan sistem kerja yang lebih cerdas.

1. Penerapan Kerangka Proaktif : Mengadopsi kerangka manajemen risiko klinis yang terstruktur sebelum masalah terjadi.
2. Peningkatan Kepatuhan Standar: Menerapkan checklist dan protokol berbasis bukti untuk setiap prosedur klinis
3. Perbaikan Komunikasi Tim: Membangun sistem komunikasi yang jelas antara bidan, pasien, keluarga, dan fasilitas rujukan.

Setiap tindakan bidan, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks, harus selalu berlandaskan pada satu prinsip utama: keselamatan ibu dan bayi di atas segalanya.

Setiap tindakan bidan mengandung dimensi hukum dan etik yang tidak dapat diabaikan. Kesadaran akan tanggung jawab hukum bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mendorong praktik yang lebih hati-hati, terstandar, dan bertanggung jawab

1. Tanggung Jawab Klinis: Bidan bertanggung jawab penuh atas setiap Tindakan medis yang dilakukannya, termasuk keputusan untuk merujuk atau tidak merujuk
2. Sanksi Hukum: Pelanggaran dapat berujung pada sanksi administratif (pencabutan izin), pidana (kelalaian), dan perdata (ganti rugi).
3. Kode Etik Kebidanan: Kode etik profesi menjadi panduan moral yang mengatur hubungan bidan dengan pasien, sesama profesi, dan masyarakat luas.

Analisis yuridis normatif terhadap kasus ini menegaskan konsekuensi hukum yang berat bagi bidan yang melakukan tindakan di luar batas kewenangannya. Studi ini menganalisis secara mendalam implikasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010 dalam konteks persalinan letak sungsang yang ditangani oleh bidan praktik mandiri. Kasus ini menjadi preseden penting dalam dunia hukum kesehatan Indonesia

1. Kewenangan yang Jelas: Regulasi menetapkan secara eksplisit kondisi-kondisi di mana bidan boleh dan tidak boleh melakukan Tindakan persalinan tanpa supervise dokter.
2. Prinsip Perlindungan Pasien: Hukum kesehatan Indonesia memberikan perlindungan kuat kepada pasien dan keluarga untuk menuntut pertanggungjawaban atas kelalaian medis.
3. Pelajaran untuk Semua Bidan: Kasus ini menjadi pengingat bahwa merujuk tepat waktu adalah tindakan profesional dan berani, bukan tanda kelemahan

I. Peningkatan Kualitas Pelayanan Melalui Manajemen Risiko

Manajemen risiko yang diterapkan dengan baik bukan hanya mencegah kejadian buruk — ia secara aktif meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan secara keseluruhan. Dampak positifnya dirasakan oleh pasien, keluarga, bidan, dan masyarakat luas.

1. Luaran Kesehatan Lebih Baik : Angka komplikasi ibu dan bayi menurun secara signifikan Ketika manajemen risiko diterapkan secara konsisten dan sistematis
2. Kepercayaan Masyarakat Meningkat : Praktik yang aman dan transparan membangun reputasi positif bagi bidan, menarik lebih banyak pasien dan memperkuat posisinya di komunitas.
3. Standar Pelayanan Meningkat: Evaluasi berkelanjutan mendorong perbaikan prosedur yang pada akhirnya mengangkat standar pelayanan kebidanan secara nasional

Tinjauan literatur komprehensif yang dilakukan oleh Sefentina, Santi Widya Purba, dan May Linda Kristina mengungkap bahwa integrasi proaktif kerangka

manajemen risiko klinis dapat menghasilkan perubahan positif yang terukur dalam pelayanan kebidanan

1. Manfaat Terbukti

- a. Penurunan insiden yang tidak diinginkan
- b. Peningkatan kepatuhan terhadap standar klinis
- c. Perbaikan komunikasi antara anggota tim
- d. Dokumentasi yang lebih akurat dan lengkap

2. Tantangan yang Dihadapi

- a. Kurangnya budaya pelaporan insiden
- b. Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial
- c. Kebutuhan pelatihan yang berkelanjutan
- d. Resistensi terhadap perubahan prosedur

J. Perencanaan Pembukaan Praktik Mandiri Bidan Yang Aman

Mendirikan praktik mandiri bidan membutuhkan perencanaan yang matang dan menyeluruh. Identifikasi risiko harus dimulai sejak tahap perencanaan, jauh sebelum pintu praktik dibuka untuk pasien pertama.

1. Analisis Kebutuhan Wilayah : Kaji kebutuhan layanan kebidanan di calon lokasi, termasuk demografi dan kompetitor yang ada.
2. Pemilihan Lokasi Strategis: Pertimbangkan aksesibilitas, keamanan lingkungan, kedekatan dengan faskes rujukan, dan infrastruktur jalan.
3. Pemenuhan Persyaratan Legal: Lengkapi semua perizinan: STRB, SIPB, izin operasional, dan registrasi di dinas kesehatan setempat
4. Persiapan Sarana dan Prasarana: Siapkan ruang, peralatan, obat-obatan, dan SDM sesuai standar Permenkes yang berlaku

Pengelolaan sumber daya yang efektif adalah tulang punggung manajemen risiko di praktik mandiri bidan. Tanpa sumber daya yang memadai dan terkelola dengan baik, bahkan bidan paling kompeten pun akan kesulitan memberikan pelayanan yang aman

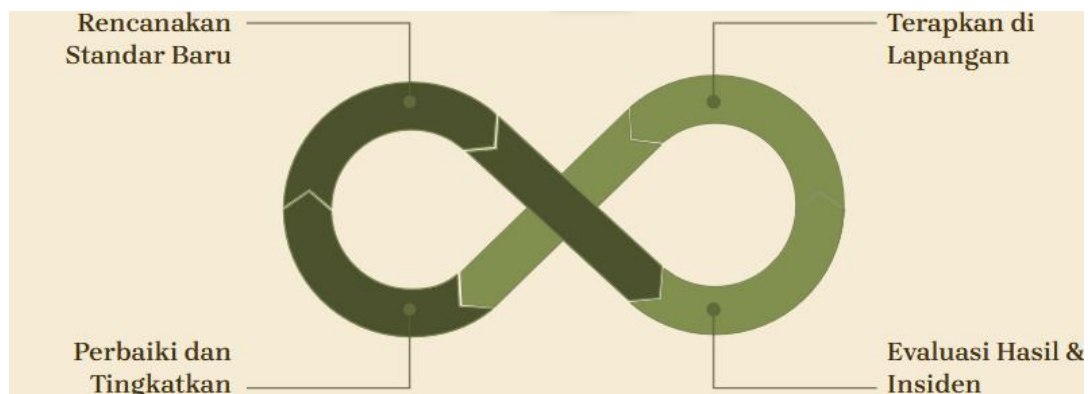
1. Peralatan Medis: Peralatan harus memadai, berfungsi baik, dan menjalani kalibrasi rutin. Buat jadwal pemeliharaan berkala yang terdokumentasi.
2. Obat Esensial & Alkon: Ketersediaan obat-obatan esensial dan alat kontrasepsi harus selalu terjaga. Pantau tanggal kadaluarsa secara rutin.
3. Sistem Pencatatan: Pencatatan dan pelaporan yang tertib merupakan dasar evaluasi mutu dan bukti hukum yang penting bagi perlindungan bidan.

Penetapan biaya pelayanan yang tepat adalah bagian integral dari manajemen praktik yang sehat. Biaya yang terlalu rendah mengancam keberlanjutan praktik,

sementara biaya yang terlalu tinggi menghambat akses masyarakat terhadap layanan berkualitas.

1. **Transparansi:** Penetapan Biaya pelayanan harus dipajang secara terbuka dan dapat diakses oleh seluruh pasien. Tidak ada biaya tersembunyi yang dapat merusak kepercayaan.
2. **Kesesuaian dengan Standar:** Merujuk pada tarif yang ditetapkan oleh Perda, Permenkes, dan kesepakatan organisasi profesi sebagai acuan penetapan biaya
3. **Akuntabilitas Keuangan:** Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel melindungi bidan dari potensi masalah hukum dan menjaga kepercayaan pasien

Manajemen risiko bukan aktivitas satu kali — ia adalah siklus evaluasi dan perbaikan yang tidak pernah berhenti. Pengawasan berkelanjutan memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan benar-benar diterapkan dan secara terus-menerus ditingkatkan.



Gambar 5. 4 siklus perbaikan berkelanjutan

Mekanisme umpan balik dari pasien (melalui kuesioner kepuasan) dan dari staf (melalui rapat rutin) memberikan data berharga untuk pengambilan keputusan berbasis bukti dalam peningkatan mutu pelayanan

Audit internal yang dilakukan secara mandiri dan jujur adalah cermin yang menunjukkan kondisi sesungguhnya dari praktik kebidanan. Bidan yang berani melakukan self-assessment secara berkala adalah bidan yang berkomitmen pada keunggulan pelayanan.

Audit internal yang rutin terbukti mampu mengidentifikasi potensi masalah sebelum berkembang menjadi insiden serius yang membahayakan pasien.

Tidak ada praktik mandiri yang dapat bekerja secara terisolasi. Kemitraan yang kuat dengan fasilitas Kesehatan lain merupakan komponen esensial dari system manajemen risiko yang efektif, khususnya dalam memastikan pasien mendapatkan penanganan yang tepat pada saat yang tepat.

1. **Kemitraan dengan Puskesmas;** Koordinasi program KIA, imunisasi, dan KB. Jalur komunikasi langsung untuk konsultasi kasus sulit.

2. Jejaring dengan Rumah Sakit: Sistem rujukan yang terencana dan terpola, dengan kontak person yang jelas untuk kasus emergensi obstetri.
3. Kolaborasi dengan Laboratorium: Akses cepat ke layanan diagnostik untuk mendukung pengambilan keputusan klinis yang berbasis bukti.

K. Peran Teknologi dalam Manajemen Risiko

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang baru bagi bidan praktik mandiri untuk meningkatkan kualitas layanan dan efektivitas manajemen risiko secara signifikan.

1. Sistem Informasi Kesehatan: Rekam medis elektronik memudahkan akses data pasien, mencegah kesalahan, dan mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih cepat dan tepat.
2. Alat Diagnostik Modern: Doppler genggam, CTG, portabel, dan pulse, oximeter membantu deteksi dini kondisi berisiko sebelum berkembang menjadi komplikasi serius.
3. Akses Informasi Medis: Internet memberikan akses ke panduan klinis terbaru, jurnal ilmiah, dan platform konsultasi daring dengan rekan sejawat dan dokter spesialis.

Adopsi teknologi digital dalam pengelolaan data pasien dan jadwal praktik bukan lagi kemewahan — ini adalah kebutuhan untuk manajemen risiko yang efektif di era modern. Sistem digital membantu bidan mengelola informasi lebih akurat dan efisien. Sistem informasi kesehatan terintegrasi dapat mengurangi risiko kesalahan pencatatan, memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data, dan memperkuat sistem rujukan antar fasilitas Kesehatan

Pasien dan keluarga yang terinformasi dengan baik adalah mitra aktif dalam manajemen risiko, bukan sekadar penerima layanan pasif. Pemberdayaan mereka merupakan komponen vital dalam system keselamatan pasien yang komprehensif.

1. Edukasi Kesehatan Komprehensif: Berikan informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipahami tentang kehamilan, tanda bahaya, persiapan persalinan, dan perawatan bayi kepada ibu dan keluarga
2. Keterlibatan dalam Keputusan: Ajak pasien dan keluarga berdiskusi secara setara dalam setiap pengambilan keputusan medis. Informed consent bukan sekadar formalitas administratif.
3. Kesadaran Manajemen Risiko: Ajarkan pasien untuk mengenali tanda bahaya dan kapan harus mencari pertolongan segera. Pengetahuan ini dapat menyelamatkan nyawa.

L. Manajemen Risiko Dalam Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi

Pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi merupakan bagian integral dari praktik mandiri bidan yang memiliki dimensi risiko tersendiri. Identifikasi dan manajemen risiko yang cermat dalam bidang ini melindungi kesehatan jangka panjang klien

Identifikasi Risiko Kontrasepsi Skrining riwayat kesehatan sebelum pemasangan alkon: kontraindikasi absolut dan relatif harus diketahui dengan baik.

Penanganan Efek Samping Bidan harus mampu mengenali, menangani, dan mendokumentasikan efek samping kontrasepsi dengan tepat sesuai protap.

Konseling Komprehensif Konseling kesehatan reproduksi yang menyeluruh memastikan klien membuat pilihan yang tepat dan informasi yang diterima berbasis bukti.

M.Manajemen Risiko Pada Neonatus dan Bayi

Bayi baru lahir merupakan kelompok paling rentan dalam praktik kebidanan. Manajemen risiko neonatal yang tepat dapat mencegah kecacatan permanen dan kematian yang sesungguhnya dapat dihindari.



Gambar 5. 5 infografis tentang perawatan dan penanganan bayi baru lahir

Pemeriksaan Fisik Bayi Baru Lahir

Pemeriksaan fisik neonatus yang sistematis dan menyeluruh adalah tindakan manajemen risiko terpenting dalam jam pertama kehidupan bayi. Setiap penyimpangan dari normal harus segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

1. Penilaian APGAR : Menit 1 dan 5 setelah lahir
2. Pemeriksaan Antropometri: BB, PB, LK, LD, LILA
3. Pemeriksaan Head-to-Toe: Sistematis dari kepala hingga kaki
4. Skrining Neonatal: Hipotiroid kongenital, PKU, defisiensi G6PD

Manajemen Risiko dalam Situasi Darurat

Kesiapsiagaan menghadapi kegawatdaruratan obstetri dan neonatal adalah aspek terpenting dalam manajemen risiko bidan praktik mandiri. Respons yang tepat dalam hitungan menit dapat membedakan antara hidup dan mati.

1. Pelatihan Simulasi: Latihan simulasi kegawatdaruratan secara rutin — minimal dua kali setahun — membangun muscle memory dan kepercayaan diri dalam menghadapi situasi nyata.
2. Kesiapan Alat & Obat: Peralatan resusitasi, oksitosin, MgSO₄, dan obat-obatan emergensi harus selalu tersedia, berfungsi, dan dalam masa berlaku.
3. Protokol Rujukan Cepat: Nomor kontak rumah sakit rujukan, ambulans, dan prosedur stabilisasi pra-rujukan harus sudah dihafal dan dipraktikkan.

N. Budaya Keselamatan Pasien di Praktik Mandiri Bidan

Pengukuran berkala terhadap pengetahuan dan sikap bidan merupakan langkah kritis untuk memastikan bahwa kompetensi yang dibutuhkan terjaga dan berkembang seiring waktu. Evaluasi yang sistematis menjadi dasar program pengembangan yang tepat sasaran.

Instrumen Kuesioner terstandarisasi digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan bidan tentang konsep dan prosedur manajemen risiko. Dilaksanakan minimal satu kali per tahun. (Marsheila Salvinia Amanitia Setiawan et al., 2025)

Lembar Observasi langsung terhadap praktik klinis memberikan gambaran nyata tentang sejauh mana pengetahuan diterapkan dalam tindakan nyata di lapangan.

Hasil evaluasi harus ditindaklanjuti dengan program pelatihan yang disesuaikan, bukan sekadar didokumentasikan dan disimpan.

Keterbatasan Pengalaman dan Profesionalisme Pengalaman kerja yang masih terbatas merupakan faktor risiko tersendiri dalam praktik kebidanan. Bidan muda yang baru membuka praktik mandiri menghadapi tantangan unik dalam membangun kepercayaan diri klinis sambil mengelola kompleksitas praktik sehari-hari

1. Dampak Keterbatasan Pengalaman
 - a. Kepercayaan diri klinis yang lebih rendah
 - b. Pengambilan keputusan yang lebih lambat
 - c. Potensi peningkatan insiden tidak diinginkan
 - d. Kesulitan menghadapi komplikasi tak terduga
2. Solusi: Program Mentoring
 - a. Pendampingan dari bidan senior berpengalaman
 - b. Supervisi klinis terstruktur berkala
 - c. Diskusi kasus rutin dan refleksi
 - d. Akses ke jaringan konsultasi profesional

O. Peran Organisasi Profesi dalam Mendukung Manajemen Risiko

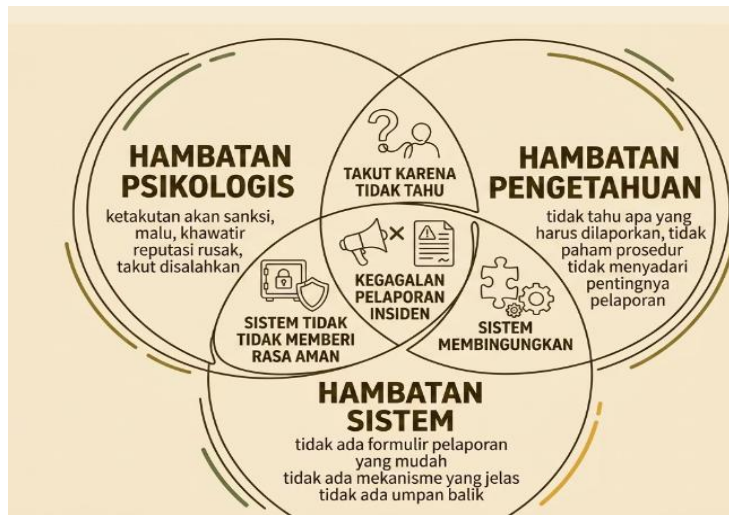
Organisasi profesi kebidanan memiliki peran strategis yang jauh melampaui sekadar administrasi keanggotaan. Mereka adalah pilar utama dalam membangun ekosistem praktik kebidanan yang aman, kompeten, dan terlindungi secara hukum.

Penyediaan Panduan dan Standar Menerbitkan pedoman klinis, SOP, dan panduan praktik berbasis bukti yang menjadi referensi utama bidan dalam pengambilan keputusan.

Penyelenggaraan Pelatihan Mengorganisir program pelatihan, seminar, workshop, dan konferensi ilmiah yang memperbarui kompetensi anggota secara berkelanjutan.

Advokasi dan Dukungan Hukum Memberikan bantuan hukum, advokasi kebijakan, dan perlindungan profesional kepada anggota yang menghadapi tantangan hukum dalam praktik.

Pelaporan insiden adalah mekanisme kunci untuk pembelajaran sistem dan pencegahan pengulangan. Namun, berbagai hambatan psikologis dan struktural membuat praktik ini belum optimal dilaksanakan di banyak praktik mandiri bidan Indonesia.



Gambar 5. 6 diagram Venn

Membangun budaya pelaporan yang positif membutuhkan perubahan paradigma mendasar: dari "pelaporan sebagai ancaman" menjadi "pelaporan sebagai tanggung jawab profesional untuk keselamatan bersama"

Sistem pelaporan insiden yang efektif adalah investasi jangka panjang dalam keselamatan pasien. Setiap laporan yang masuk adalah data berharga yang memungkinkan seluruh komunitas kebidanan belajar dan berkembang bersama

1. Non-Punitif : Pelaporan tidak boleh berujung pada hukuman bagi pelapor yang beritikad baik. Fokus pada pembelajaran, bukan penyalahan.
2. Konfidensial : Identitas pelapor terlindungi untuk mendorong kejujuran dan keterbukaan dalam pelaporan
3. Ditindaklanjuti: Setiap laporan harus mendapatkan respons nyata berupa tindakan perbaikan yang dikomunikasikan kembali ke pelapor.

P. Manajemen Risiko Dalam Konteks Kewirausahaan Kebidanan

Bidan praktik mandiri bukan hanya seorang klinisi — ia juga seorang wirausahawan. Dimensi bisnis praktik mandiri menghadirkan risiko tersendiri yang membutuhkan manajemen yang cerdas dan terencana. (nelly aranda, n.d.)

1. Dimensi Kewirausahaan
 - a. Mengembangkan jiwa kepemimpinan dan manajerial
 - b. Merencanakan investasi sarana dan prasarana
 - c. Membangun brand dan reputasi praktik
 - d. Mengelola hubungan dengan pasien sebagai klien

2. Analisis Lokasi Usaha
 - a. Analisis demografi dan kebutuhan layanan
 - b. Aksesibilitas transportasi dan parkir
 - c. Kedekatan dengan faskes rujukan
 - d. Potensi persaingan dan kolaborasi
 - e. Kondisi keamanan lingkungan sekitar

Q. Pelayanan Yang Di Berikan Bidan Praktik Mandiri

Cakupan pelayanan bidan praktik mandiri sangat luas, mencakup seluruh siklus reproduksi perempuan. Setiap jenis pelayanan memiliki profil risikonya masing-masing yang harus dipahami dan dikelola dengan baik

1. Asuhan Kehamilan: ANC terpadu, skrining risiko, edukasi persiapan persalinan, konseling nutrisi dan gaya hidup sehat.
2. Asuhan Persalinan : Pertolongan persalinan normal, pemantauan partograf, manajemen aktif kala III, asuhan bayi baru lahir.
3. Asuhan Nifas & BBL: Pemantauan pemulihan ibu, dukungan laktasi, perawatan tali pusat, skrining neonatal.
4. Imunisasi & KB: Imunisasi dasar lengkap, konseling dan pelayanan kontrasepsi, deteksi dini kanker serviks.

Transparansi dalam penetapan dan komunikasi biaya pelayanan merupakan bagian dari manajemen risiko non-klinis yang penting. Ketidakjelasan biaya dapat menimbulkan konflik, ketidakpercayaan, dan bahkan tuntutan hukum.

Prinsip Transparansi Daftar tarif dipajang secara terbuka di tempat yang mudah dilihat pasien. Tidak ada biaya kejutan yang dapat merusak kepercayaan dan hubungan terapeutik.

Kesesuaian dengan Standar Tarif merujuk pada standar Perda, Permenkes, dan kesepakatan IBI setempat. Tarif yang wajar menjamin keberlanjutan praktik sekaligus aksesibilitas bagi masyarakat.

Akomodasi Pasien Tidak Mampu Memiliki kebijakan subsidi silang atau rujukan ke faskes dengan jaminan sosial untuk memastikan pelayanan yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Dokumentasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu adalah tulang punggung praktik kebidanan yang aman dan terlindungi secara hukum. Rekam medis yang baik melindungi pasien dan bidan secara bersamaan.

1. Akurasi Data : Setiap data harus dicatat dengan tepat, lengkap, dan jelas terbaca. Hindari singkatan yang ambigu yang dapat menimbulkan kesalahpahaman
2. Ketepatan Waktu : Pencatatan dilakukan segera setelah tindakan, bukan beberapa jam kemudian. Penundaan meningkatkan risiko kesalahan dan inkonsistensi data.
3. Keamanan Penyimpanan : Rekam medis disimpan dengan aman, terlindungi dari kerusakan dan akses tidak sah, minimal selama 5 tahun sesuai regulasi yang berlaku.
4. Pelaporan Rutin : Laporan bulanan dan tahunan kepada dinas kesehatan merupakan kewajiban hukum dan instrumen evaluasi mutu pelayanan yang penting.

Rekam medis yang terisi lengkap dan akurat adalah bukti terkuat bahwa bidan telah melaksanakan tugasnya sesuai standar. Dalam situasi sengketa hukum, dokumentasi yang baik adalah pembelaan yang paling efektif.

Rekam medis yang baik mencerminkan bidan yang profesional — ia menunjukkan bahwa setiap keputusan klinis didasarkan pada data yang terukur dan prosedur yang terstandarisasi

R. Penutup

Manajemen risiko bukan sekadar kewajiban administratif atau pemenuhan regulasi — ia adalah investasi nyata dalam keselamatan ibu, bayi, dan keberlangsungan karier bidan itu sendiri. Bidan yang mengelola risiko dengan baik adalah bidan yang memberikan yang terbaik bagi pasiennya.

Rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan secara bertahap oleh bidan, organisasi profesi, dan pemangku kebijakan untuk memperkuat manajemen risiko dalam praktik mandiri bidan.

Pelatihan Berkelanjutan Terstruktur Merancang program pelatihan berjenjang yang terstruktur, mencakup keterampilan klinis, manajerial, dan legal, dengan evaluasi kompetensi yang terstandarisasi.

Penguatan Budaya Pelaporan Membangun sistem pelaporan insiden yang non-punitif, konfidensial, dan disertai mekanisme umpan balik yang konstruktif dan tepat waktu.

Peningkatan Kolaborasi Memperkuat jejaring antarbidan dan antara bidan dengan fasilitas kesehatan lain melalui forum komunikasi reguler dan sistem rujukan yang terintegrasi

Selain rekomendasi yang bersifat operasional, diperlukan juga perubahan pada level sistem dan kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung

implementasi manajemen risiko yang optimal di seluruh praktik mandiri bidan Indonesia

Hasil dari Praktik Kebidanan yang Aman Senyum ibu dan sehat bayi adalah bukti nyata bahwa manajemen risiko yang baik bukan hanya tentang mencegah yang buruk — ini tentang mewujudkan yang terbaik bagi setiap keluarga Indonesia.

Setiap ibu berhak melahirkan dengan selamat. Setiap bayi berhak terlahir ke dunia yang aman. Bidan yang kompeten dan bertanggung jawab adalah kunci terwujudnya hak tersebut.

Menuju Praktik Mandiri Bidan yang Unggul dan Terpercaya Visi akhir dari seluruh upaya manajemen risiko adalah terwujudnya praktik mandiri bidan yang tidak hanya aman, tetapi benar-benar unggul — menjadi pilihan utama masyarakat dan mitra terpercaya dalam perjalanan kesehatan ibu dan anak

Komitmen Standar Tertinggi Tidak pernah berkompromi dengan keselamatan. Selalu memberikan pelayanan sesuai standar terbaik yang berlaku.

Mitra Terpercaya Masyarakat Membangun kepercayaan jangka panjang melalui konsistensi, transparansi, dan dedikasi yang tulus kepada kesehatan komunitas.

Pembelajaran Seumur Hidup Berkomitmen untuk terus belajar, berkembang, dan berinovasi demi pelayanan yang semakin baik setiap harinya.

Wujudkan praktik mandiri bidan yang aman, berkualitas, dan bebas risiko untuk setiap ibu dan bayi Indonesia. Setiap langkah kecil menuju manajemen risiko yang lebih baik adalah kontribusi nyata bagi masa depan Kesehatan bangsa.

Masa Depan Kesehatan Ibu dan Anak di Tangan Bidan yang Profesional dan Bertanggung Jawab Bidan Kompeten. Indonesia Sehat. Manajemen risiko yang baik bukan hanya tentang menghindari masalah — ia adalah tentang membangun warisan pelayanan kebidanan yang akan dikenang oleh setiap ibu dan bayi yang pernah Anda tolong. Mulailah hari ini, satu langkah pada satu waktu

Referensi

- Edozien, L. C. (2017). *Reducing risk in intrapartum care: The RADICAL framework*. International Journal of Obstetrics and Gynaecology.
- Halimatussakdiah. (2019). Analisis fungsi manajemen dalam persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 10(2), 45–53.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Nursyahri Sapriani, & Selia Juita. (2023). Asuhan kebidanan komprehensif berbasis continuity of care. *Jurnal Kebidanan dan Kesehatan Reproduksi*, 8(1), 12–25.
- Wahyuningsih, S., et al. (2024). Manajemen risiko dalam pelayanan kesehatan maternal. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(1), 1–10.
- Saleh, M., et al. (2023). Hubungan pengetahuan dan sikap bidan terhadap penerapan manajemen risiko persalinan. *Jurnal Ilmu Kebidanan*, 9(2), 78–85.
- World Health Organization. (2023). *Trends in maternal mortality 2000–2023*. Geneva: WHO.
- Dinas Kesehatan Kota Surabaya. (2023). *Profil Kesehatan Kota Surabaya Tahun 2023*. Surabaya: Dinkes.
- Yully Asmariana, & U. Evi Nasla. (2025). Peran organisasi profesi dalam peningkatan mutu praktik kebidanan. *Jurnal Kebidanan Nasional*, 11(1), 33–40.
- Marsheila Salvinia Amanitia Setiawan, et al. (2025). Analisis pengetahuan, sikap, dan implementasi manajemen risiko pada bidan praktik mandiri. *Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak*, 12(1), 21–30.
- Sefentina, Purba, S. W., & Kristina, M. L. (2022). Integrasi manajemen risiko dalam pelayanan kebidanan: Tinjauan literatur. *Jurnal Kesehatan Global*, 7(2), 90–102.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.
- Aranda, N. (n.d.). Kewirausahaan dalam praktik kebidanan mandiri

Glosarium

Adverse Event

Kejadian yang tidak diharapkan yang menyebabkan cedera atau dampak negatif pada pasien.

ANC (Antenatal Care)

Pelayanan kesehatan selama kehamilan untuk memantau kondisi ibu dan janin.

APGAR Score

Penilaian kondisi bayi baru lahir berdasarkan lima parameter (Appearance, Pulse, Grimace, Activity, Respiration).

Asfiksia Neonatorum

Kondisi bayi baru lahir yang mengalami gangguan pernapasan.

BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)

Bayi dengan berat lahir kurang dari 2500 gram.

Continuity of Care

Pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dari kehamilan hingga masa nifas.

Distosia

Kesulitan dalam proses persalinan.

Informed Consent

Persetujuan tindakan medis setelah pasien mendapat penjelasan lengkap.

Manajemen Risiko

Proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko.

Mitigasi Risiko

Upaya untuk mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko.

Neonatus

Bayi baru lahir usia 0–28 hari.

Partograf

Alat pencatatan untuk memantau kemajuan persalinan.

Patient Safety (Keselamatan Pasien)

Upaya untuk mencegah kesalahan dan cedera pada pasien.

Postpartum

Masa setelah persalinan.

Protap (Prosedur Tetap)

Standar prosedur operasional dalam pelayanan kesehatan.

Rujukan

Pemindahan pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan)

Metode dokumentasi medis dalam pelayanan kesehatan.

Tali Pusat Menumbung

Kondisi tali pusat keluar lebih dulu sebelum bayi.

TPMB (Tempat Praktik Mandiri Bidan)

Fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola secara mandiri oleh bidan.

Hipertensi Gestasional

Tekanan darah tinggi yang terjadi selama kehamilan.

BAB 6

STRATEGI PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEBIDANAN

A. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, yang diarahkan untuk mewujudkan kesehatan keluarga dalam rangka tercapainya keluarga yang berkualitas. KIA sampai saat ini menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Hal ini disebabkan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia (Elba, 2020).

Pelayanan kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu pilar penting dalam sistem kesehatan publik karena kesehatan ibu dan anak—termasuk bayi baru lahir dan balita—sangat menentukan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. Di Indonesia, meskipun telah terjadi berbagai upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, namun angka tersebut masih tergolong tinggi. Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) (2023), angka kematian ibu secara global mencapai sekitar 223 kematian per 100.000 kelahiran hidup, dengan Indonesia masih termasuk dalam negara dengan rasio kematian ibu yang tinggi di kawasan Asia Tenggara (WHO, *Trends In Maternal Mortality*, 2024).

Data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih berada pada kisaran 189 per 100.000 kelahiran hidup, sementara Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 18 per 1.000 kelahiran hidup (Indonesia, Profil Kesehatan Indonesia, 2023). Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk menurunkan mortalitas pada ibu yakni dengan mencegah intervensi yang tidak diperlukan selama proses melahirkan melalui peningkatan pelayanan kesehatan selama masa kehamilan dan menyediakan pelayanan berkualitas serta pelayanan yang mudah diakses bagi ibu hamil. maka dari itu, bidan yang berperan penting dalam menyediakan pelayanan primer dalam menurunkan angka kematian ibu memerlukan peningkatan kualitas pelayanan kebidanan.

Khosravi, S. et al, 2022 beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kebidanan yang terbagi menjadi 4 subtema, yakni mendukung dan mengembangkan pendidikan, manajemen tenaga kerja, aturan dan standar pelayanan kebidanan, serta pembentukan kebijakan. Namun, peningkatan akses belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan mutu pelayanan kebidanan. Berdasarkan konsep (Donabedian A. , 1988) mutu pelayanan kesehatan ditentukan

oleh tiga komponen utama, yaitu struktur, proses, dan outcome. Struktur mencakup sumber daya seperti tenaga bidan, sarana dan prasarana, serta kebijakan pelayanan; proses mencakup cara bidan memberikan asuhan dan komunikasi dengan pasien; sedangkan outcome mencerminkan hasil pelayanan, termasuk tingkat kepuasan pasien dan hasil kesehatan ibu dan anak. Mutu pelayanan yang rendah pada salah satu komponen ini dapat berdampak langsung terhadap rendahnya kepuasan pasien dan berdampak pada penurunan kepercayaan serta pemanfaatan layanan Kesehatan.

Dalam praktik kebidanan, mutu pelayanan dapat dilihat dari berbagai aspek seperti kompetensi tenaga bidan, ketersediaan sumber daya, penerapan Standar Asuhan Kebidanan (SAK) dan kepuasan pasien. Mutu tidak hanya diukur dari hasil akhir berupa angka mortalitas dan morbiditas tetapi juga dari proses pemberian asuhan yang berlandaskan pada prinsip *evidence-based practice* serta pendekatan yang humanistic dan berpusat pada pasien (Kemenkes, 2021).

Kesenjangan mutu pelayanan kebidanan di Indonesia masih menjadi tantangan utama. Factor penyebabnya antara lain keterbatasan sumber daya manusia, distribusi bidan yang tidak merata, infrastruktur yang belum memadai serta lemahnya system pemantauan dan evaluasi mutu di tingkat fasilitas Kesehatan primer. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan (Kemenkes, 2022), masih terdapat disparitas mutu pelayanan antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang berdampak langsung pada capaian indikator Kesehatan ibu dan anak.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan penguatan system manajemen mutu pelayanan kebidanan yang komprehensif melalui pendekatan berkelanjutan seperti *Continuous Quality Improvement* (CQI) dan penerapan *Plan-Do-Check-Act* (PDCA). Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kegiatan pelayanan kebidanan dilakukan secara sistematis, terukur, dan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, mutu pelayanan kebidanan tidak hanya menjadi tanggung jawab individu tenaga Kesehatan, tetapi merupakan hasil kerja kolektif dari semua system pelayanan Kesehatan.

Mutu pelayanan kebidanan secara keseluruhan harus dipahami sebagai bagian integral dari system Kesehatan nasional. Pelayanan yang bermutu tidak hanya menghasilkan kepuasan pasien, tapi juga menghasilkan efisiensi biaya Kesehatan dan memperkuat kepercayaan public terhadap layanan Kesehatan. Dalam konteks Pembangunan Kesehatan di Indonesia, penguatan mutu pelayanan kebidanan merupakan Langkah strategis dalam mewujudkan Indonesia Sehat 2045 dengan orientasi pada pelayanan yang berkeadilan, berkesinambungan dan berorientasi pada keselamatan ibu dan anak.

B. Promosi dan Pengembangan Pendidikan

Mendukung dan mengembangkan pendidikan bagi bidan penting dilakukan untuk meningkatkan kemampuan serta meningkatkan pengetahuan terkait pelayanan ibu. Selain itu, pendidikan dalam jabatan, serta melakukan edukasi di tingkat komunitas dapat meningkatkan skills sesuai dengan lingkup kerja dan melatih bidan untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan pelayanan antenatal. Perkembangan pelayanan kebidanan sejalan dengan kemajuan pelayanan obstetri dan ginekologi. Bidan sebagai profesi yang terus berkembang, senantiasa mempertahankan profesionalitasnya dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Profesionalitas terkait erat dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang profesional (kompetensi profesional). Bidan profesional yang dimaksud harus memiliki kompetensi klinis (*Midwifery Skills*), sosial-budaya untuk menganalisa, melakukan advokasi dan pemberdayaan dalam mencari solusi dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, keluarga dan Masyarakat. (Kepmenkes, 2020).

Kualitas Pendidikan kebidanan memiliki pengaruh yang besar terhadap ketrampilan klinis kebidanan. Bidan yang baru lulus harus sudah memiliki ketrampilan klinis dan professional minimum sehingga mereka dapat melaksanakan tugas kebidanan, meningkatkan asuhan kebidanan pada ibu dan bayi serta pada akhirnya meningkatkan Kesehatan Masyarakat (Bender, 2015). Selain itu kurikulum Pendidikan harus dievaluasi pada titik-titik tertentu dan berdasarkan standar yang dapat diterima sehingga dapat mencetak lulusan bidan yang dapat memberikan pelayanan kebidanan yang berkualitas (Allahdadyan, 2008).

1. Promosi dan pengembangan Pendidikan di perguruan tinggi yaitu Khosravi, S. et al, (2022) :
 - a. Memberikan perhatian khusus pada kualitas pendidikan mahasiswa kebidanan dan memilih pengajar/ dosen berdasarkan kriteria tertentu.
 - b. Kurikulum pendidikan mahasiswa kebidanan perlu direvisi agar mereka berkomitmen dan efisien setelah lulus.
 - c. Meningkatkan ketrampilan mahasiswa kebidanan dengan mempraktikkan ke tempat pelayanan kebidanan.
 - d. Penggunaan bidan dengan pengalaman teoritis dan klinis serta untuk pendidikan mahasiswa kebidanan.
2. Pelatihan bagi bidan

Penelitian Sapari (2020) menyatakan bahwa perlunya dilakukan pelatihan bidan yang dilaksanakan secara rutin dan bergiliran agar seluruh bidan dapat mengikuti pelatihan. Pelaksanaan pelatihan bidan di tempat kerja atau di luar

tempat kerja baik secara formal maupun informal sehingga tujuan pelatihan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan dapat terwujud sehingga kinerja bidan menjadi lebih baik. Pelatihan merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh bidan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya. Peneliti merekomendasikan bahwa setiap bidan harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan asuhan kebidanan khususnya dalam memberikan pelayanan kebidanan berkelanjutan dengan kriteria yang menunjang pelatihan berkaitan dengan keterampilan dalam memberikan pelayanan ANC, Pelatihan APN, pelayanan BBL, pelayanan pada ibu nifas dan penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal (Isitadah, Nurul, 2023). Pelatihan bagi bidan berupa Khosravi, S. et al, 2022) :

- a. Menyelenggarakan pelatihan persiapan persalinan untuk bidan di fasilitas pelayanan kebidanan, terutama yang melayani persalinan.
 - b. Pelatihan bagi staf yang baru dipekerjakan.
 - c. Pelatihan berkelanjutan dan terstruktur untuk bidan di ruang bersalin.
 - d. Pelatihan berkala bagi bidan di fasilitas pelayanan kebidanan untuk pengawasan yang tepat terhadap ibu hamil dan pendidikan Kesehatan pada masa prenatal.
3. Bidan memberikan edukasi kepada Masyarakat
- a. Promosikan persalinan alami melalui media dan pasang banner iklan.
 - b. Memberikan edukasi kepada ibu hamil di pusat-pusat kesehatan tentang persalinan alami.
 - c. Kewajiban untuk mengajarkan manfaat persalinan alami dalam kelas konseling pranikah.
 - d. Menciptakan budaya tentang persalinan alami dan komplikasi operasi caesar, terutama di televisi

C. Manajemen Sumber Daya Manusia

1. Manajemen tenaga kebidanan
 - a. Menciptakan lapangan kerja baru bagi bidan
 - b. Pekerjaan berdasarkan keterampilan, efisiensi, dan pengetahuan ilmiah
 - c. Penggunaan bidan di bidang klinis
 - d. Memberikan izin untuk memperkerjakan bidan untuk pekerjaan klinis.

Manajemen tenaga kerja yang efektif dalam pelayanan kebidanan mencakup perencanaan, pelatihan, dan supervisi untuk memastikan mutu layanan yang aman dan memuaskan pasien. Peningkatan mutu dilakukan melalui pembinaan

staf berkelanjutan, orientasi bidan baru, serta pemenuhan standar pelayanan. Bidan harus kompeten secara klinis dan mematuhi etika untuk mencapai standar pelayanan yang tinggi. Manajemen tenaga kerja yang efektif meliputi Khosravi, S. et al, 2022) :

- a. Perencanaan dan Orientasi: Program pelatihan dan orientasi terstruktur bagi tenaga baru untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja.
 - b. Pembinaan Berkesinambungan: Pengembangan staf secara rutin untuk memperbarui keterampilan klinis
 - c. Supervisi: Penyediaan supervisor yang berpengalaman untuk membimbing bidan dalam pekerjaan sehari-hari.
 - d. Pengorganisasian: Pembagian wilayah kerja dan tugas yang jelas di puskesmas atau fasilitas Kesehatan.
2. Manajemen kebidanan
- a. Pembentukan pengawas kebidanan
 - b. Kehadiran bidan di posisi manajerial
 - c. Menghadiri rapat komite kematian ibu
3. System pendukung dan insentif
- a. Pembayaran biaya persalinan normal kepada bidan di rumah sakit
 - b. Perlindungan hukum bagi bidan di sektor swasta
 - c. Reformasi sistem pembayaran
 - d. Meningkatkan tingkat kesulitan pekerjaan kebidanan hingga 100%
 - e. Menciptakan motivasi dengan menugaskan bidan penanggung jawab kepada kepala ruang persalinan

Bidan yang telah melakukan tugasnya akan mendapatkan gaji sebagai haknya dan bidan akan memiliki motivasi dan kemauan yang kuat untuk memberikan layanan kebidanan berkualitas, hal ini berkaitan dengan system dukungan dan insentif bagi bidan. Imbalan (insentif) dapat digunakan untuk memotivasi prestasi kerja. Jika imbalan yang bernilai digunakan untuk memotivasi, karyawan akan mengarahkan upaya untuk mencapai Tingkat prestasi yang tinggi (Gibson ,1996). Faktor finansial yang merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan pegawai yang meliputi gaji, jaminan sosial, macam-macam tunjangan, promosi dan sebagainya mempengaruhi kinerja (As'ad, 1995). Imbalan akan berpengaruh untuk meningkatkan motivasi kerja yang pada akhirnya secara langsung akan meningkatkan kinerja. Penelitian Emilia (2020) menyebutkan adanya hubungan antara insentif bidan dengan kinerja bidan desa dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak.

D. Peraturan, Regulasi Dan Standar Untuk Layanan

Aturan dan standar pelayanan kebidanan yang terus berkembang dan berubah juga harus disertai dengan penyediaan perlengkapan oleh rumah sakit dan pemenuhan standar kompetensi sesuai dengan standar pelayanan, serta audit juga supervisi secara berkala terkait kompetensi bidan dapat dilakukan untuk memenuhi dan meningkatkan indikator yang berkaitan dengan kebutuhan kesehatan ibu dan anak. Dalam lingkup kebijakan yang berlaku di sektor kesehatan, bidan dapat mengimplementasikan aturan-aturan yang berfokus pada promosi kesehatan lewat vaksinasi, penyuluhan infeksi menular seksual, deteksi dini penyakit, pelayanan asuhan antenatal, pemberian pelayanan kontrasepsi dan lain-lain. Kolaborasi interdisiplin juga dapat dilakukan untuk mengembangkan serta memaksimalkan layanan yang diberikan, seperti mengembangkan paket layanan bersalin oleh spesialis obstetri dan ginekologi dan bidan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) atau sistem tata kerja merupakan instrumen yang memberikan petunjuk kepada setiap anggota dan bagian kerja di dalam organisasi untuk menjalankan tugasnya secara konsisten, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, SOP berfungsi sebagai panduan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional dalam institusi tersebut. Penggunaan SOP dalam institusi bertujuan untuk memastikan bahwa institusi tersebut beroperasi secara konsisten, efektif, efisien, sistematis, dan terkelola dengan baik. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan produk atau jasa yang memiliki mutu konsisten sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya SOP, setiap langkah dalam proses operasional dapat diikuti dengan ketat, memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang terstruktur dan produktif. (Yurniati, 2024).

1. Peraturan tentang kualifikasi profesional bidan
 - a. Tinjau Kembali tugas-tugas kebidanan
 - b. Implementasi penuh bagian uraian tugas bidan dalam surat tersebut

Bidan harus memiliki kompetensi dan standar profesi bidan tertulis di Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 320 tahun 2020 untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu dan anak sepanjang siklus hidupnya. Bidan mampu melakukan pendekatan yang mutakhir dan kreatif agar tetap kompetitif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. (Oyetunde, 2014) Hasil penelitian menunjukkan bahwa bidan harus menyesuaikan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan standar internasional.

2. Audit dan pengawasan
 - a. Tersedianya sanksi berupa teguran bagi spesialis yang melakukan operasi Caesar elektif atau membuat Keputusan yang tidak ilmiah
 - b. Membangun system yang kuat untuk memantau indikasi operasi Caesar
 - c. Mengawasi pelaksanaan surat-surat terkait kebidanan dan protocol.
3. Peralatan dan fasilitas
 - a. Fasilitas persalinan perlu direhabilitasi
 - b. Melengkapi rumah sakit dengan ruang persalinan fisiologis 24 jam
 - c. Standarisasi ruang persalinan di semua rumah sakit
 - d. Modifikasi lingkungan fisik rumah sakit untuk akses cepat pasien pada saat keadaan darurat.

Kurangnya peralatan dan fasilitas yang memadai di rumah sakit dan ruang bersalin merupakan salah satu keluhan yang sering disampaikan oleh bidan pelaksana. Hasil penelitian Iran sebelumnya di bidang ini juga menunjukkan bahwa fasilitas RS dan ruang bersalin tidak terlalu memuaskan, dan semua perempuan dengan kehamilan berisiko tinggi dan rendah, menerima model asuhan kebidanan berorientasi medis, sama seperti yang ditawarkan oleh dokter kandungan sehingga klien terpapar intervensi yang tidak diperlukan dan menimbulkan kemungkinan operasi Caesar (Alidosti, 2013 dan Mesgarzade, 2012). Sanitasi dan penyediaan lingkungan yang sesuai untuk persalinan normal dapat berpengaruh pada kepuasan ibu dan berdampak pada pola persalinan (Jannati, 2010). Sebuah studi kualitatif oleh Shirzad et al (2022) menunjukkan beberapa factor-faktor penting yang dapat mempengaruhi Keputusan Perempuan tentang cara persalinan yaitu sarana prasarana di tempat pelayanan Kesehatan, perbedaan antara RS Swasta dan pemerintah dan kurangnya akses terhadap Pereda nyeri selama persalinan pervaginam (Shirzad, 2019).

E. Pembuatan Kebijakan

1. Organisasi
 - a. Menentukan posisi yang tepat bagi bidan dalam program doctor keluarga dan rujukan
 - b. Rumah sakit seharusnya tidak memiliki pemerintahan sendiri
2. Kepatuhan terhadap kebijakan umum
 - a. Menggunakan kata-kata pemimpin tertinggi Iran terkait pertumbuhan penduduk dan persalinan normal untuk mengurangi operasi Caesar.
 - b. Meningkatkan gaya hidup dan mengubah keyakinan untuk menerapkan kebijakan Kesehatan umum.

3. Kegiatan interdisipliner
 - a. Pengembangan protocol aktivitas tim untuk bidan dan dokter kandungan
 - b. Meningkatkan interaksi antara universitas swasta dan Kementerian Kesehatan.
 - c. Menyelenggarakan symposium berkala antara bidan dari universitas swasta dan negeri.

F. Standar Pelayanan Kebidanan

Standar pelayanan kebidanan ada 24 standar, meliputi :

- a. standar pelayanan umum (2 standar)
 - 1) standar 1 : Persiapan Untuk Kehidupan Keluarga Sehat
Bidan memberikan penyuluhan dan nasehat kepada Perempuan, keluarga dan masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan kehamilan, termasuk penyuluhan kesehatan umum, gizi, keluarga berencana, kesiapan dalam menghadapi kehamilan dan menjadi calon orangtua, menghindari kebiasaan yang tidak baik dan mendukung kebiasaan yang baik.
 - 2) Standar 2 : pencatatan dan pelaporan
Bidan melakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukannya yaitu registrasi. Semua ibu hamil di wilayah kerja, rincian pelayanan yang diberikan kepada setiap ibu hamil/ bersalin/ nifas dan bayi baru lahir, semua kunjungan rumah dan penyuluhan kepada Masyarakat. Di samping itu, bidan hendaknya mengikutsertakan kader untuk mencatat semua ibu hamil dan meninjau upaya Masyarakat yang berkaitan dengan ibu hamil dan bayi baru lahir. Bidan meninjau secara teratur catatan tersebut untuk menilai kinerja dan penyusunan rencana kegiatan untuk meningkatkan pelayanannya.
- b. standar antenatal (6 standar)
 - 1) Standar 3 : Identifikasi Ibu Hamil
Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan Masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu, suami dan anggota keluarganya agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini dan secara teratur.
 - 2) Standar 4 : Pemeriksaan Dan Pemantauan Antenatal
Bidan memberikan minimal 6 kali melakukan kunjungan antenatal care (ANC). Melakukan kunjungan ANC 1 kali pada trimester pertama, 2 kali pada trimester kedua, 3 kali pada trimester ketiga. Pemeriksaan meliputi : anamnesis dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan berlangsung normal. Bidan juga harus mengenali

kehamilan risiko tinggi/ kelainan, khususnya anemia, kurang gizi, hipertensi, PMS, infeksi HIV, memberikan pelayanan imunisasi, nasehat dan penyuluhan Kesehatan serta tugas terkait lainnya yang diberikan oleh puskesmas. Mereka harus mencatat data yang tepat pada setiap kunjungan. Bila ditemukan kelainan, mereka harus mampu mengambil Tindakan yang diperlukan dan merujuknya untuk Tindakan selanjutnya.

3) Standar 5 : Palpasi Dan Abdominal

Bidan melakukan pemeriksaan abdominal dan melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan serta bila kehamilan bertambah memeriksa posisi, bagian terendah janin dan masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul, untuk mencari kelainan dan melakukan rujukan tepat waktu.

4) Standar 6 : Pengelolaan Anemia Pada Kehamilan

Bidan melakukan Tindakan pencegahan, penemuan, penanganan dan rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Standar 7 : pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan

Bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenal tanda serta gejala preeklampsia lainnya serta mengambil Tindakan yang tepat dan merujuknya.

6) Standar 8 : persiapan persalinan

Bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami serta keluarganya pada trimester ketiga untuk memastikan bahwa persiapan persalinan yang bersih dan aman serta suasana yang menyenangkan akan direncanakan dengan baik, disamping persiapan transportasi dan biaya untuk merujuk, bila tiba-tiba terjadi keadaan gawat darurat. Bidan hendaknya melakukan kunjungan rumah untuk hal ini.

c. standar pertolongan persalinan (4 standar)

1) Standar 9 : Asuhan Persalinan Kala I

Bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai dengan memperhatikan kebutuhan klien selama proses persalinan berlangsung.

2) Standar 10 : Persalinan Kala II yang aman.

Bidan melakukan pertolongan persalinan yang aman dengan sikap sopan dan penghargaan plasenta dan selaput ketuban secara lengkap.

- 3) Standar 11 : Penatalaksanaan aktif persalinan kala III
 Bidan melakukan penegangan tali pusat dengan benar untuk membantu pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap.
 - 4) Standar 12 : Penanganan kala II dengan Gawat janin melalui episiotomy
 Bidan mengenal secara tepat tanda-tanda gawat janin pada kala II yang lama dan segera melakukan episiotomy dengan naman untuk memperlancar persalinan, di ikuti dengan penjahitan perineum.
- d. standar nifas (3 standar)
- 1) Standar 13 : Perawatan Bayi Baru Lahir (BBL)
 Bidan memeriksa dan menilai BBL untuk memastikan pernafasan spontan, mencegah hipoksia sekunder, menemukan kelainan dan melakukan Tindakan atau merujuk sesuai dengan kebutuhan. Bidan juga harus mencegah atau menangani hipotermi.
 - 2) Standar 14 : Penanganan pada dua jam pertama setelah persalinan
 Bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi dalam dua jam setelah persalinan, serta melakukan Tindakan yang diperlukan. Di samping itu, bidan memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mempercepat pulihnya Kesehatan ibu dan membantu ibu untuk memulai pemberian ASI.
 - 3) Standar 15 : Pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas
 Bidan memberikan pelayanan selama masa nifas melalui kunjungan rumah pada hari ketiga, minggu kedua dan minggu ke enam setelah persalinan untuk membantu proses pemulihan ibu dan bayi melalui penanganan tali pusat yang benar, penemuan dini, penanganan atau rujukan komplikasi yang mungkin terjadi pada masa nifas serta memberikan penjelasan tentang Kesehatan secara umum, kebersihan perorangan, makanan bergizi, perawatan BBL, pemberian ASI, imunisasi dan KB.
- e. Standar penanganan kegawatdaruratan obstetric neonatal (9 Standar) :
- 1) Standar 16 : penanganan perdarahan dalam kehamilan pada trimester III
 Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala perdarahan pada kehamilan, serta melakukan pertolongan pertama dan merujuknya.
 - 2) Standar 17 : penanganan kegawatan dan eclampsia
 Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala eclampsia mengancam, serta merujuk dan atau memberikan pertolongan pertama.
 - 3) Standar 18 : penanganan kegawatan pada partus lama/ macet
 Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala partus lama/ macet serta melakukan penanganan yang memadai dan tepat waktu atau merujuknya.

- 4) Standar 19 : persalinan dengan penggunaan vacuum ekstraktor
Bidan mengenali kapan diperlukan ekstraksi vakum, melakukannya dengan benar dalam memberikan pertolongan persalinan dengan memastikan keamanannya bagi ibu dan janin/bayinya.
- 5) Standar 20 : penanganan retensio Plasenta
Bidan mampu mengenali retensio plasenta dan memberikan pertolongan pertama termasuk plasenta manual dan penanganan perdarahan sesuai dengan kebutuhan.
- 6) standar 21 : Penanganan perdarahan post partum primer
Bidan mampu mengenali perdarahan yang berlebihan dalam 24 jam pertama setelah persalinan (perdarahan post partum primer) dan segera melakukan pertolongan pertama untuk mengendalikan perdarahan.
- 7) standar 22 : penanganan perdarahan post partum sekunder
Bidan mampu mengenali secara tepat dan dini tanda serta gejala perdarahan post partum sekunder dan melakukan pertolongan pertama untuk penyelamatan jiwa ibu atau merujuknya.
- 8) standar 23 : penanganan sepsis puerpuralis
Bidan mampu mengamati secara tepat tanda dan gejala sepsis puerpuralis, serta melakukan pertolongan pertama atau merujuknya.
- 9) standar 24 : penanganan asfiksia neonatorum
Bidan mampu mengenali dengan tepat bayi baru lahir dengan asfiksia, serta melakukan resusitasi, mengusahakan bantuan medis yang diperlukan dan memberikan perawatan lanjutan.
bidan mampu mengamati secara tepat tanda dan gejala sepsis puerpuralis, serta melakukan pertolongan pertama atau merujuknya.

G. Penilaian Mutu Pelayanan Kebidanan

Penilaian adalah suatu proses untuk menentukan nilai atau jumlah keberhasilan dari pelaksanaan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan pada tahap akhir (*summative evaluation*) sehingga perhatian hendaknya lebih ditujukan pada unsur keluaran (*output*) dari program menjaga mutu pelayanan kebidanan. Penilaian dapat dibedakan atas tiga jenis, yaitu :

1. Penilaian pada tahap awal program, yaitu penilaian yang dilakukan pada saat merencanakan suatu program (*formative evaluation*). Tujuan utamanya adalah untuk meyakinkan bahwa rencana yang disusun benar-benar telah sesuai dengan masalah yang ditemukan (dapat menyelesaikan masalah tersebut). Penilaian yang dimaksudkan untuk mengukur kesesuaian program dengan masalah dan/atau

kebutuhan masyarakat dan disebut dengan studi penjajakan kebutuhan (*need assessment study*).

2. Penilaian pada tahap pelaksanaan program, yaitu penilaian pada saat program sedang dilaksanakan (*promotive evaluation*). Tujuan utamanya adalah untuk mengukur apakah program yang sedang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana atau tidak, atau apakah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan pencapaian tujuan dari program tersebut. Pada umumnya ada dua bentuk penilaian pada tahap pelaksanaan program yaitu pemantauan (*monitoring*) dan penilaian berkala (*periodical evaluation*).
3. Penilaian pada tahap akhir program, yaitu penilaian yang dilakukan pada saat program telah selesai dilaksanakan (*summative evaluation*). Tujuan utamanya dibedakan atas dua macam yakni untuk mengukur keluaran (*output*) serta untuk mengukur dampak (*impact*) yang dihasilkan. Dari kedua macam penilaian akhir ini, diketahui bahwa penilaian keluaran lebih mudah daripada penilaian dampak karena pada penilaian dampak diperlukan waktu yang lama.

H. Strategi Untuk Melakukan Penilaian Mutu Pelayanan Kebidanan

1. Teknik Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data untuk menilai dengan menggunakan indra (tidak hanya dengan mata saja). Mendengarkan, mencium, mengecap meraba juga termasuk bentuk dari observasi. Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah panduan pengamatan dan lembar pengamatan.

2. Teknik wawancara

Wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dimana penilai mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang sasaran penilaian. Data diperoleh langsung dari orang yang dinilai melalui suatu pertemuan/percakapan. Wawancara sebagai pembantu utama dari metode observasi. Gejala-gejala sosial yang tidak dapat terlihat atau diperoleh melalui observasi dapat digali dari wawancara. Jenis wawancara yang sering digunakan dalam penilaian mutu adalah wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilaksanakan berdasarkan pedoman-pedoman berupa panduan penilaian yang telah disiapkan secara matang sebelumnya.

3. Teknik dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu sistem pencatatan dan pelaporan informasi tentang kondisi dan perkembangan kesehatan pasien dan semua kegiatan yang dilakukan oleh petugas Kesehatan. Dokumen terbagi dua kategori yaitu: 1)

dokumen sumber resmi, merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh lembaga atau perorangan atas nama lembaga. Ada dua bentuk yaitu sumber resmi normal dan sumber resmi informal; 2) dokumen sumber tidak resmi, merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Ada dua bentuk yaitu sumber tak resmi formal dan sumber tak resmi informal.

I. Penutup

Peningkatan pelayanan kebidanan ditekankan pada kualitas dan kuantitas pendidikan kebidanan, pelatihan individu dan pemberian informasi kepada bidan, serta peningkatan sumber daya manusia kebidanan melalui lapangan kerja. Adanya dukungan dan motivasi bagi bidan, perbaikan fasilitas serta penyediaan RS dan ruang bersalin dengan peralatan mutakhir, promosi dan penguatan posisi bidan dalam Masyarakat dan penggunaan system rujukan sesuai ketentuan sebagai strategi yang layak untuk meningkatkan pelayanan kebidanan. Adanya system pemantauan yang efisien dan kuat untuk mengontrol praktik kebidanan yang dilakukan oleh bidan, peningkatan praktik kolaboratif antara bidan dengan dokter kandungan, promosi Kerjasama tim dalam pelayanan kebidanan merupakan strategi lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan.

Referensi

- Allahdadyan M. Standar yang tepat yang direkomendasikan oleh dewan keperawatan dan kebidanan diambil dari standar internasional. Iran J Med Educ. 2008;8(1):15–22.
- Alidosti M, Tahmasebi M, Raeisi M. Mengevaluasi kepuasan wanita terhadap layanan rumah sakit Hajar setelah melahirkan. J Clin Nurs Midwife. 2013;2(1):1–8
- Donabedian, A. (1988). The quality of care: How can it be assessed?. *Journal of the American Medical Association (JAMA)*, 260(12), 1743-1748. [10.1001/jama.1988.03410120089033](https://doi.org/10.1001/jama.1988.03410120089033)
- Elba et al. (2020). Pengetahuan Remaja Putri Tentang Bahaya Perilaku Seksual Pranikah Di Desa Kalisari Dan Desa Kalijaya Kabupaten Karawang. Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan Vol.11 No.1 (2020) 51-55
- Emilia Silvana Sitompul. (2020). Analisis Kinerja Bidan Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak Di Kabupaten Tapanuli Utara. GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online). Volume 7 Nomor 1 September 2020. <https://doi.org/10.56015/governance.v7i1.34>
- Firouznia R, Dargahi H, Koshki TJ, Khaledian Z. Tantangan program kesehatan ibu di Iran dari perspektif bidan: studi kualitatif. Jundishapur J Health Sci. 2019;11(3):e92354. doi: 10.5812/jjhs.92354
- Indria Nuraini. (2015). Mutu Pelayanan Bidan Praktek Mandiri Kota Surabaya. Vol. VII, Agustus 2015. Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
- Istiadah Fatmawati, Nurul Hidayati. (2023). Analisis Faktor Kinerja Bidan Terhadap Pelayanan Kebidanan Continuty Of Care Di TPMB. Prima Wiyata Health. Volume IV Nomor 1 Tahun 2023. <https://ejournal.shj.ac.id/ojs/index.php/PWH/article/view/43/45>
- Jannati A, Maleki M, Gholizade M, Narimani M, Vakeli S. Menilai kekuatan dan kelemahan program dokter keluarga. Knowl Health. 2010;4(4):38–43
- Kemenkes RI. (2023). *Profil Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- Kemenkes RI. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter Dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, Dan Unit Transfusi Darah. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

- Kemenkes RI. (2020). Indikator Program Kesehatan Masyarakat Dalam RPJMN Dan Rentra Kementerian Kesehatan 2020-2024. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Jakarta: Kemenkes R
- Khosravi, S. et al, (2022). Evidence Based Midwifery Practice and Its Role In Improving Maternal Outcomes. *Journal of Midwifery and Reproductive Health*, 10 (2), 3214-3221.
- Laporan Akhir Kelompok Kerja Pengukuran Kualitas Program Kebidanan 2020. Tersedia di: https://www.nes.scot.nhs.uk/media/1891400/measuring_quality.pdf
- Modul Teori 2 : Mutu Layanan Kebidanan. (2019). Jurusan Kebidanan. Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya
- Mesgarzade M, Baghaei R, Ebrahimi M, Orujlu S. Survuy kepuasan ibu dari perawatan yang diberikan di unit persalinan di rumah sakit Khoy Qamar Bani Hashem pada tahun 2012. *J Urmia Nurs Kebidanan Fac*. 2014;12(10):919–925
- Oyetunde MO, Nkwonta CA. (2014). Isu kualitas dalam kebidanan: analisis kritis kebidanan di Nigeria dalam konteks standar global Konfederasi Bidan Internasional (ICM). *Int J Nurse Mid*. 2014;6(3):40–48. doi: 10.5897/IJNM2013-0119
- Permenkes No. 28 tahun 2017 tentang izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan
- Roni I, Ade RP, Suci I. (2019). Hubungan Mutu Pelayanan Kebidanan dengan Kepuasan Pasien di Ruang Rawat Inap Kebidanan. *Jurnal Kesehatan Pertiwi Politeknik Kesehatan Bhakti Pertiwi Husada Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019*.
- Strategi peningkatan mutu layanan kebidanan.
- [Shahla Khosravi](#), [Farah Babaey](#), [Parvin Abedi](#), [Zohreh Mazaheri Kalahroodi](#), [Saeideh Sadat Hajimirzaie](#). (2022). Strategies To Improve The Quality Of Midwifery Care And Developing Midwife-Centered Care In Iran: Analyzing The Attitudes Of Midwifery Experts. *BMC Kehamilan Persalinan*. 2022 16 Januari;22:40. doi: [10.1186/s12884-022-04379-7](https://doi.org/10.1186/s12884-022-04379-7) di akses https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/translate/google/articles/PMC8762813/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=sge

- Shirzad M, Shakibazadeh E, Betran AP, Bohren MA, Abedini M. Persepsi perempuan tentang faktor-faktor di tingkat fasilitas dan sistem kesehatan yang memengaruhi cara persalinan di Teheran: sebuah studi kualitatif. *Reprod Health*. 2019;16(15). 10.1186/s12978-019-0680-2
- Ten Hoope-Bender P, de Bernis L, Campbell J, Downe S, Fauveau V, Fogstad H, Renfrew MJ. Peningkatan kesehatan ibu dan bayi baru lahir melalui kebidanan. *Lancet*. 2014;384(9949):1226–1235. doi: 10.1016/S0140-6736(14)60930-2
- WHO, *Trends In Maternal Mortality*, 2024
- WHO. (2023). *Maternal Mortality Rate in Indonesia*. World Health Organization
- Yurniati et al, (2024). *Mutu Pelayanan Kebidanan*. Ureka Media Aksara. Purbalingga Jawa Tengah

Glosarium

Strategi : rencana cermat, menyeluruh, dan terintegrasi yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Mutu : tingkat baik buruk, kadar, taraf, atau derajat kualitas suatu benda, produk, maupun layanan.

Pelayanan Kebidanan : bentuk layanan profesional bagian integral dari system kesehatan yang diberikan oleh bidan—secara mandiri, kolaborasi, atau rujukan—kepada perempuan sepanjang siklus reproduksi (pra-hamil, hamil, bersalin, nifas, bayi baru lahir, balita). Pelayanan ini fokus pada promotif, preventif, serta pertolongan persalinan normal, deteksi komplikasi, dan tindakan darurat.

PROFIL PENULIS



Bd. Dewi Mayangsari, S.Si.T., M.Kes., M.Keb.

Ketua Penulis Lahir di Semarang, 23 Maret 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-IV Kebidanan pada Program Studi D-IV Kebidanan, STIKes Ngudi Waluyo Ungaran tahun 2003. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Diponegoro jurusan MKIA (Manajemen Kesehatan Ibu dan Anak) lulus tahun pada tahun 2014, melanjutkan Pendidikan Profesi Bidan lulus tahun 2022 dan S2 pada STIKes Guna Bangsa Yogyakarta jurusan Magister Kebidanan lulus tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2004 di Akademi Kebidanan Karya Husada Semarang sampai dengan sekarang yang sudah bertransformasi menjadi Universitas Karya Husada Semarang. Penulis mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas, Natural Therapy Kebidanan, Natural Advance Therapy, Promosi Kesehatan, Metodik Khusus, Panum Asuhan Kebidanan Nifas, Evidence Based Midwifery. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku di OPTIMAL, publikasi artikel, seminar, webinar serta pelatihanpelatihan yang mendukung kinerja di Kebidanan. JaFung: Lektor. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mayang230380@gmail.com
Motto: "Kejarlah Akhiratmu, Dunia Akan Mengikutimu"



Rosa Susanti, S.ST.M.Kes

Lahir di Palembang. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV di Poltekes Kemenkes III Jakarta. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Respati Indonesia (URINDO). Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2008 sebagai bidan Praktisi di RSIA, Tahun 2012 menjadi Dosen Tetap di Universitas Mohammad Husni Thamrin. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bhakti Pertiwi Indonesia mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan dan kesehatan reproduksi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail rosasusanti36@gmail.com

PROFIL PENULIS



Yeti Yuwansyah.,SST,M.Kes.,M.Keb

Lahir di Sumedang, 06 Agustus 1980. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV Bidan pendidik pada Program Studi DIV Bidan Pendidik Poltekes Kemenkes tasikmalaya tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Respati Indonesia Jakarta Prodi Kesehatan Masyarakat dan lulus tahun pada tahun 2015 kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan di Universitas Padjadjaran lulus tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2010 sebagai dosen di STIKes YPIB Majalengka tahun 2022 menjadi Universitas YPIB Majalengka. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai Pembicara, penulis buku, publikasi, seminar, Reviwer. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yetiYuwansyah@gmail.com

Motto: "Bersyukur dan Berbuat baik".



Bdn. Imelda Diana Marsilia, SST., SKM., M.Keb.

Lahir di Bandung, 3 Maret 1980. Penulis menempuh pendidikan DIII Kebidanan di RSPAD Gatot Soebroto (2001), DIV dan S2 Kebidanan di Universitas Padjadjaran (2003, 2013), S1 Kesehatan Masyarakat di STIKes Mitra Ria Husada Jakarta (2012), serta Profesi Bidan di STIKes Abdi Nusantara (2023). Saat ini sedang menempuh S3 di Universitas Diponegoro.

Karier dimulai tahun 2001 di TPMB Sri Pasar Minggu, kemudian menjadi dosen tetap di Akbid Istara Nusantara (2003), dan sejak 2004 mengajar di STIKes Mitra Ria Husada Jakarta. Mata kuliah yang diampu meliputi Asuhan Kebidanan Kehamilan, Persalinan, Neonatus hingga Anak Prasekolah, Kegawatdaruratan Maternal Neonatal, serta Kebidanan Komplementer berbasis evidensi.

Penulis aktif dalam kegiatan tridharma, organisasi, seminar, pelatihan, serta publikasi jurnal nasional terakreditasi dan penulisan buku kebidanan. Penulis dapat dihubungi melalui email : imeldadiana33@gmail.com

PROFIL PENULIS



Bd., Siti Nur Farida., SST., M.Kes,

Lahir di Bondowoso 22 Oktober 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Stikes Husada Jombang dan S2 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, IIK Strada Indonesia Kediri. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011 sampai saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang

Motto: "Patience guides the steps, gentleness adorns the soul, firmness maintains principles, and sincerity strengthens life"



Sujianti, S.ST., Bdn., M.Kes

Penulis bernama lengkap Sujianti, lahir di kota Batang pada bulan September tahun 1979. Penulis adalah dosen tetap di Program Studi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Al-irsyad Cilacap. Penulis memiliki latar belakang Pendidikan D3 Kebidanan di STIKes 'Aisyiyah Yogyakarta lulus tahun 2004, D-IV Kebidanan di Universitas Padjadjaran Bandung lulus tahun 2006, S-2 Magister Kesehatan di Universitas Sebeas Maret Surakarta lulus tahun 2014.

Penulis Mengampu Mata Kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah, serta Kesehatan Reproduksi. Penulis sudah mendapatkan sertifikasi sebagai dosen serta terdaftar dan aktif dalam keanggotaan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Moto : "Bersyukur adalah cara tercepat untuk mengubah kekurangan menjadi kecukupan."

Sinopsis

Buku referensi *Keselamatan Ibu dan Bayi dalam Praktik Kebidanan* disusun sebagai rujukan bagi mahasiswa, pendidik, dan praktisi kebidanan untuk menerapkan prinsip keselamatan pasien secara konsisten dalam pelayanan maternal dan neonatal. Keselamatan ibu dan bayi menjadi prioritas utama karena periode kehamilan, persalinan, nifas, dan masa neonatal merupakan fase yang rentan terhadap komplikasi. Buku ini menekankan pentingnya praktik berbasis bukti, budaya keselamatan, serta manajemen risiko untuk mencegah kejadian tidak diharapkan dan meningkatkan mutu layanan.

Pembahasan diawali dengan konsep *patient safety* dalam kebidanan yang meliputi komunikasi efektif, kerja tim, kepatuhan pada standar prosedur, dan penguatan budaya keselamatan. Selanjutnya diuraikan identifikasi faktor risiko maternal dan neonatal sebagai dasar deteksi dini, pemantauan, serta pengambilan keputusan klinis yang tepat waktu. Buku ini juga memuat manajemen kegawatdaruratan obstetri dan neonatal, termasuk prinsip stabilisasi awal, tindakan segera, dan koordinasi rujukan untuk kondisi kritis.

Aspek pencegahan infeksi dibahas sebagai komponen penting keselamatan, mencakup penerapan asepsis–antisepsis, penggunaan APD, serta pengendalian infeksi di fasilitas layanan maupun praktik mandiri. Untuk menjaga akuntabilitas, buku ini menekankan dokumentasi dan pelaporan insiden secara akurat sebagai bagian dari evaluasi dan perbaikan sistem. Selain itu, dijelaskan manajemen risiko dalam praktik mandiri bidan agar pelayanan tetap aman, sesuai standar, dan selaras dengan regulasi. Pada bagian akhir, buku ini menguraikan strategi peningkatan mutu pelayanan kebidanan melalui audit, supervisi, pendidikan berkelanjutan, dan pemantauan indikator mutu.

Secara keseluruhan, buku ini memberikan kerangka praktis dan sistematis untuk memperkuat keselamatan ibu dan bayi serta mendukung layanan kebidanan yang profesional, aman, dan bermutu.

Buku referensi Keselamatan Ibu dan Bayi dalam Praktik Kebidanan disusun sebagai rujukan bagi mahasiswa, pendidik, dan praktisi kebidanan untuk menerapkan prinsip keselamatan pasien secara konsisten dalam pelayanan maternal dan neonatal. Keselamatan ibu dan bayi menjadi prioritas utama karena periode kehamilan, persalinan, nifas, dan masa neonatal merupakan fase yang rentan terhadap komplikasi. Buku ini menekankan pentingnya praktik berbasis bukti, budaya keselamatan, serta manajemen risiko untuk mencegah kejadian tidak diharapkan dan meningkatkan mutu layanan.

Pembahasan diawali dengan konsep patient safety dalam kebidanan yang meliputi komunikasi efektif, kerja tim, kepatuhan pada standar prosedur, dan penguatan budaya keselamatan. Selanjutnya diuraikan identifikasi faktor risiko maternal dan neonatal sebagai dasar deteksi dini, pemantauan, serta pengambilan keputusan klinis yang tepat waktu. Buku ini juga memuat manajemen kegawatdaruratan obstetri dan neonatal, termasuk prinsip stabilisasi awal, tindakan segera, dan koordinasi rujukan untuk kondisi kritis.

Aspek pencegahan infeksi dibahas sebagai komponen penting keselamatan, mencakup penerapan asepsis–antisepsis, penggunaan APD, serta pengendalian infeksi di fasilitas layanan maupun praktik mandiri. Untuk menjaga akuntabilitas, buku ini menekankan dokumentasi dan pelaporan insiden secara akurat sebagai bagian dari evaluasi dan perbaikan sistem. Selain itu, dijelaskan manajemen risiko dalam praktik mandiri bidan agar pelayanan tetap aman, sesuai standar, dan selaras dengan regulasi. Pada bagian akhir, buku ini menguraikan strategi peningkatan mutu pelayanan kebidanan melalui audit, supervisi, pendidikan berkelanjutan, dan pemantauan indikator mutu.

Secara keseluruhan, buku ini memberikan kerangka praktis dan sistematis untuk memperkuat keselamatan ibu dan bayi serta mendukung layanan kebidanan yang profesional, aman, dan bermutu.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7556-91-2 (PDF)



9

786347

556912

